MINISTERIO DE SALUD

No. 883-2014/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

A. Velásquez

Lima, 18 de NOVIEMBRE del 2014

Visto el expediente N° 13-091585-001, que contiene el Informe N° 058-2014-SL-DPCS de la Dirección General de Promoción de la Salud;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

D. CESPEDES M.

Que, el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece las funciones rectoras del Ministerio de Salud y señala entre otras, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud y dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, la gestión de los recursos del sector; así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su competencia;

M. YAGUI M.

Que, el artículo 60° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA y sus modificatorias, estipula que la Dirección General de Promoción de la Salud es el órgano técnico normativo, responsable de la conducción del proceso de Promoción de la Salud, así como de contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad cuyas acciones inciden en los determinantes sociales que influyen en la salud de la población;

H. Rebaza I.

P. GIUSTI

Que, con el documento del visto, la Dirección General de Promoción de la Salud, ha propuesto el Documento Técnico: "Acciones de Promoción de la Salud para la Prevención del Dengue a través del Abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud", que tiene como objetivo, promover en la población en riesgo, la adopción de prácticas individuales, familiares y comunitarias, orientadas a la eliminación o tratamiento de potenciales criaderos, que disminuyan la probabilidad de un incremento de zancudos *Aedes aegypti*, así como impulsar la articulación intergubernamental e intersectorial para el abordaje de los determinantes sociales asociados al dengue y fortalecer la organización comunitaria y la responsabilidad ciudadana para la promoción de la salud y la prevención del dengue;

J. Zavala S.

M.L. Pérez G.

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Promoción de la Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Promoción de la Salud, del Director General de la Dirección General de Epidemiología, del Director General de la Dirección General de Salud de las Personas, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y de la Viceministra (e) de Salud Pública y;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el **Documento Técnico: "Acciones de Promoción de la Salud para la Prevención del Dengue a través del Abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud"**, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Promoción de la Salud la difusión y supervisión de lo dispuesto en el citado Documento Técnico.

Artículo 3°.- Disponer que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, así como las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional son responsables en lo que corresponde de la implementación del mencionado Documento Técnico en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4°.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANIBAL VELASQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

D. CESPEDES M.

M. YAGUI M.

H. Rebaza I.

P. GIUSTI

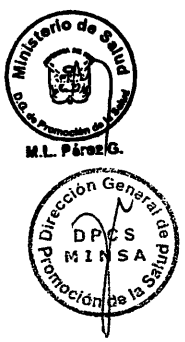
J. Zavala S.

M.L. Pérez G.

PERÚ | Ministerio de Salud

DOCUMENTO TÉCNICO:

"ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE A TRAVES DEL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD"



DOCUMENTO TÉCNICO:
"ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE A TRAVES DEL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD"

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.

II. FINALIDAD

III. OBJETIVOS

IV. BASE LEGAL

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN

VI. CONTENIDO

6.1 Consideraciones Generales:

6.1.1 Definiciones Operativas

6.1.2 Aspectos Conceptuales

6.2 Consideraciones Especificas:

6.2.1 Del Modelo de Abordaje de Determinantes Sociales de la Salud para la Prevención de Dengue

6.2.2 Líneas de Acción para las Intervenciones del Modelo

a) Acciones a corto plazo: Determinantes intermedios

a.1. Acción sobre *hábitos y estilos de vida* (determinante intermedio)

a.2. Mejoramiento de la *capacidad de respuesta del Sistema de Salud*: (determinante intermedia)

b) Acciones a mediano y largo plazo: Determinantes estructurales

b.1. Modificación de *comportamientos y estilos de vida*, (determinante estructural)

b.2. Acceso a *servicios de agua potable y desagüe*, (determinante estructural)

b.3. Funcionamiento de *sistemas efectivos y seguros de recojo de desperdicios y disposición de residuos sólidos* (determinante estructural)

6.2.3 Proyectos de Inversión

6.2.4 Del Equipo de Trabajo: Conformación y Organización

a) De la conformación del Equipo de Trabajo Dengue

b) De la organización del Equipo de Trabajo Dengue

6.2.5 Determinación de la Línea de Base:

a) Encuesta CAP

b) Medición de Índice Aédico

c) Medición de Índice Breteau

d) Reporte del Número de Casos de dengue

6.2.6 Implementación de las acciones de corto plazo

a) Acción sobre *hábitos y estilos de vida*

a.1. Comunicación Social en Salud

a.2. Vigilancia comunitaria

a.3. Campaña masiva de eliminación de criaderos

a.4. Recojo y procesamiento de residuos sólidos

a.5. Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos

Ministerio de Salud — Dirección General de Promoción de la Salud — M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud — DPCS MINSA

b) Cronograma de actividades

c) Monitoreo y Evaluación

c.1. Del Monitoreo

c.2. De la Evaluación o Línea de Control

6.2.7 Declaración de Brote Epidémico

a) Acciones en brote epidémico

b) Casas deshabitadas, cerradas y renuentes

VII. RESPONSABILIDADES

VIII. ANEXOS

IX. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Promoción de la Salud – Ministerio de Salud, busca promover municipios y comunidades saludables reduciendo los riesgos de enfermar por dengue, que durante los últimos años ha causado grandes pérdidas de vidas y económicas, en el país.

El dengue, siendo una enfermedad viral transmitida por la picadura del vector infectado (Zancudo *Aedes aegypti*), que abunda en las zonas calurosas y que actualmente es mortal, debido al genotipo DENV-2 americano/asiático, que causa los casos más graves; circula en nuestro país a predominio de las Regiones: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y San Martin. Cabe resaltar, que las otras regiones cercanas y fronterizas se encuentran en riesgo de tener este serotipo debido a la gran migración de las personas que contribuyen a la dispersión del zancudo; además de su adaptación a los cambios asociadas a ciertos factores determinantes.

Los determinantes sociales que condicionan la aparición y persistencia del dengue están relacionadas a: condiciones climáticas, crecimiento desordenado de la población, insuficiente abastecimiento de agua intradomiciliario, inadecuadas prácticas de almacenamiento de agua por parte de la población, inadecuado manejo de residuos sólidos y una escasa participación de las autoridades locales y de la comunidad.

Estos determinantes en su mayoría, están directamente vinculadas a funciones de salubridad y saneamiento encargadas a los municipios conforme lo dispone el artículo 80 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades compartidas con los Gobiernos Regionales; además de los determinantes asociadas a las competencias de otros sectores del estado.

Por estas características, el abordaje de la prevención y control del dengue tiene un enfoque multisectorial e intergubernamental.

Existen evidencias de que el trabajo articulado entre los diferentes sectores como educación, salud, vivienda, medio ambiente, agricultura entre otros, conjuntamente con los diferentes niveles de gobierno y otros actores sociales, aseguran una intervención efectiva, eficiente y eficaz que contribuye a la disminución de probabilidades de enfermar y morir por dengue.

Es por ello, que el documento técnico:***"Acciones de promoción de la salud para la prevención del dengue a través del abordaje en los determinantes sociales"*** tiene un enfoque de participación de los diferentes actores sociales, siendo uno de los principales, el gobierno local, por su posición como gestor territorial. Asimismo enfatiza, actividades costo-efectivas relacionadas a cortar la cadena reproductiva del vector, eliminando sostenidamente los potenciales criaderos del zancudo, beneficiando el cuidado del medio ambiente.

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

I. FINALIDAD

Contribuir a la disminución de la morbi - mortalidad por dengue.

II. OBJETIVOS

3.1. Promover en la población en riesgo, la adopción de prácticas individuales, familiares y comunitarias; orientadas a la eliminación o tratamiento de potenciales criaderos, que disminuyan la probabilidad de un incremento de zancudos *Aedes aegypti.*

3.2. Impulsar la articulación intergubernamental e intersectorial para el abordaje de los determinantes sociales asociados al dengue.

3.3. Fortalecer la organización comunitaria y la responsabilidad ciudadana para la promoción de la salud y la prevención del dengue.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 007-2013-SA, que aprueba el Plan Nacional Multisectorial e Intergubernamental de Prevención y Control de Dengue en el Perú.
- Resolución Ministerial N° 517-2004/MINSA, que aprueba la Directiva N° 036-2004-OGDN/MINSA-V.01, Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres.
- Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA, Lineamientos de Política de Promoción de la Salud.
- Resolución Ministerial N° 277-2005/MINSA, que aprueba el Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas.
- Resolución Ministerial N° 457-2005/MINSA, que aprueba el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.
- Resolución Ministerial N° 402-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Programa de Familias y Viviendas Saludables.
- Resolución Ministerial N° 720-2006/MINSA, que aprueba el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud.
- Resolución Ministerial N° 658-2010-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 037-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Notificación de casos en la Vigilancia Epidemiológica del Dengue".
- Resolución Ministerial N° 797-2010/MINSA, que aprueba la NTS N° 085-MINSA/DIGESA-V.01. Norma Técnica de Salud para la implementación de la vigilancia y control del *Aedes aegypti*, vector del dengue en el territorio nacional.

- Resolución Ministerial N° 298-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica de Gestión de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible.
- Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad.
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba las Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01. Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de manos social como práctica saludable en el Perú.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento Técnico es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos: Establecimientos de salud a cargo del Instituto de Gestión de Servicios de Salud-IGSS, del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales (Direcciones Regionales de Salud - DIRESA), Gerencia Regionales de Salud - GERESA) o las que cumplan su función), Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud - EsSalud, de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También servirá como referencia para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atención de salud en todo el país.

V. CONTENIDO

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

a) PROMOCION DE LA SALUD

Promoción de la Salud, como función esencial de la salud pública, es un ámbito específico de desarrollo de acciones y competencias de los sistemas de salud, para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es mejorar la salud de la población.

La Promoción de la Salud entre sus áreas de acción busca fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos para tener mayor control sobre su salud y mejorarla, logrando un estado de bienestar físico, mental y social. Esto se hace como parte de la Atención Integral de la Salud, junto a las otras 3 intervenciones sanitarias (prevención de las enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud), en el establecimiento de salud y en la comunidad.

También la Promoción de la Salud busca modificar sustancialmente las condiciones sociales, ambientales y económicas en las que viven las personas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual, mediante el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud[1].

Cabe resaltar que las acciones de Promoción de la Salud se implementan a través de procesos políticos y sociales, que involucran necesariamente al Estado y la sociedad, y requieren de la coordinación y sinergia inter/trans sectorial, e intergubernamental, así como del empoderamiento y participación social como elementos esenciales de su sostenibilidad.

[1] Organización Mundial de la Salud.1998. Promoción de la salud. Glosario de términos.

b) DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD (DSS)

Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y que tienen impacto positivo o negativo en la situación de salud de la población. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.[2]

c) PRÁCTICAS SALUDABLES

Son acciones relacionadas a la adopción, modificación o fortalecimiento de hábitos y comportamientos de las familias, que parten de la identificación de las necesidades para cuidar o mejorar su salud, siendo necesario contar con condiciones o entornos que favorezcan el desarrollo de las prácticas saludables que garanticen estilos de vida saludables en las familias. [3]

d) ENTORNO SALUDABLE

Es un concepto integral que reconoce el hogar, la escuela y la comunidad como espacios clave donde transcurre parte importante de la infancia y la adolescencia y donde se adquieren conocimientos y valores decisivos para la vida.

El entorno o condiciones comprende dos dimensiones que se superponen y están interrelacionados; el "entorno inmediato", compuesto por los progenitores, familiares, amigos y miembros de la comunidad, en que la comunicación es el factor que más influye sobre el comportamiento; mientras que el "entorno más amplio", está referido a políticas públicas y legislación, ofertas de servicios, sistemas educativos, factores culturales, religión, factores sociopolíticos, socioeconómicos y el entorno físico, en los que las personas desarrollan su vida diaria, estableciéndose condiciones, no solo para proteger su salud, sino para potenciar al máximo e incrementar el nivel de calidad de vida.[4]

e) ACTORES SOCIALES

Son todas las personas o colectivo de personas que desempeñan roles de liderazgo, que al interactuar con los determinantes sociales pueden contribuir a mejorar o a empeorar la salud de su comunidad. Un actor social puede ser individual o representante de instituciones, organizaciones, partidos políticos y otros que propugne trabajar con liderazgo, concertación, compromiso y en un espacio territorial.[5]

f) MENSAJES CLAVES

Es un enunciado que expone aquello que se comunicará, ya sea una idea, un concepto, un hecho o una indicación. Este enunciado debe suscitar el interés del público objetivo y facilitar su interpretación, influenciándolos para que aprendan, crean, cambien su comportamiento y adopten la conducta deseada.[6]

g) VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD

Mecanismo de participación comunitaria basada en identificar todas las actividades que deben hacer los integrantes de una comunidad desde el núcleo familiar y su entorno, con un enfoque de autorresponsabilidad y fortalecimiento de las acciones preventiva promocionales que contribuyan a la preservación de su salud.

---

[2] Organización Mundial de la Salud.2008. Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.

[3] Dirección General de Promoción de la Salud.MINSA.2011.DT: Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el Cuidado Infantil, aprobado con RM N° 528-2011/MINSA.

[4] Idem.

[5] Idem.

[6] Por Octavio Rojas. En Razón y Palabra. N° 34, año 8, agosto - septiembre 2003, México. Mensajes Claves y Preguntas y Respuestas. Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al Comunicar.

El desarrollo de esta vigilancia promueve principalmente las acciones auto gestionarias desde la familia, el entorno y de la comunidad organizada articulándose con los niveles gubernamentales e institucionales para una mejor respuesta a su problemática sanitaria. [7]

h) *AEDES AEGYPTI*

Mosquito vector del dengue.[8]

i) INSECTO VECTOR

Insecto que tiene la posibilidad de ser infectado por un patógeno, permitir su propagación en su propio organismo y transmitirlo en forma viable a otro organismo que desarrollará la enfermedad.[9]

j) ÍNDICE AÉDICO

Indicador que mide el porcentaje de casas positivas con larvas y pupas de *Aedes aegypti* en el total de las casas inspeccionadas de una localidad. [10]

k) ÍNDICE BRETEAU

Indicador que mide el porcentaje de recipientes positivos con larvas y pupas de *Aedes aegypti* en una localidad.[11]

l) CRIADEROS DE ZANCUDO

Lugar propicio para el desarrollo del zancudo.

m) CAMPAÑA DE RECOJO Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS (INSERVIBLES)

Acción de limpieza liderada por las autoridades locales con participación activa de la población, donde recogen y eliminan de sus casas todo objeto en desuso donde se puede desarrollar y proliferar el zancudo.

n) VIVIENDA CERRADA

Vivienda que se encuentra cerrada al momento de la inspección de vivienda o en la que no hay presencia de un adulto al momento de la inspección.[12]

ñ) VIVIENDA DESHABITADA

Vivienda que se encuentra sin ocupante por lo menos un mes.[13]

o) VIVIENDA RENUENTE

Vivienda que se encuentra con la presencia de un adulto al momento de la inspección pero que no autoriza el ingreso a la vivienda.[14]

M.L. Pérez G.

DPCS MINSA

6.1.2. ASPECTOS CONCEPTUALES

a) La promoción de la salud se orienta a desarrollar políticas y acciones estratégicas dirigidas a mejorar la salud de la población, a través de procesos políticos y sociales, que involucran necesariamente al Estado y la Sociedad, y requieren de la coordinación y sinergia inter / trans sectorial, e intergubernamental, así como del empoderamiento ciudadano y participación social como elementos esenciales de su sostenibilidad.

---

[7] Dirección General de Promoción de la Salud.MINSA.2011.DT: Lineamientos de Política para la Vigilancia Ciudadana en Salud, aprobado con RM N° 040-2011/MINSA.

[8] Dirección General de Salud Ambiental.MINSA.2011. Norma Técnica de Salud para la implementación de la Vigilancia y Control del *Aedes aegypti*, Vector del Dengue en el Territorio Nacional, aprobado con RM N° 797-2010/MINSA.

[9] Idem

[10] Idem

[11] Idem

[12] Idem

[13] Idem

[14] Idem

b) Las acciones de promoción de la salud buscan no solo a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.

c) Las intervenciones de promoción de la salud en el país, se orientan a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la articulación intersectorial, intergubernamental, la participación comunitaria y la reorientación de los servicios de salud; con el propósito de lograr que las personas y las familias adopten prácticas saludables, que las protejan frente al dengue y que las autoridades gestionen entornos que promuevan condiciones favorables para el cuidado de la salud, que disminuyan el riesgo de brotes.

d) Las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs), las Gerencias Regionales de Salud (GERESAs) y las Direcciones de Salud (DISAs) o las que cumplan su función, deben impulsar la participación activa de la población, así como la articulación entre los gobiernos regionales y locales, otros sectores del Estado y privados; a fin de promover la adopción de prácticas y gestión de entornos saludables como medidas preventivas frente al dengue.

e) El IGSS/las DISAs/ DIRESAs/ GERESAs, deberán realizar la asistencia técnica, monitoreo y supervisión a las redes y microrredes para impulsar las actividades de promoción de la salud en los diferentes escenarios de intervención (Municipios, Comunidades, Instituciones Educativas y Familias), prevención y control del dengue en su jurisdicción sanitaria, en el marco de lo dispuesto en el presente Documento Técnico.

M.L. Pérez G.

f) Las DIRESAs, GERESAs, DISAs o las que hagan sus veces, redes y microrredes deben organizar y capacitar a los equipos de salud para que desarrollen acciones educativas, de comunicación social y de vigilancia comunitaria en su jurisdicción para la promoción de prácticas saludables y el mejoramiento de sus entornos para contribuir a la prevención y control del dengue.

DPCS MINSA

g) Las DIRESAs, GERESAs, DISAs o la que hagan sus veces, redes y microrredes, deben promover la incorporación en la agenda de las mesas multisectoriales de salud o sus equivalentes, el tema de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y control del dengue; así como realizar acciones de incidencia y/o abogacía para que los sectores asuman actividades y objetivos en el campo de su competencia, que contribuya a la prevención y control del dengue.

6.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

6.2.1 DEL MODELO DE ABORDAJE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE

a) El modelo de intervención planteado desde la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, para la prevención del dengue a través del abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud se centra en la identificación de aquellos factores que están relacionados con "las causas de las causas" de las inequidades en salud en general, y del dengue en especial.

Así, es importante señalar que el modelo identifica aquellas intervenciones que se consideran necesarias para vulnerar y modificar la situación de afectación a las poblaciones con riesgo o presencia de dengue. Las intervenciones están orientadas a actuar sobre los determinantes intermedios y los determinantes estructurales, siendo que estas últimas no dependen exclusivamente del Ministerio de Salud o de los establecimientos de salud para su ejecución, sino

que responden a una necesaria e imprescindible acción intersectorial, transectorial e intergubernamental, liderados por la Autoridad Nacional de Salud, en tanto es la responsable de ejercer la rectoría del Sector Salud.

b) Se considera como pilares claves para el marco de la intervención sobre los determinantes sociales, la acción intersectorial y el empoderamiento y participación social, sin las cuales no podría tener resultados efectivos para mejorar la salud de la población.

La *acción intersectorial* tiene como fin disminuir las inequidades en salud mediante la ejecución de políticas públicas que permitan mitigar el efecto de la estratificación social (diferencias entre los individuos), reducir la exposición (factores de riesgo) y la vulnerabilidad de las personas (grupo de personas con algo en común p.e. gestantes, madres de niños menores de 5 años, grupo ocupacional, entre otros); mientras el *empoderamiento* y la participación social busca promover el involucramiento activo de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos para el desarrollo y empoderamiento ciudadano (Grupos de apoyo de la comunidad, Comités de Vigilancia Comunitaria, Comunidad Educativa, Agentes Comunitarios, entre otros) para la implementación de las políticas públicas y hacerlas sostenible.

c) El abordaje de los determinantes sociales de la salud para la prevención del dengue implica desarrollar mínimamente acciones de corto, mediano y largo plazo:

Acciones de corto plazo: orientadas a incidir en los determinantes intermedios

- Acción sobre *hábitos y estilos de vida.*
- Mejoramiento de la *capacidad de respuesta del Sistema de Salud*, para la prevención, diagnóstico y tratamiento del dengue.

Acciones a mediano y largo plazo orientadas a incidir en los Determinantes estructurales

- Modificación de *comportamientos y estilos de vida*, desde la labor del Sector Educación (determinante estructural).
- Acceso a *servicios de agua potable y desagüe*, como parte de las condiciones de vivienda, desde la intervención de gobiernos regionales, gobiernos locales, y Sector Vivienda (determinante estructural).
- Funcionamiento de *sistemas efectivos y seguros de recojo de desperdicios y disposición de residuos sólidos*, desde la intervención de los gobiernos locales (determinante estructural).

Existen otros determinantes estructurales ligados a la presencia del dengue, como son la pobreza, la ocupación /desocupación, los niveles de ingreso, la posición social, que de manera general pero trascendente condicionan que sean los sectores de la población menos favorecidos los que estén en más riesgo y más afectados por esta patología, pero cuyo abordaje depende de las políticas socio económicas que desarrolle el Estado, y que por su naturaleza general, no son específicas ni exclusivas para la prevención del dengue, pero sí son indispensables.

d) Las acciones de Promoción de la Salud, en tanto una función esencial de la Salud Pública, en el contexto del abordaje de la DSS en general, y de la prevención del dengue en particular, se deben entender en dos dimensiones:

d.1. La labor desde el establecimiento de salud, donde se brinda atención integral de salud que incluye a la Promoción de la Salud, y que se puede

Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

desarrollar en cada atención individual o en atenciones colectivas (sesiones educativas, sesiones demostrativas, actividades educativo comunicacionales, acciones de difusión, etc.), e incluso con intervenciones dirigidas a sensibilizar y comprometer a las autoridades locales. Están orientadas a impulsar hábitos y estilos de vida saludables, realizar comunicación social en salud, impulsar la vigilancia comunitaria, promover campañas masivas de eliminación de criaderos de zancudos, o de recojo y procesamiento de residuos sólidos (que pueden servir de criaderos) en instituciones educativas y centros laborales, entre otras.

d.2. La labor desde la Autoridad de Salud, de nivel nacional y de nivel regional, e incluso desde las redes, orientada a plantear las acciones de coordinación y de abogacía para proponer, impulsar y desarrollar el trabajo intersectorial, transectorial e intergubernamental, que incluye a Educación, Vivienda, Trabajo, Ambiente, Agricultura, entre otros, para poner en la agenda política y en las acciones de los sectores correspondientes aquellas intervenciones que tendrán impacto definitivo en el esfuerzo de prevenir y controlar el dengue.

e) El trabajo, para abordar los determinantes sociales de la salud en la prevención del dengue, demanda además de los sectores mencionados y de los diferentes niveles de gobierno, la participación de otros actores sociales (sector privado, sociedad civil, organizaciones de base, etc.), para asegurar intervenciones efectivas, eficientes y eficaces que contribuyan a la disminución de probabilidades de enfermar y morir por dengue.



f) Las intervenciones identificadas por la instancia de Promoción de la Salud del nivel nacional y regional, respecto a la prevención del dengue a través del abordaje de las DSS, están relacionadas a las competencias y responsabilidades del gobierno a nivel nacional, regional, local, y de los sectores sociales, que tienen funciones vinculadas a la salubridad y saneamiento, de acuerdo a la normatividad vigente y sus leyes orgánicas respectivas.



g) En ese contexto se podrán planificar intervenciones en el corto plazo, como la eliminación o tratamiento sistemático de los criaderos del zancudo (campañas de recojo y eliminación, etc.) y otras intervenciones de largo plazo (proyectos de inversión en abastecimiento de agua, canales de drenaje fluvial, entre otros) que por lo general dependen de otros sectores y actores sociales, y no del establecimiento de salud.

6.2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LAS INTERVENCIONES DEL MODELO

El modelo de abordaje de las DSS para la prevención del dengue identifica la necesidad de actuar en los determinantes intermedios, pero fundamentalmente en los determinantes estructurales. En tal sentido, plantea líneas de acción para el corto plazo que inciden en los determinantes intermedios, y líneas de acción para el mediano y largo plazo que inciden en los determinantes estructurales.

a) Acciones a corto plazo: Determinantes intermedios

Son acciones orientadas a intervenir en los determinantes intermedios ligados a la presencia de dengue en la población; y que se deben hacer desde el Sistema de Salud, y por tanto su operatividad es factible de cumplirse en el corto plazo; sin embargo, es importante tener claro que sus efectos son de corto alcance y por tanto de impacto limitado. La realidad nos muestra que los esfuerzos del personal del establecimiento para pretender cambios en los estilos de vida y hábitos que favorecen el riesgo de dengue, pueden tener eco pero sólo se mantendrán en tanto se siga insistiendo en realizar dichos cambios, y si se deja de trabajar en ello, lo más probable es que la población vuelva a realizar sus hábitos y costumbres de riesgo.

Por eso es importante tener un trabajo sostenido con la población mediante una comunicación interpersonal, participativa y en masa, donde se les informe, se promueva su participación y eduque sobre las prácticas saludables para el tratamiento y eliminación sistemática de criaderos de zancudo, a través de las acciones a corto plazo.

Estas acciones deben hacerse necesariamente, y en ello radica su importancia, en que no se pueden dejar de hacer porque las consecuencias serían severas para la situación de salud de la población afectada.

a.1. Acción sobre *hábitos y estilos de vida*

El personal de salud debe ser capacitado y provisto de los recursos necesarios para poder proporcionar al individuo, familias y la comunidad en la que trabajan la información y educación sanitaria relacionados a los comportamientos y estilos de vida saludables que protegen o disminuyen el riesgo de ser afectados por el dengue.

Estas acciones son desarrolladas por el personal de salud en el establecimiento de salud como parte de la atención integral que se brinda, individualmente, a las poblaciones de zonas endémicas o en riesgo. El personal de salud que ha sido debidamente capacitado, puede aprovechar inclusive las oportunidades de interactuar en los momentos de espera, o en la atención en laboratorio, farmacia, entre otros.

Sin embargo, por la naturaleza del dengue, las acciones en la que se deben enfatizar más son las orientadas a modificar hábitos y estilos de vida de riesgo, en acciones colectivas, tanto intra o extramurales, en las cuales, el personal del establecimiento debe informar y educar a la población en las practicas saludables relacionadas al mantenimiento y limpieza de los recipientes donde almacenan agua, a la higiene y ordenamiento de las viviendas, las prácticas de protección personal y de eliminación de residuos sólidos y de los potenciales criaderos del zancudo; además de involucrarlos en la vigilancia comunitaria.

El personal de salud del establecimiento debe hacer actividades de abogacía con las autoridades locales y comunales para desarrollar actividades relativas a:

- Comunicación Social en Salud.
- Vigilancia Comunitaria.
- Campaña masiva de eliminación de criaderos.
- Recojo y procesamiento de residuos sólidos.
- Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos.

Estas actividades se pueden realizar en la atención cotidiana en el establecimiento de salud, en la comunidad, en las instituciones educativas, en los centros laborales, y en todo espacio donde se puede llevar el mensaje que busca cambiar los hábitos y estilos de vida.

Así, las actividades de Promoción de la Salud están orientadas a llevar información y conocimiento de prácticas saludables para disminuir el riesgo de enfermar por dengue. Pero en general, estas acciones –de ser eficientes– van a permitir que se pueda desarrollar la *prevención primaria*[15] ante la amenaza o riesgo de dengue.

[15] Prevención primaria: Acciones que se desarrollan para evitar el riesgo de enfermar.

a.2. Mejoramiento de la *capacidad de respuesta del Sistema de Salud:*

El Sistema de Salud es un determinante intermediario y por tanto influye en la situación de salud de la población, y por ello es importante tenerlo en cuenta desde la perspectiva de abordaje de DSS para la prevención del dengue.

Los establecimientos de salud deben ser dotados de la capacidad y recursos para que puedan realizar un adecuado desempeño ante el riesgo de dengue. Así como es importante que pueda hacer las acciones de promoción de la salud, es imprescindible que desarrolle las correspondientes a prevención de la enfermedad, y principalmente las de atención de los casos de dengue que llegan a los servicios ambulatorios o de emergencia, de manera que se pueda identificar oportunamente a los casos sospechosos, realizar las evaluaciones clínicas y de apoyo al diagnóstico correspondiente, y brindar el tratamiento que requiera cada caso, incluida las complicaciones, hasta su recuperación.

Un sistema que no está atento a los casos o que los devuelve a sus hogares sin adecuado diagnóstico, no solo pone en riesgo la vida de cada paciente, sino que contribuye involuntariamente a que se propague la enfermedad al exponer a la contaminación de más vectores. Un sistema de salud que está preparado para afrontar eficazmente el riesgo de dengue contribuye a cumplir con la *prevención secundaria y terciaria*[16], de manera que se puede controlar rápidamente un brote.

En tal sentido se requiere que los recursos humanos de los establecimientos de salud estén capacitados y alerta a reconocer temprana y oportunamente los signos y síntomas relacionados a casos posibles de dengue, y brindarles atención inmediata. Se requiere que cuenten con los recursos necesarios para realizar las pruebas de diagnóstico de laboratorio pertinentes, el tratamiento inmediato de los casos diagnosticados, la atención de las complicaciones, y para las referencias y contra referencias que se pudieran necesitar.

Un Sistema de Salud preparado para prevenir y controlar la presencia de dengue contribuye eficazmente a disminuir la morbilidad y mortalidad por dengue, pero no resuelve el problema en su integridad.

M.L. Pérez G.

b) <u>Acciones a mediano y largo plazo: Determinantes estructurales</u>

Son acciones orientadas a intervenir en los determinantes estructurales ligados a la presencia de dengue en la población; y que por su naturaleza no pueden ser abordados desde el Sistema de Salud o de los establecimientos de salud, sino que atañe a otros actores sociales que están más allá del Sector Salud, en otros sectores del estado y en otros niveles de gobierno, y por tanto su implementación implica un trabajo de mediano y largo plazo. Es importante precisar que en realidad las acciones de intervención sobre los determinantes estructurales son los que tendrán efecto trascendente y definitorio respecto a la prevención del dengue y para modificar el patrón de comportamiento epidemiológico, sanitario y social inherente.

b.1. Modificación de *comportamientos y estilos de vida*

- Elaboración de propuestas de contenidos curriculares según nivel educativo.

La verdadera y definitiva modificación positiva de comportamientos y estilos de vida para contribuir a la prevención de dengue es la que se incorpora al conocimiento de las personas desde la niñez, desde el aprendizaje en la

[16] Prevención secundaria: acciones que se desarrollan para intervenir de inmediato en cuanto aparece el primer caso, y se evita la aparición de más casos por contagio.
Prevención terciaria: Acciones que se desarrollan para atender y disminuir el riesgo de secuelas.

infancia, en la escolaridad (educación primaria), y que debe ser extendida a los contenidos educativos en los estudios secundarios, y afianzados en los estudios superiores generales, sean universitarios o técnicos, de la población educativa en general pero de los estudiantes en particular, esta acción es responsabilidad del Sector Educación.

Al Sector Salud, le corresponde desde el nivel nacional y regional, proponer los contenidos conceptuales y educativos sobre las practicas saludables, medidas de prevención y control del dengue necesarios de ser impartidos en las instituciones educativas como parte de los contenidos curriculares correspondientes, adecuados a la etapa educativa, al grupo etario, y a las necesidades endémicas y epidemiológicas relacionadas al dengue de la población objetivo. También le corresponde a la Autoridad de Salud del nivel nacional y regional establecer las coordinaciones y acuerdos necesarios para que el Sector Educación incorpore los contenidos educativos en instituciones educativas públicas y privadas; en las universidades e institutos superiores, según corresponda.

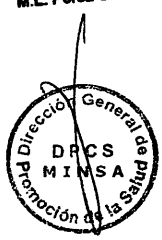
No debe confundirse ni pretender restringirla esta intervención a la labor del personal de los establecimientos de salud, sino que esta labor corresponde a la autoridad sanitaria regional y nacional. Como es evidente, esta intervención relativa a la elaboración de propuestas de contenidos curriculares es planificada, programada, estructurada, estandarizada y sistematizada, para ser aplicada dentro del sistema educativo por los docentes previamente capacitados en prácticas saludables para la prevención del dengue quienes deben manejar y enseñar los contenidos establecidos.

Los contenidos, que deben ser propuestos por el Sector Salud, estarán referidos a conocer la enfermedad y los riesgos a los que se exponen las personas, la promoción de estilos y hábitos de vida saludables, la prevención de la enfermedad, el reconocimiento de los signos y síntomas de alarma, a dónde y cuándo acudir para atención, así como el tratamiento y eliminación sistemática de potenciales criaderos de zancudo en la vivienda, en las instituciones educativas y centros laborales.



b.2. Acceso a *servicios de agua potable y desagüe*

- Elaboración de Proyectos de Inversión Pública.



Sin duda que la prevención de dengue será dramáticamente más efectiva si la población no requiere almacenar agua en reservorios que les permita disponer de ella cuando lo necesite. El acceso a servicios básicos de agua y desagüe domiciliario es un elemento clave para cambiar sustancialmente la calidad de vida de la población, y es un paso trascendente para salir de la exclusión social y económica, y es reflejo de la capacidad del Estado, y de los gobiernos nacional, regional y local para responder a las necesidades sociales básicas de la población a la que sirven.

En ese orden de ideas, la elaboración de proyectos de inversión pública para dotar de servicios de agua y desagüe intradomiciliario es un paso indispensable para que los sectores más pobres de la población accedan a este servicio básico, y que es condición para vivir con dignidad y con niveles de salubridad mínimos indispensables.

Como es lógico, esta intervención en la DSS estructural aludida está relacionada a la pobreza y las condiciones de vida, entre otras, y demanda la participación de los 3 niveles de gobierno, de otros sectores como Vivienda, Economía, entre otras, que están involucrados en la formulación, aprobación, financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, y que obviamente no dependen del Sector Salud ni del personal de los establecimientos de salud. Sí corresponde a la Autoridad de Salud, del nivel nacional y regional, realizar las acciones de incidencia y abogacía en los niveles de gobiernos, como en los

gobiernos locales para su incorporación en la agenda política y priorización en los presupuestos participativos y otras fuentes de financiamiento para la inmediatez de su ejecución.

b.3. Funcionamiento de *sistemas efectivos y seguros de recojo de desperdicios y disposición de residuos sólidos*

Otra área que requiere intervención para actuar en los determinantes estructurales es el funcionamiento de sistemas efectivos y seguros de recojo de desperdicios y disposición de residuos sólidos, los cuales dependen de los gobiernos locales, y cuyas deficiencias generan mayores riesgos para crear condiciones favorables de reproducción y crianza del vector.

Es imprescindible que se tenga acciones para orientar a la población para la disposición adecuada de desperdicios domiciliarios, el recojo y eliminación de criaderos, el puntual y sistemático de recojo de basura, y la disposición correcta de estos.

Si se suma esto a la disposición de agua potable y desagüe intradomiciliario, y a la educación desde el sistema educativo, se estará trabajando en los determinantes estructurales y se podrá modificar definitivamente las condiciones de riesgo de enfermar de dengue en la población.

Evidentemente las acciones de este rubro no corresponden al Sector Salud para su realización sino a los otros sectores, gobiernos regionales y locales; a la Autoridad de Salud, de nivel nacional y regional le corresponde realizar acciones de incidencia y abogacía con los otros sectores, gobiernos regionales y locales para que se priorice la ejecución de las funciones sanitarias que la ley asigna a los gobiernos locales.

6.2.3 Proyectos de Inversión

La Dirección General de Políticas de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestra una "Guía simplificada con conceptos y contenidos básicos para la elaboración de un estudio de pre inversión, a nivel de perfil de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) de atención médica básica de salud". La finalidad de esta guía es servir de apoyo a los operadores como los gobiernos locales o entidades no gubernamentales, que deseen acceder al Sistema Nacional Inversión Pública (SNIP); permitiendo impulsar la formulación de perfiles de proyectos técnicamente sustentados, que incrementen de manera significativa la inversión de calidad, en proyectos de inversión pública en el contexto de la salud como producto social.

Para acceder a la referida Guía puede acceder al enlace del Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, en el siguiente enlace web:

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/salud/Guia_Simplificada_Salud

6.2.4 DEL EQUIPO DE TRABAJO: CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

a) <u>De la conformación del Equipo de Trabajo:</u>

Para la implementación del presente Documento Técnico, se requiere la conformación de un equipo de trabajo conjunto entre el Municipio – Microrred/Red / DIRESA / GERESA / DISA o la que hagan sus veces, el que conducirá las líneas de acción de la intervención.

La autoridad sanitaria regional coordinará con la municipalidad para que se designe al "Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue" que debe ser (de preferencia) el Gerente de Desarrollo Social o de Salud si fuera el caso, y a un equipo de trabajo conformado por:

- El encargado de Saneamiento Ambiental de la municipalidad o el que haga sus veces.
- El encargado de Imagen Institucional de la municipalidad o el que haga sus veces.
- El encargado de Participación Vecinal de la municipalidad o el que haga sus veces.

La autoridad sanitaria regional solicitara a la municipalidad para que informe oficialmente acerca del equipo de trabajo conformado en la municipalidad. **Ver Anexo 1 (modelo de informe)**.

La Microrred/Red/DIRESA/GERESA/DISA o la que hagan sus veces, a su vez designará al equipo responsable que estará conformado por:

- Jefe o el que haga sus veces, de la Red/Microrred / Establecimiento de Salud, que será el principal punto de contacto.
- El responsable de las Enfermedades Metaxénicas o Dengue de la Red/Microrred/ Establecimiento de Salud.
- El responsable de Saneamiento Ambiental de la Red/Microrred / Establecimiento de Salud.
- El responsable de Epidemiología de la Red/Microrred / Establecimiento de Salud.
- El Coordinador de Promoción de la Salud de la Red/Microrred / Establecimiento de Salud.

Esta conformación se hará de conocimiento de la autoridad municipal mediante un oficio dirigido al Alcalde o Alcaldesa con atención al Coordinador del Equipo de trabajo Dengue. **Ver Anexo 2.**

IMPORTANTE:

Para dar oficialidad a la conformación del Equipo de Trabajo DENGUE, corresponde al Alcalde o Alcaldesa emitir una Resolución de Alcaldía reconociendo al Equipo de Trabajo DENGUE y la enviará a la DIRESA/GERESA/DISA de su jurisdicción. Ver Anexo 3.

b) <u>De la organización del Equipo:</u>

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue, será el responsable de convocar oficialmente a las siguientes reuniones a todos los actores involucrados en el tema del dengue:

- Reunión de coordinación para realizar la medición de la línea basal: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (ECAP) y medición del Índice Aédico y Breteau.
- Reunión de coordinación con la municipalidad para definir responsabilidades en la implementación de las intervenciones. Por ejemplo: Para elaborar el Plan de Comunicación, el Área de Comunicación Social: Responsable de Imagen Institucional del Municipio y Coordinador de

Promoción de la Salud, y/o el responsable del Área de Comunicaciones de la Red/DIRESA/GERESA/DISA; en caso fuera necesaria su participación.

- Reuniones de organización para la implementación de las actividades.
- Reuniones para el monitoreo del cumplimiento de las actividades.
- Reuniones de evaluación o control post-intervención.

El número de reuniones, se establecerán de acuerdo a la realidad local respetando el tiempo o periodo de ejecución de las acciones sanitarias.

La DIRESA/GERESA/DISA/Red/Jefe de la Microrred, enviará a la municipalidad la información periódica de índice aédico y alertará de las zonas de alto riesgo en las que hará la intervención.

El Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microrred, orientará y coordinará con el encargado de Saneamiento Ambiental de la municipalidad para que, conjuntamente con el responsable de Saneamiento Ambiental de la DIRESA/GERESA/Red/Microrred, realicen la medición basal, periódica y de control del índice aédicos y Breteau; así como, la organización de las campañas de recojo y eliminación de criaderos (inservibles).

Por otro lado, el Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microrred, invitará al responsable de participación vecinal del municipio y a su equipo, a la capacitación referida a las practicas saludables y el recojo y eliminación de criaderos; y así puedan estar preparados para participar activamente en las visitas a las familias ubicadas en las zonas de riesgo.

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DGPS MINSA

RECORDAR:

Que las funciones sugeridas del Equipo de Trabajo Dengue son generales, pudiendo ser adaptadas a cada realidad, sin dejar de cumplirse todas las actividades para el éxito de la intervención.

6.2.5 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE

La Línea de Base o Línea Basal, será la primera medición de todos los indicadores contemplados en el plan de trabajo a implementar. Nos hace conocer cuál es la situación de los cuatro indicadores previa a la intervención: La Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la Población, el Índice Aédico: que evalúa la dispersión del zancudo en la localidad, el Índice de Breteau que refleja los hábitos y costumbres de la población, y el número de casos de dengue reportados; para luego comparar los cambios que se han logrado gracias a la intervención. Esta línea de base se realizará en la localidad seleccionada a intervenir en los distritos de riesgo o endémicos. A continuación, se detallan los indicadores a utilizar:

a) **Medición de Encuesta para la Evaluación de Conocimientos, Aptitudes y Prácticas (ECAP):** con el fin de identificar algunos hábitos, costumbres y cuánto conoce la población acerca de los factores que favorecen o no la transmisión del dengue, se aplicará una encuesta, en las zonas de riesgo del distrito.

Su elaboración estará a cargo del equipo técnico del Ministerio de Salud, el IGSS/DISA/DIRESA/GERESA o la que haga sus veces (Promoción de la Salud); del mismo modo se coordinará con el área respectiva del municipio para la aplicación conjunta de la misma y la respectiva sistematización de los resultados.

Para la aplicación de la encuesta CAP, se debe tomar una muestra representativa de la población objetivo (dependiendo de su realidad, considerar el número de habitantes y viviendas). Ver Anexo 4. (Fórmula muestral)

Referencia del tamaño muestral:

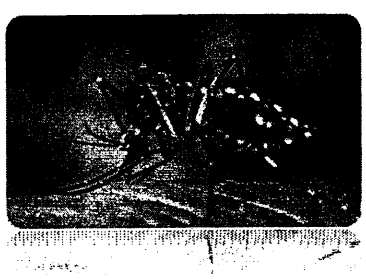
- Población hasta 100 hab. = 41 personas
- De 101 - 500 hab. = 111 personas
- De 501 - 1000 hab. = 142 personas
- De 1001- 5000 hab. = 182 personas
- De 5001- 10000 hab. = 189 personas
- De 10001 – 30000 hab. = 194 personas
- >50000 hab. = 196 personas

M.L. Pérez G.

b) Medición del Índice Aédico (IA): Mide el porcentaje (%) de casas positivas con larvas y pupas de *Aedes aegypti* en una localidad. Este índice por encima del 2 % es de muy alto riesgo; y que al no intervenir puede desencadenar en brotes de dengue. Se determina realizando la inspección en el 10% de las viviendas totales, en forma mensual en las localidades positivas a la presencia del vector.

El IA con el que se reporta los resultados de la vigilancia entomológica, refleja el porcentaje de viviendas que se encuentran positivas a la presencia del *Aedes aegypti*, en una localidad (localidad = jurisdicción correspondiente a un establecimiento de salud). Asimismo, se ha establecido tres niveles de riesgo en función de los IA:

- Bajo Riesgo : 0.0% - 1.0%
- Mediano Riesgo: 1.1% - <2.0%
- Alto riesgo : >2.0%



IMPORTANTE:

Reducir el índice aédico, a menos del 2% en las localidades en riesgo de dengue, de acuerdo a los criterios establecidos por la DIGESA del Ministerio de Salud.

c) **Medición del Índice de Breteau (IB):** Mide el porcentaje de recipientes positivos con larvas y pupas de *Aedes aegypti*, en el total de las casas inspeccionadas de una localidad. Este índice nos refleja los hábitos y costumbres que tienen las familias en las viviendas de una localidad.

Se recomienda realizar esta medición previa a la intervención y al final de ésta

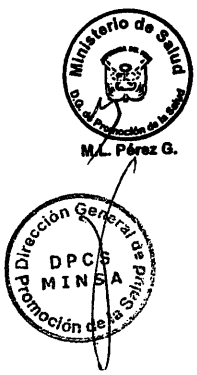
N°	Parámetro entomológico	Riesgo		Formula
		Bajo	Alto	
01	Índice de Breteau	Menor o igual de 5.0%	Mayor de 5.0%	N° de recipientes positivos a larvas x 100 / N° de viviendas inspeccionadas

Fuente: *Ministerio de Salud de El Salvador.2012. Lineamientos Técnicos para el Abordaje del Dengue.*



ES RECOMENDABLE:

Reducir el índice de Breteau a menos del 5.0 % en las localidades en riesgo de dengue.



d) <u>Reporte del Número de Casos de Dengue:</u> Medición concerniente a la incidencia (número de casos nuevos de dengue), registrados en el período en que empiezan (línea basal) y concluye momentáneamente las intervenciones propuestas (línea control), en un determinado territorio o localidad. Los datos serán proporcionados por las oficinas regionales o locales de epidemiología, en base a la información reportada por el sistema nacional de vigilancia y control de enfermedades.

Finalmente, concluimos las mediciones con una **línea control** al terminar una etapa de las intervenciones, donde se evaluará la gestión del Equipo de Trabajo Dengue, en el período de un año. Estas mediciones, darán a conocer el grado de eficacia de las intervenciones que se realizó conjuntamente con las municipalidades.

<u>Nota</u>: Al inicio de la intervención, se aplicará una línea de base y al término de la intervención, se realizará la línea de control de las actividades.

6.2.6 IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO

a) Las intervenciones a corto plazo forman parte del proceso de implementación en el marco del trabajo con municipios y comunidades saludables; buscando disminuir los potenciales criaderos del zancudo y lograr una población libre del riesgo de enfermar y/o morir por dengue. Estas comprenden:

a.1. Comunicación social en salud.

a.2. Vigilancia comunitaria.

a.3. Campaña masiva de eliminación de criaderos de zancudos.

a.4. Recojo y procesamiento de residuos sólidos.

a.5. Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos en instituciones educativas y centros laborales.

a.1. Comunicación Social en Salud:

El equipo de trabajo dengue debe elaborar un Plan de Comunicación Social anual.

Este plan se establecerá en 2 fases:

Primera Fase: La autoridad sanitaria regional (DIRESA, GERESA/DISA o la que hagan sus veces), elaborará y validará el material educativo comunicacional. Su ejecución será en los primeros meses (abril – mayo de todos los años).

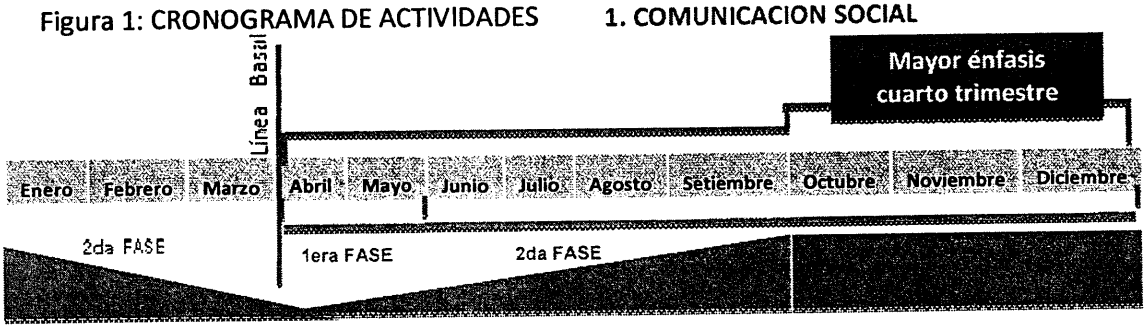
Cabe resaltar, que para la elaboración de los mensajes, se debe tener en cuenta la información de los órganos técnicos competentes del nivel nacional (Oficina General de Comunicaciones) y del nivel regional, de tal manera que los mensajes dirigidos a la población sean precisos y efectivos.

Segunda Fase: Consistirá en la reproducción en diferentes formatos educativo comunicacionales (folletería, dípticos, audio, spot radial y televisivo, entre otros), y difusión de los mensajes en los diversos espacios de la comunidad, con énfasis en las zonas de alto riesgo. Asimismo, mediante el perifoneo y emisoras locales se difundirán los mensajes y se anunciará las campañas de recojo de criaderos. El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue estará a cargo de la segunda fase con asesoría continua del personal de salud de la GERESA/DIRESA/DISA o la que haga sus veces.

La difusión se realizará preferentemente en los meses de junio a diciembre y de enero a marzo del siguiente año y se intensificará según la autoridad sanitaria regional y local lo considere conveniente.

Por otro lado, se debe identificar a los diferentes actores locales, que puedan apoyar en la reproducción y difusión de los materiales educativos comunicacionales. Ejemplo: Instituciones del sector público y privado.

Figura 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1. COMUNICACION SOCIAL



a.2. Vigilancia comunitaria

La vigilancia está referida a todas las acciones que están orientadas a la eliminación de los potenciales criaderos del zancudo dentro y fuera de la vivienda.

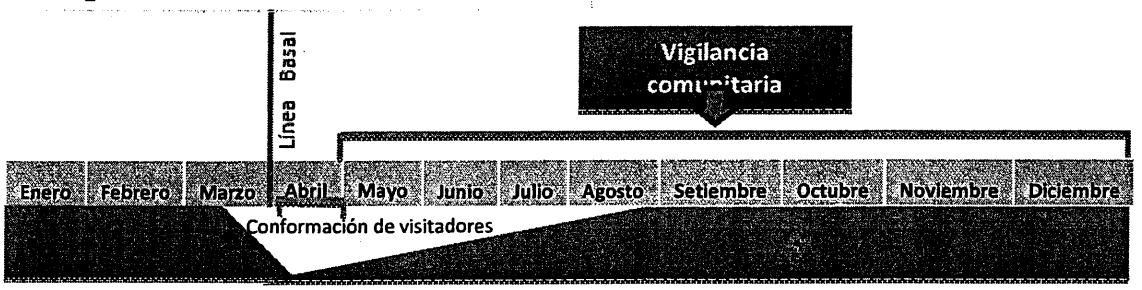
Para vigilar la Microrred/Red/ DIRESA/GERESA/DISA o quien haga sus veces identificará la zona de riesgo, para ello se debe obtener información del índice Aédico e índice Breteau del área de Saneamiento Ambiental de la autoridad sanitaria regional; con la finalidad de focalizar las intervenciones haciéndolas más efectivas.

Asimismo, la DIRESA/GERESA/DISA o quien haga sus veces, debe coordinar con la municipalidad para realizar un mapeo de las zonas críticas o de riesgo para mejorar las intervenciones sanitarias especialmente las preventivas y conformar un grupo de trabajo mixto con participación activa de la municipalidad, líderes comunales de: Juntas Vecinales Comunales (JVC), Organización Social de Base (OSB) y Agentes Comunitarios de Salud (ACS), para realizar las visitas a las familias de las zonas de riesgo. Esto se desarrolla con la asistencia técnica y acompañamiento del personal de salud de la jurisdicción.

Las DIRESAs/GERESAs/DISAs realizarán por lo menos dos (2) talleres de capacitación en los meses de mayo y junio; dirigido a los grupos que visitarán las viviendas de las localidades de riesgo, para que realicen acciones de educación e inspección casa por casa en la localidad, las que se intensificarán en periodos de riesgo.

Se sugiere, que al grupo de voluntario (ACS, estudiantes u otros), se les pueda brindar algún tipo de incentivo, no monetario por la vigilancia comunitaria realizada casa por casa. Ver Anexo 5.

Figura 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



a.3. Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)

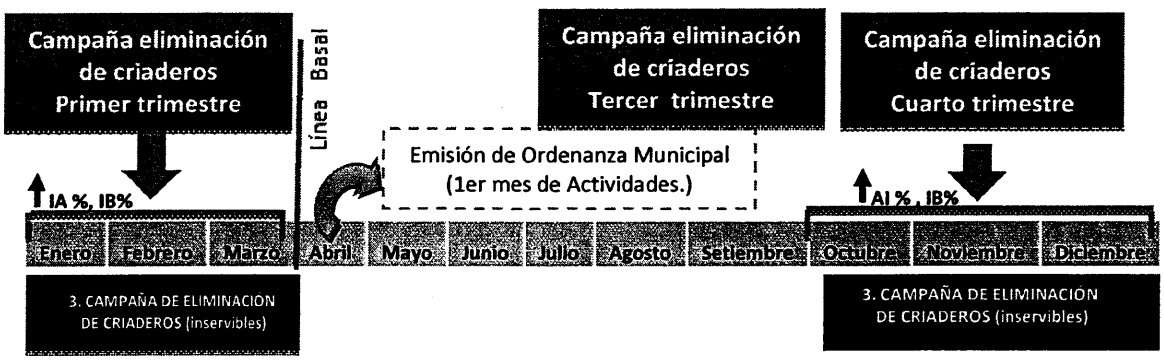
La DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred de salud orientará y coordinará con la municipalidad para que se emita una ordenanza que incorpore un cronograma de campañas masivas de eliminación de criaderos (inservibles), con una frecuencia no menor de dos (2) al año.

La DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred de salud deberá coordinar con la municipalidad, para que autorice al área correspondiente, para promover la participación de los actores sociales de los diferentes sectores de su ámbito, especialmente las organizaciones comunitarias, con quienes ejecutará las campañas de preferencia en el primer, tercer y cuarto trimestre del año (relacionado a periodos de lluvias); con la permanente orientación técnica de la autoridad sanitara.

La DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred de salud debe orientar a la municipalidad en el recojo y eliminación de criaderos (inservibles). Tener en cuenta que un punto crítico bajo responsabilidad y control de la municipalidad es la disposición final de los residuos sólidos y potenciales criaderos para evitar el reciclaje y la exposición de los mismos al aire libre en los puntos de acumulación o acopio.

Nota: En caso de no contarse con la maquinaria pesada (camiones recolectores, y otros.); la municipalidad puede coordinar y gestionar con la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y/o con la Gerencia Regional de Obras e Infraestructura.

Figura 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD



M.L. Pérez G.

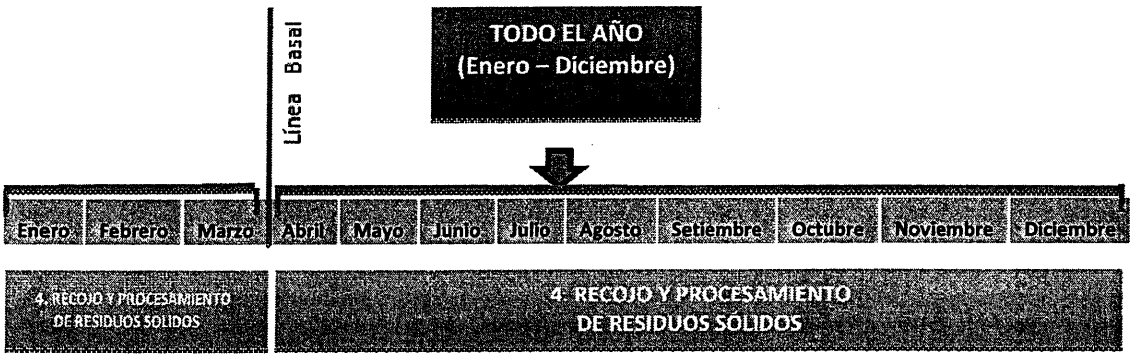
DPOS MINSA

a.4. Recojo y procesamiento de residuos sólidos

La DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred de salud incidirá sobre la importancia de la función de la municipalidad en mantener la regularidad y cumplimiento del servicio de recojo y eliminación de residuos sólidos, especialmente en las zonas de riesgo de dengue, para evitar la acumulación de criaderos en las calles o puntos de acopio.

Esta actividad, se encuentra establecida en los sub numerales 4.1 y 4.3 del numeral 4 del artículo 80° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, que refiere como funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales, el administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo; y difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

Figura 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



e) Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)

Son actividades focalizadas, que buscan intervenir espacios públicos y privados para el recojo y eliminación de criaderos de zancudos.

En un distrito endémico esta actividad debe ser realizada por lo menos cuatro (4) veces al año: dos (2) campañas en centros laborales y dos (2) campañas en instituciones educativas (nivel primaria, secundaria y superior); recomendándose realizarlas en el último semestre del año, entre los meses de septiembre a diciembre, específicamente; coincidiendo con la culminación del año académico, la estación primaveral y el comienzo de vacaciones e inicio de las lluvias y el verano.

A nivel de centros laborales, la DIRESA/GERESA/DISA/Red orientará y acompañará a la municipalidad para que coordine con las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo para organizar las campañas de eliminación de criaderos en los centros laborales de la jurisdicción, definiendo fechas simultáneas (2 veces al año) en las que se realizará el recojo y eliminación de criaderos; la cual consiste en organizar a los trabajadores de la empresa para que en el día señalado recojan los potenciales criaderos de su centro laboral y acopien en un lugar predeterminado, y la municipalidad pueda recogerlo para su eliminación final.

A nivel de las Instituciones Educativas (II.EE.), la actividad consiste en movilizar a la población escolar para el recojo de potenciales criaderos (inservibles) dentro de sus instalaciones (limpieza) y desde los domicilios de los escolares mediante el (concurso interescolar).

Para el caso de la "limpieza", la DIRESA/GERESA/DISA/Red deberá orientar a la dirección de la UGEL para que determine la fecha y hora en la que todas las IIEE de su jurisdicción realizarán una jornada simultánea de eliminación de criaderos dentro de las IIEE, la que deberá ser coordinada con la municipalidad para el respectivo recojo de los criaderos (inservibles) en los puntos de acopio y su respectiva eliminación. En esta actividad la DIRESA/GERESA/DISA/RED juntamente con la UGEL y Municipalidad deberán promover la participación del sector privado y otras instituciones para premiar a la II.EE. que mantiene sus ambientes libres de criaderos de zancudo.

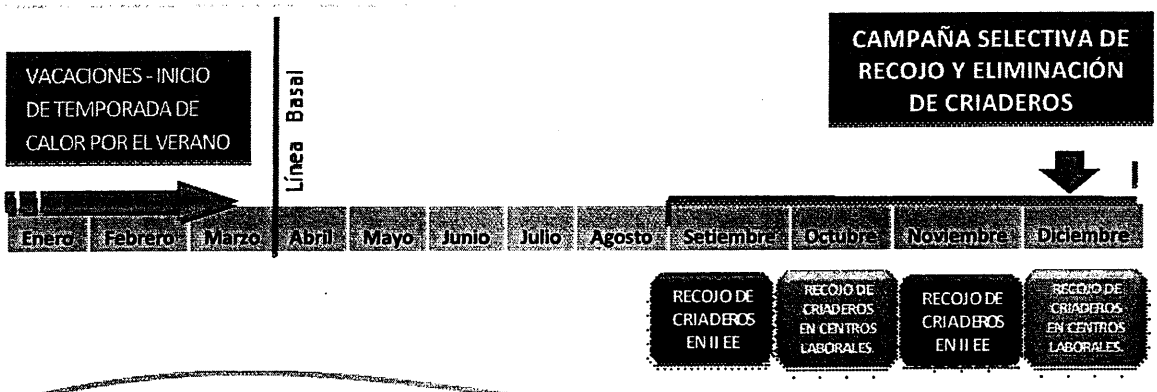
Para el caso de los concursos inter escolares, la DIRESA/GERESA/DISA/Red promoverá, coordinará y orientará a la Municipalidad y UGEL para que organicen los concursos entre II.EE. de su jurisdicción, en el que la población escolar recogerá de sus casas los potenciales criaderos del zancudo (inservibles) y los trasladará hacia un sitio de acopio preferentemente afuera

M.L. Pérez G.

de la II.EE.; y la Municipalidad se encargue de pesar, recoger y eliminar los potenciales criaderos desde el punto de acopio. Ver detalles del concurso en el Anexo 6.

Nota: La DIRESA/GERESA/Red orientará a la municipalidad para que previamente a las actividades, tenga en cuenta que los "espacios finales" de disposición de residuos sólidos posean las condiciones básicas establecidas por la DIGESA y evitar convertirlos en focos infecciosos de reproducción y multiplicación del zancudo.

Figura 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Nota: Se debe promover que todas las actividades sean lideradas por el Gobierno Local; en estrecha coordinación con la DIRESA/GERESA/DISA/Red, según corresponda.

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

IMPORTANTE:

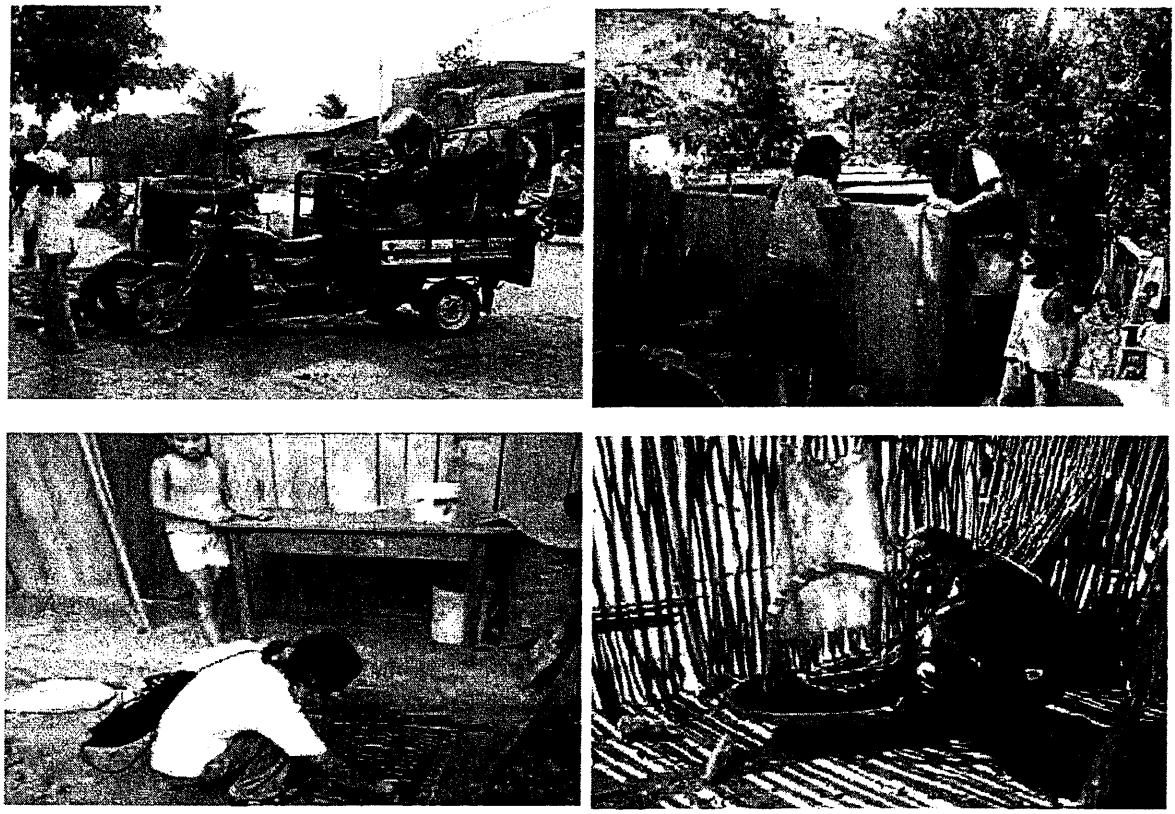
La DIRESA/GERESA/DISA/Red o la que haga sus veces, incidirá y brindara Asistencia Técnica al Municipio para que estas cinco intervenciones de corto plazo, se incluya en el Plan Operativo Institucional como una actividad del Área de Salud del municipio, debiendo considerarse todos los gastos en los que se va a incurrir.

Ver detalles de las actividades en el Anexo 7.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPOS
MINSA

¿Qué resultados se espera lograr con estas intervenciones?

Reducción de los niveles de infestación aédica (zancudos) a menos del 2%, en las localidades intervenidas mediante la ejecución intensiva y permanente de actividades de eliminación de criaderos intra y peridomiciliarios.



Diversas actividades de vigilancia y control de dengue: Recojo de inservibles en San Martín y Vigilancia Entomológica en Lima, Loreto y Lambayeque.
FUENTE: DIRESA, 2011

OTRAS ACCIONES:

También, se recomienda a las DIRESA/GERESA/DISA/Red o la que haga sus veces realizar otras acciones de promoción de la salud, organizado según cinco (5) grupos objetivos de trabajo (Personal de salud, autoridades regionales y locales, Sector Educación, OSB, ACS y población en general, y Sector Privado y centros laborales) para prevenir el dengue.

Ver detalles de las actividades en el Anexo 8.

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

b) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las acciones a corto plazo se desarrollará, de acuerdo al cronograma de intervención sugerido en el Anexo 10 del Documento Técnico para el periodo de un (1) año; los tiempos se han establecido en función de los factores relacionados al dengue, como clima, prácticas de la población y funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.

c) MONITOREO Y EVALUACIÓN

c.1. DEL MONITOREO:

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue, el Jefe de la Red/Microrred/ Establecimiento de salud y el resto de los miembros del equipo conformado, realizarán las reuniones de monitoreo al segundo y tercer trimestre, con apoyo de las otras áreas técnicas de la DIRESA /GERESA/DISA involucradas en el tema.

Monitoreo trimestral

Se monitorea, a través del indicador: medición de Índice Aédico (IA) e Índice Breteau (IB) para confirmar el logro de las intervenciones, utilizando los datos de los tres (3) últimos trimestres de intervención:

Monitoreo 1:

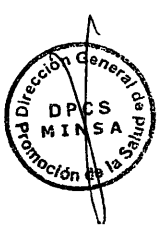
Del segundo trimestre: (Se reporta en el mes de julio)

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue conjuntamente con el Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/ Microrred/Establecimiento de salud enviará el informe del resultado del Monitoreo 1, al Alcalde y al Director General de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, máximo a los diez (10) días del mes de julio.

El resultado del monitoreo corresponde a la:

- Medición del Índice Aédico del segundo trimestre de cada año (junio), a reportar en el mes de julio, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.
- Medición del Índice de Breteau del segundo trimestre de cada año (junio), a reportar en julio, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.





Monitoreo 2:

Del tercer trimestre: (Se reporta en el mes de octubre)

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue conjuntamente con el Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/ Microrred/ Establecimiento de salud enviará el informe del resultado del Monitoreo 2, al Alcalde y al Director General de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, máximo a los diez (10) días del mes de octubre.

El resultado del monitoreo corresponde a la:

- Medición del Índice Aédico del tercer trimestre de cada año (setiembre) a reportar en el mes de octubre, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.
- Medición del Índice de Breteau del tercer trimestre de cada año (setiembre) a reportar en el mes de octubre, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.

Monitoreo 3:

Del cuarto trimestre: (Se reporta en el mes de enero)

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue conjuntamente con el Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/ Microrred/Establecimiento de salud enviará el informe del resultado del Monitoreo 3, al Alcalde y al Director General de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, máximo a los diez (10) días del mes de enero del siguiente año.

El resultado del monitoreo corresponde a la:

- Medición del Índice Aédico del tercer trimestre de cada año (diciembre) a reportar en el mes de enero, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.
- Medición del Índice de Breteau del tercer trimestre de cada año (diciembre) a reportar en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.

CUADRO N° 01: Donde se detalla la metodología para alcanzar los indicadores.

MONITOREO 1:

Medición del IA segundo trimestre = IA Junio

Medición del IB segundo trimestre = IB Junio

MONITOREO 2:

Medición del IA tercer trimestre = IA Setiembre

Medición del IB tercer trimestre = IB Setiembre

MONITOREO 3:

Medición del IA cuarto trimestre = IA Diciembre

Medición del IB cuarto trimestre = IB Diciembre

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

GRÁFICO N° 01: Se muestra correlativamente un ejemplo de la medición trimestral del Índice Aédico.

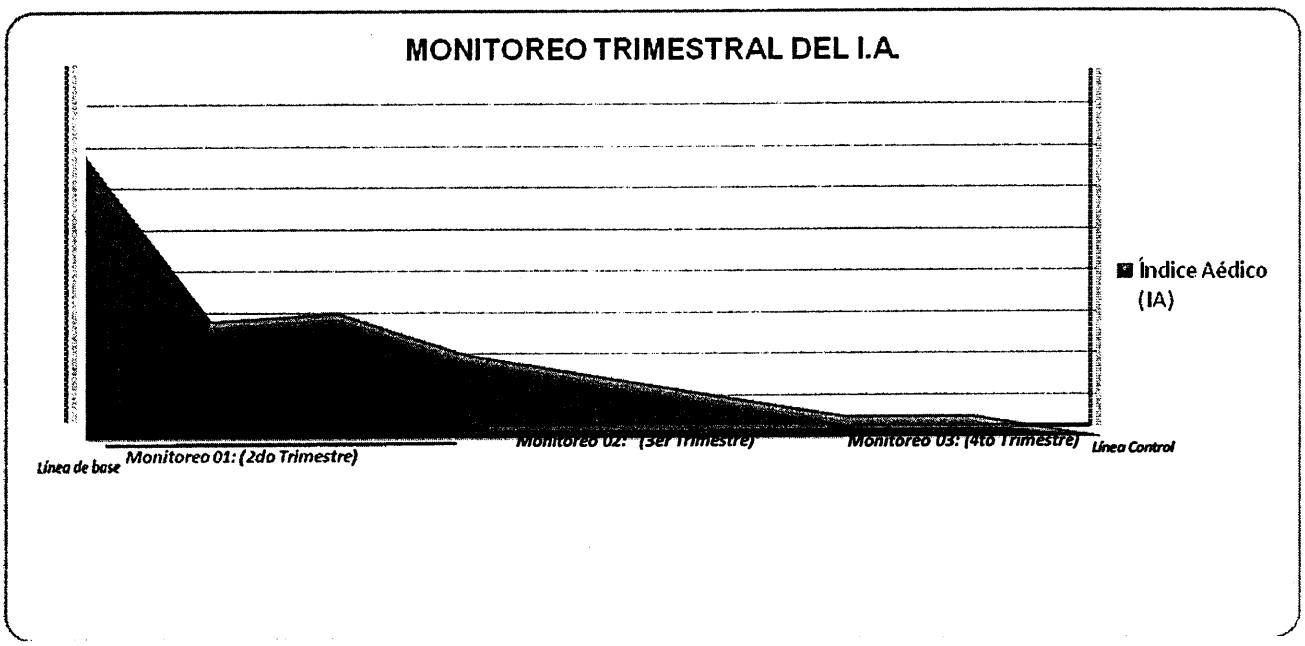
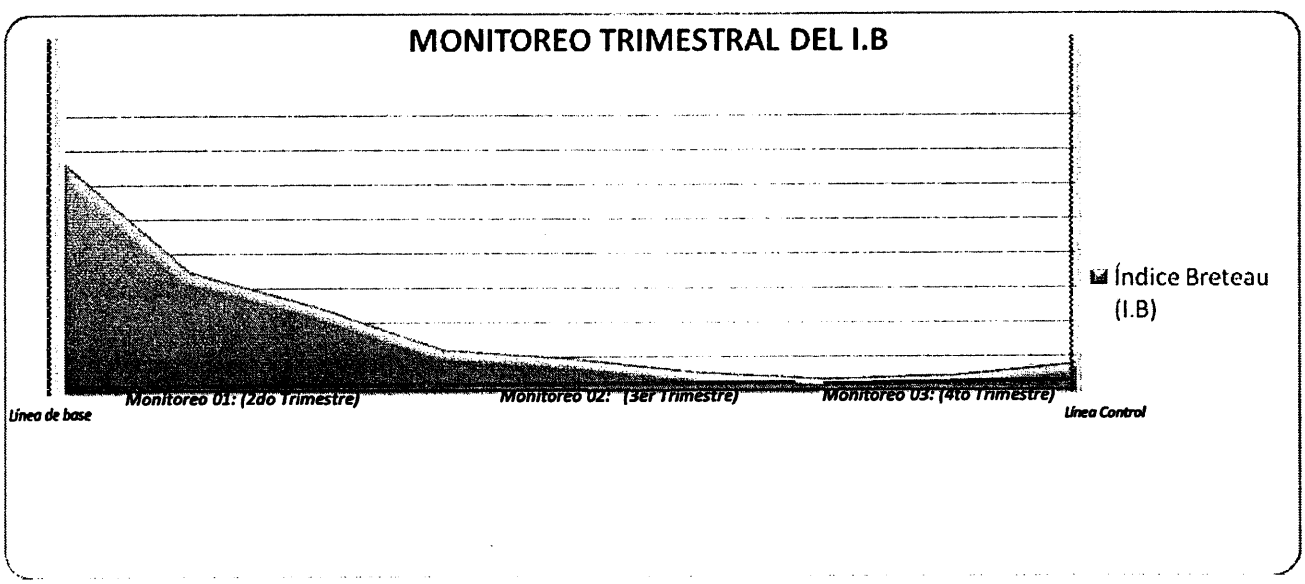


GRÁFICO N° 02: Se muestra correlativamente un ejemplo de la medición trimestral del Índice Breteau.



Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

REPORTE DE MONITOREO TRIMESTRAL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS COJUNTAMENTE CON LOS GOBIERNOS LOCALES DE LAS ZONAS ENDÉMICAS DE DENGUE

REPORTES *	PERIODO	PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN	LUGAR DE PRESENTACIÓN
Segundo trimestre reporte	Junio	Hasta el 10 de julio del año ____	MUNICIPALIDAD Y DIRESA/ GERESA/DISA
Tercer trimestre reporte	Setiembre	Hasta el 10 de octubre del año ___	
Cuarto trimestre reporte	Diciembre	Hasta el 10 de enero del siguiente año.	

(*): Se reportara a partir del segundo trimestre, debido a que generalmente en el primer trimestre están realizando intervenciones de emergencia (brotes).

Nota: El Índice Aédico (IA) se mide de la siguiente manera: Porcentaje de casas positivas al *Aedes aegypti,* en una determinada localidad.

Mide la dispersión del vector en la localidad.

$$\frac{\text{Nº Viviendas positivas}}{\text{Nº viviendas inspeccionadas}} \times 100$$

Nota: El Índice Breteau (IB) se mide de la siguiente manera: Porcentaje de recipientes positivos en las casas inspeccionadas de la localidad; mide la cantidad de recipientes positivos por vivienda inspeccionada.

$$IB = \frac{\text{Nº Recipientes positivos}}{\text{Nº viviendas inspeccionadas}} \times 100$$

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

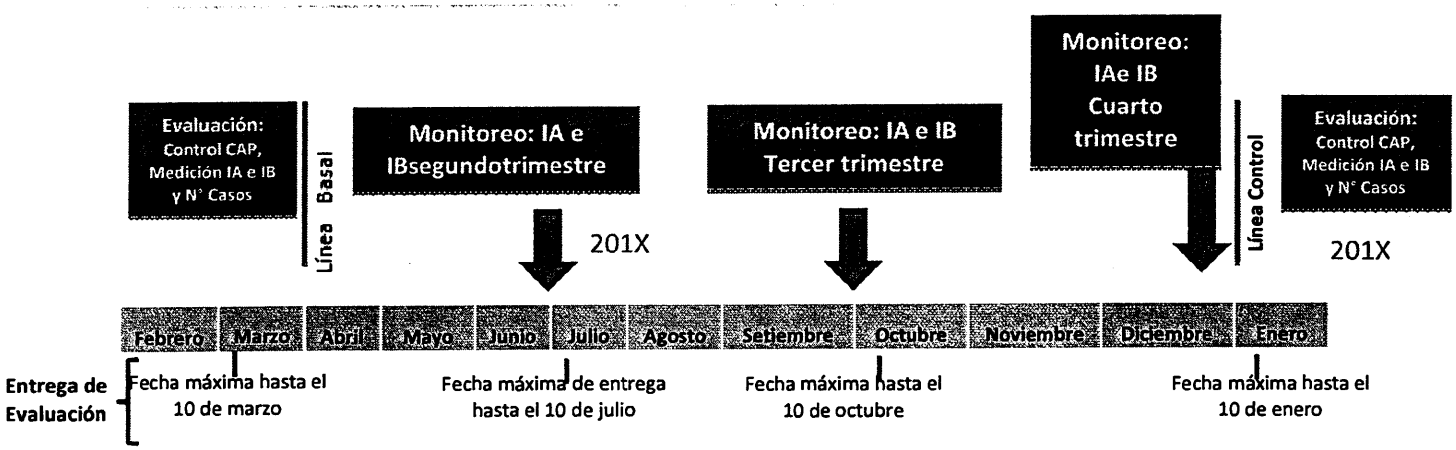
c.2. DE LA EVALUACIÓN O LÍNEA CONTROL:

NOTA: Se evaluará y se realizará, la línea de control al término de la intervención (en diciembre). *Indicadores de Control a evaluar*: Índice Aédico (IA), Índice de Bretau (IB), número de casos y encuesta **CAP.**

El Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue y el Coordinador de Promoción de la Salud de la DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microrred elaborarán conjuntamente el informe de evaluación de la gestión sanitaria para la prevención del dengue a fin de cada año, cuya copia será enviado a la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Ver en el Anexo 11 (ejemplo de informe).

El Informe de Evaluación/Control debe ser remitido en el plazo máximo de entrega, hasta los diez (10) primeros días del mes de marzo, del siguiente año.

Figura 6: CRONOGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN



Ver Esquema Completo del Plan de Intervenciones en Anexo 12.

6.2.7 EN DECLARACION DE BROTE EPIDEMICO

a) Acciones en brote epidémico: Cuando la DIRESA/GERESA/Red active la declaratoria de brote de dengue, debe realizar las siguientes acciones:

- Participar activamente en las reuniones del Comité Operativo de Emergencias (COE) Regional, Provincial o Distrital, según corresponda.
- Promover que el gobierno regional y los gobiernos locales convoquen y conduzcan las coordinaciones multisectoriales en el marco del brote.
- Incidir a que el gobierno regional y gobiernos locales como gestor territorial puedan organizar y coordinar actividades con empresas públicas, privadas, universidades, y otros actores locales de la jurisdicción para que participen en el control del dengue.
- Informar y coordinar acciones educativo comunicacionales con las autoridades del aeropuerto y terrapuerto; acerca de las medidas de prevención y control para evitar la propagación del dengue.
- Convocar a los prestadores de servicios del Sector Salud (Es Salud, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, entre otros establecimientos de salud públicos y privados, Hospitales de la Solidaridad, etc.) para coordinar acciones conjuntas de difusión de mensajes preventivos.
- Recomendar entre las organizaciones de sociedad civil, organismos cooperantes, las OSB y los programas sociales, la utilización de teléfonos y radios para la comunicación oportuna de casos sospechosos de dengue en la comunidad incluyendo la línea de INFOSALUD al 0800-10828.
- Establecer el uso de instrumentos de referencia y contrarreferencia comunal para derivar casos sospechosos de dengue a los establecimientos de salud.
- Activar e incorporar a las JVC y las OSB a la Red de Vigilancia de Febriles para comunicar oportunamente a las autoridades de salud de su localidad.
- Promover en coordinación con la autoridad educativa, la activación de la red de vigilancia de la comunidad educativa, previamente capacitados en medidas de prevención y control del dengue, para la detección oportuna de febriles, mediante la cual diariamente los alumnos de las II.EE y universidades reporten a sus tutores la ocurrencia de algún evento en su vivienda o localidad, relacionada a la aparición de casos de febriles compatibles con dengue y la presencia del vector o de potenciales criaderos intra y peridomiciliarios.
- Conformar con los ACS brigadas educativas para la recuperación de casas cerradas y renuentes para la intervención en zonas de brote.
- Promover que la autoridad del gobierno regional o local, según corresponda a sus funciones convoque a las principales empresas del sector privado; especialmente las farmacias y boticas, y medios de comunicación para implementar medidas de control del dengue, enfatizando en evitar la automedicación.
- Implementar estrategias de comunicación social masivas y selectivas dirigidas a la población focalizada en el brote, convocando el concurso de todo medio; que permita difundir los mensajes claves a la población; tales como, su participación activa en las campañas de eliminación de criaderos; motivarlos para facilitar el trabajo de fumigación y control focal del personal de salud; y mantener las bolsitas del larvicida (abate) durante el tiempo recomendado por la autoridad sanitaria regional; así como, limitar en lo posible la movilización de los enfermos de una localidad o distrito a otro, mientras dure el periodo de virosis y así evitar la propagación de la enfermedad.

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

- Establecer el monitoreo semanal de actividades, utilizando como referencia el cuadro de monitoreo diario de las actividades de promoción de la salud para el control y prevención del dengue. *Ver anexo 13.*

b) Casas Deshabitadas, Cerradas y Renuentes: ***En caso de encontrar casas deshabitadas, cerradas y renuentes***: El personal de salud de la DIRESA/GERESA/Red/Microrred debe coordinar y orientar a los diferentes actores involucrados, según sea el caso:

b.1 EN CASAS DESHABITADAS:

- Una vez que el personal de salud o ACS ha identificado, que la casa tiene riesgo de potenciales criaderos para la proliferación del zancudo y se observa que está deshabitada por más de un mes y no hay una persona responsable de la misma; se inicia la coordinación con la municipalidad.
- El Director de la Red/Microrred de Salud correspondiente a la jurisdicción asignada, deberá remitir a la municipalidad el listado del consolidado de las viviendas deshabitadas, identificadas durante las actividades de prevención y control del dengue.
- Se solicitará que la municipalidad de acuerdo a sus funciones según el artículo 80 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades identifique al propietario de cada una de las viviendas en lista, mediante sus fuentes informativas o solicite esta información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de ser necesario.
- El Director de la Red/Microrred de salud coordinará con la municipalidad para que en el marco de sus funciones notifique al propietario de cada una de las viviendas, en la fecha y hora, previamente coordinada con el personal de salud y de la municipalidad, quienes se acercarán a realizar las actividades de prevención y control del vector del dengue, el cual no debe exceder de una semana posterior a la notificación.
- Por otro lado, debe quedar establecido un canal de comunicación futuro entre la municipalidad y los propietarios de casas en zonas de riesgo y endémicas de dengue; de tal forma que se pueda citar para realizar las actividades de prevención y control del vector del dengue oportunamente.
- En caso, de que el propietario de la casa hiciera caso omiso a la notificación, entonces le corresponde al personal de la municipalidad oficiar a la Fiscalía de Prevención del Delito para que realicen una visita conjunta contra el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
- Seguidamente, la Fiscalía de Prevención del Delito realizará la visita de acuerdo a su competencia conjuntamente con el personal de salud y personal de la municipalidad en la fecha y la hora programada.
- El día de la visita si el propietario de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario no accede a la intervención, el Fiscal actúa de acuerdo a sus competencias.

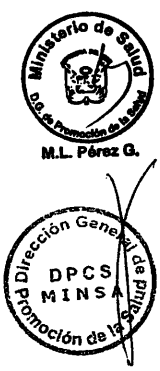
b.2 EN CASAS CERRADAS

- Una vez identificada, que la casa tiene riesgo de potenciales criaderos para la proliferación del zancudo y que los propietarios o poseedor de las viviendas, por diversos motivos están fuera de la vivienda durante las horas de las actividades de prevención y control del vector del dengue (inspección y/o fumigación) y no hay una persona responsable de la misma; se inicia la notificación respectiva.
- El personal de salud o ACS con la colaboración de los vecinos, identifica al propietario o poseedor de la casa (verificar con título de propiedad, constancia

de posesión o contrato de alquiler u otro documento a fin) y lo visita para comunicarle la próxima fecha de intervención y solicitar su apoyo para la realización de la actividad. En caso de no identificar al propietario o poseedor, se clasificará a la casa o predio como DESHABITADAS.

- El personal de salud y/o Agente Comunitario de Salud (ACS), realizarán el seguimiento del cumplimiento de la programación de las actividades de recuperación de viviendas cerradas desde el día siguiente de iniciadas y deberán informar acerca de las visitas fallidas al Director de la Red/Microrred correspondiente.
- El Director de la Red/Microrred de Salud correspondiente a la jurisdicción asignada, deberá remitir a la municipalidad distrital o provincial el listado del consolidado de las viviendas cerradas que hicieron caso omiso a la primera notificación.
- Una vez que la municipalidad recibe la relación de los propietarios de casas o predios cerrados que no colaboren con las actividades sanitarias, este actúa de acuerdo a sus competencias y realiza la notificación respectiva (Acta de advertencia 1), donde señala la fecha de la próxima visita.
- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario o poseedor no accede a la intervención, entonces le corresponde al personal de la Municipalidad oficiar a la Fiscalía de Prevención del Delito para que realicen una visita conjunta contra el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
- Seguidamente, la Fiscalía de Prevención del Delito realizará la visita de acuerdo a su competencia conjuntamente con el personal de salud y personal de la municipalidad en la fecha y la hora programada.
- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario no accede a la intervención, el Fiscal actúa de acuerdo a sus competencias.

b.3 CASAS RENUENTES:



- Una vez identificada, que la casa tiene riesgo de potenciales criaderos para la proliferación del zancudo y el personal de salud ha informado, exhortado y explicado a la familia de la importancia de abrir su puerta para la inspección y/o fumigación; además de dar a conocer las consecuencias legales de su acto, de poder ser investigada por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. El personal de salud o ACS registra la casa como **RENUENTE**.
- El Director de la Red/Microrred de Salud correspondiente a la jurisdicción asignada, deberá remitir a la municipalidad distrital o provincial el listado del consolidado de las viviendas renuentes.
- Una vez que la municipalidad recibe la relación de los propietarios o poseedores de casas o predios renuentes que no colaboran con las actividades sanitarias, este actúa de acuerdo a sus competencias y realiza la notificación respectiva (Acta de advertencia 1), donde señala la fecha de la próxima visita.
- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario o poseedor de la casa no accede a la intervención, entonces le corresponde al personal de la municipalidad oficiar a la Fiscalía de Prevención del Delito para que realicen una visita conjunta contra el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
- Seguidamente, la Fiscalía de Prevención del Delito realizará la visita de acuerdo a su competencia conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, el personal de salud y el personal de la municipalidad en la fecha y la hora programada.

- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario no accede a la intervención, el Fiscal actúa de acuerdo a sus competencias.
- En cualquiera de los casos, si la municipalidad ha emitido una ordenanza en el que especifica una penalidad a las viviendas que son potencial criaderos de zancudo y no abren las casas a la inspección y/o fumigación, esta penalidad corresponde ser aplicada por el área competente de la municipalidad.
- Para visualizar el proceso de intervención a las casas deshabitadas, cerradas y renuentes ver el Anexo 14.



OTRAS ENFERMEDADES METAXENICAS: CHIKUNGUNYA

"Las acciones, estrategias e intervenciones contenidas en el presente Documento Técnico podrían ser aplicables a otras enfermedades Metaxenicas, como el Chikungunya, considerando que –en ese caso- tienen en común el mismo vector transmisor (Aedes aegypti)".

VII. RESPONSABILIDADES

Las disposiciones contenidas en el presente Documento Técnico son de aplicación y adecuación obligatoria, en todo el sistema de salud.

Nivel Nacional

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Promoción de la Salud es responsable de difundir el presente documento técnico hasta el nivel regional; así como de brindar asistencia técnica, y supervisar su cumplimiento.

Nivel Regional

Las DIRESAS/GERESAS, a través de las Direcciones de Promoción de la Salud o la que haga sus veces en el ámbito regional, son responsables de difundir el presente Documento Técnico en su jurisdicción; así como de planificar, monitorear y evaluar su implementación. Asimismo, le corresponde fortalecer competencias en el personal de salud de redes y microrredes, brindar asistencia técnica para su implementación, y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el presente Documento Técnico.

Nivel Local

Los establecimientos de salud de redes y microrredes son responsables de implementar las acciones de promoción de la salud de acuerdo a lo establecido en el presente Documento Técnico.

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

VII. ANEXOS

Anexo 1: Modelo del oficio de designación de Equipo de Trabajo Dengue por el municipio, relacionado al cumplimiento Acta de Compromiso Intergubernamental para la intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud asociados al dengue de alcaldes de zonas endémicas 2013.

Anexo 2: Modelo del oficio de designación de Equipo de Trabajo Dengue por el Sector Salud, relacionado al cumplimiento del Acta de Compromiso Intergubernamental para la intervención sobre los determinantes sociales de la salud asociados al dengue de alcaldes de zonas endémicas 2013.

Anexo 3: Modelo de Resolución de Alcaldía para la conformación del Equipo de Trabajo Dengue.

Anexo 4: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el dengue en familias de los distritos.....

Anexo 5. Algunas formas de reconocimiento de estímulos no monetarios para voluntariado.

Anexo 6: Principales procesos desarrollados en el marco del concurso de identificación, recojo y eliminación de criaderos del zancudo *Aedes aegypti*.

Anexo 7: Matriz de descripción de actividades a corto plazo, propuestas para la eliminación de criaderos.

Anexo 8: Actividades de Promoción de la Salud según grupos objetivos para la prevención del dengue.

Anexo 9: Pasos generales que orientan la creación de proyectos de inversión pública (PIP) en la municipalidad.

Anexo 10: Cronograma de intervenciones a corto plazo, a realizar por los Gobiernos Locales para la prevención y control del dengue 201__.

Anexo 11: Modelo de oficio con informe anual de la municipalidad a la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces.

Anexo 12: Intervención integral de Promoción de la Salud para la prevención del dengue en el periodo sin brote.

Anexo 13. Cuadro de monitoreo diario de las actividades de Promoción de la Salud para el control y prevención del dengue.

Anexo 14: Mapa de procesos de Intervención, modelo de Acta y Oficio para el tema de casas cerradas, deshabitadas y renuentes.





ANEXO 1:

MODELO DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DENGUE POR EL MUNICIPO, RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ASOCIADOS AL DENGUE DE ALCALDES DE ZONAS ENDÉMICAS 2013.

OFICIO Nº -201

XXXXXXXXXX, XX de Abril del 201__

Señor (a)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Director (a)/Jefe de Red/Microred/Establecimiento de Salud

Presente.-

ASUNTO: **Designación de** Equipo de Trabajo Municipal - Dengue.
REF.: "Acta de compromiso de Alcaldes de Zonas Endémicas 2013".

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar la documentación que designa al **"EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL DENGUE"** que representará a la municipalidad distrital de xxxxxx, provincia de wwwwwww departamento de yyyyyyyy, conformado por:

- El Sr(a) xxxxx encargado de xxxxxx, como Coordinador del Equipo de Trabajo Dengue.
- El Sr(a). xxxxx encargado de Saneamiento Ambiental o el que haga sus veces.
- El Sr(a). xxxxx encargado de Imagen Institucional o el que haga sus veces.
- El Sr(a). xxxxx encargado de Participación Vecinal o el que haga sus veces.

Cabe mencionar, que la conformación del equipo de trabajo se ha realizado en el marco del Acta de Compromiso Intergubernamental para la Intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud Asociados al Dengue - 2013.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Nombre _____
Alcalde de la Municipalidad _____

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS MINSA

ANEXO 2:

MODELO DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO POR EL SECTOR SALUD, RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ASOCIADOS AL DENGUE DE ALCALDES DE ZONAS ENDÉMICAS 2013.

OFICIO Nº -201

XXXXXXXXXX, XX de Abril del 201____

Señor (a)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Alcalde de la Municipalidad de xxxxxxxx

Presente.-

ASUNTO: **Designación de** Equipo de Trabajo Dengue.
REF.: "Acta de compromiso de Alcaldes de Zonas Endémicas 2013".

ATENCIÓN: **Coordinador del Equipo de Trabajo – Dengue.**

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar la documentación que designa al **"EQUIPO DE TRABAJO DENGUE PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL DENGUE"** que representará al Sector Salud en la localidad de xxxxx, distrito de xxxxxx, provincia de wwwww departamento de xxxxxxxxx, conformado por:

- El Sr(a). xxxxx, Jefe de la Red / Microrred /Centro o Puesto de Salud que será el principal punto de contacto.
- El Sr(a). xxxxx, Responsable de las enfermedades metaxénicas o dengue de la Microrred /Centro o Puesto de Salud.
- El Sr(a).xxxxx, Responsable de Saneamiento Ambiental de la Microrred / Centro o Puesto de Salud.
- El Sr(a).xxxxx, Responsable de Epidemiología de la Microrred / Centro o Puesto de Salud.
- El Sr(a).xxxxx, Coordinador de Promoción de la Salud de la Microrred / Centro o Puesto de Salud.

Cabe mencionar, que la conformación del Equipo de Trabajo, se ha realizado en el marco del Acta de Compromiso Intergubernamental para la Intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud Asociados al Dengue - 2013.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

_____

Nombre _____

Jefe de la Red/ Microrred/ Establecimiento de Salud_____

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS MINSA

ANEXO 3:
MODELO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DENGUE

MUNICIPALIDAD XXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXX

RESOLUCION DE ALCALDIA N°*XXXXXXX*–201___

XXXXXXX, ___ de XXXXXXX del 201__.

El alcalde de la Municipalidad XXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXX

VISTO:

El acta de la sesión extraordinaria de consejo municipal de la municipalidad XXXXX de XXXX, de fecha __ de XXXXXXX del 201__, y estando los Oficios N° XXX -201__-XXXXX-X/XXXX (Municipio) y N° XXX -201__-XXXXX-X/XXXX (Salud), sobre la conformación de Equipo de Trabajo encargados de liderar las líneas de acción del plan de intervenciones para la prevención y control del dengue, en cumplimiento del Acta de Compromiso Intergubernamental para la Intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud Asociados al Dengue - 2013.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política del Perú concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su competencia; como tal en estricto cumplimiento del artículo 38 los Gobiernos Locales emiten Decretos, Resoluciones con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 192 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades tienen competencias para planificar el desarrollo de sus suscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes;

Que, asimismo el artículo 80 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que establece las funciones de salubridad y saneamiento encargadas a los municipios;

Que, es política institucional de este Gobierno Local, impulsada por la actual gestión gubernamental, el cumplir con los objetivos trazados, dentro de los plazos establecidos y conforme a los lineamientos de desarrollo integral de la provincia/distrito de XXXXX, así como del Acta de Compromiso Intergubernamental para la Intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud Asociados al Dengue – 2013;

Que, el precitado documento establece la necesidad de designar a los responsables e integrantes del Equipo de Trabajo Dengue;

En uso de las facultades conferida por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CONFORMAR el Equipo de Trabajo Dengue para el cumplimiento de las ***"Intervenciones de prevención del dengue"***, trazadas en el Acta de Compromiso Intergubernamental, de acuerdo a los criterios técnicos establecido por el Ministerio de Salud; el mismo que estará integrado por las siguientes personas:

Municipalidad XXXXXXX de XXXXXXX:

- XXXXXXXXXXXXXX — Coordinador (a) del Equipo de Trabajo Dengue
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Encargado de Saneamiento Ambiental o el que haga sus veces.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — Encargado de Imagen Institucional o el que haga sus veces.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — Encargado de Participación Vecinal o el que haga sus veces.

Red / Microrred / Establecimiento de Salud ó /Puesto de Salud de XXXXXXXXX:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Jefe de Red/ Microrred/Establecimiento de salud, que será el principal punto de contacto.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Responsable de las Enfermedades Metaxénicas o Dengue de la Red/ Microrred/ Establecimiento de Salud.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Responsable de Saneamiento Ambiental de la Red/ Microrred/Establecimiento.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Responsable de Epidemiología de la Red/ Microrred/Establecimiento de Salud.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Coordinador(a) Promoción de la Salud

ARTÍCULO 2°.- DISPONER el cumplimiento de la "Intervención integral en promoción de la salud para la prevención del dengue", que contribuirá a la reducción del Índice Aédico mediante la eliminación sistémica de criaderos del vector del dengue en zonas endémicas del país trazadas en el Acta de Compromiso Intergubernamental para la Intervención sobre los Determinantes Sociales de la Salud Asociados al Dengue - 2013, a través de las acciones del Equipo de Trabajo Dengue que al 31 de Diciembre del 201X deberá realizar las acciones y coordinaciones necesarias con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Acta; conforme a lo estipulado en el artículo 80 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en el Perú.

ARTÍCULO 3°.- PONER en conocimiento de esta designación de facultades a la DIRESA/GERESA/DISA/RED/MICRORED o la que haga sus veces y a los órganos administrativos municipales, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase

ALCALDE

Ministerio de Salud — Dir. de Promoción de la Salud — M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud — DPCS MINSA

ANEXO 4:

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL DENGUE EN FAMILIAS DE LOS DISTRITOS DE.....
JULIO 2013

PRESENTACIÓN DEL ENCUESTADOR

INTRODUCCIÓN: Mi nombre es _____, trabajo en la Dirección Regional de Salud de XXXX o Establecimiento de Salud de XXXXXXXX. Estamos encuestando a familias en la comunidad para conocer sobre sus conocimientos sobre el DENGUE. Nos gustaría que participes en este estudio, para esto necesito que nos des tu consentimiento. Por favor, escucha atentamente la información que te voy a leer a cerca de la encuesta para que me digas si estás de acuerdo en participar.

CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD: Te voy hacer algunas preguntas sobre tus conocimientos sobre el DENGUE, y tus respuestas serán completamente confidenciales. Te garantizamos, que la información suministrada no será usada con ningún fin diferente a los objetivos de este estudio. Agradeceremos tu ayuda al responder esta entrevista la cual tomará cerca de 20 minutos. ¿Deseas participar?

_____ _____

FIRMA DE ENCUESTADOR **FIRMA DE LA FAMILIA**

(CERTIFICADO QUE EL ENTREVISTADO HA DADO SU CONSENTIMIENTO VERBALMENTE)

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS MINSA

SECCIÓN I. DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A) ..... **DISTRITO** ..... **AA.HH.** ..... **SECTOR** ..... **DIRECCIÓN** ..... **ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE ACUDE:**	

No.	Preguntas	Categorías de codificación
P101	**REGISTRO DEL SEXO DEL ENTREVISTADO**	Masculino .....1 Femenino 2
P102	**EDAD**	_____ (Años)
P103	**GRADO DE INSTRUCCIÓN**	Sin instrucción.....1 Primaria incompleta.....2 Primaria completa.....3 Secundaria incompleta.....4 Secundaria completa.....5 Superior no universitario...6 Superior universitario.....7
P104	**ESTADO CIVIL**	Soltero(a) 1 Casado(a) 2 Conviviente 3 Separado/Divorciado 4 Viudo(a) 5
P105	**OCUPACIÓN**	Estudiante 1 Ama de casa 2 Comerciante 3 Empleado 4 Obrero 5 Oficios varios 6 Especifique_____
P106	**AFILIADO AL SIS**	SI 1 NO 2

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

SECCIÓN 2. CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL DENGUE

No.	Preguntas	Categorías de codificación			
P201	¿QUÉ ES EL DENGUE?	Una enfermedad.....			1
		Trasmitida por zancudo....			2
		Producida por virus.....			3
P202	¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS? SI : 1 NO : 2 NO SABE : 99	Fiebre	1	2	99
		Vómito	1	2	99
		Diarrea	1	2	99
		Dolor de cabeza	1	2	99
		Dolor de huesos	1	2	99
		Dolor de cuerpo	1	2	99
		Sangrado por nariz	1	2	99
		Sangrado en encías	1	2	99
		Erupción	1	2	99
		Desaliento	1	2	99
		Escalofrió	1	2	99
		Dolor de estómago	1	2	99
		Puntos rojos en la piel	1	2	99
		Malestar	1	2	99
		Sudoración	1	2	99
		Sangrado otros sitios	1	2	99
P203	¿QUÉ TAN GRAVE ES EL DENGUE?	Muy grave.....			1
		Medianamente grave.....			2
		Nada grave.....			3
P204	¿CÓMO SE TRANSMITE EL DENGUE?	Cuando me tose a la cara			1
		Cuando me pica un zancudo que pico a un enfermo.			2
		Otro especifique_____			3

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

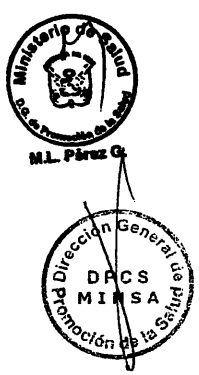
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

SECCIÓN 3. PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y TRATAR EL DENGUE

No.	Preguntas	Categorías de codificación
P301	**PARA EVITAR EL DENGUE (VERIFICAR EN LA CASA Y ALREDEDORES)**	Evita las aguas estancadas 1 Lava los depósitos de agua 2 Fumiga 3 Usa mosquitero 4 Mantiene limpia la casa 5 Recoge inservibles 6 Realiza otras actividades 7 Especifique_____ Ninguna medida 8
P302	**PARA EVITAR LA PICADURA DEL ZANCUDO (VERIFICAR EN LA CASA Y ALREDEDORES)**	Fumiga..... 1 Usa mosquitero..... 2 Mantiene limpia la casa..... 3 Evita las aguas estancadas... 4 Usa repelente..... 5 Realiza otras actividades..... 6 Especifique:..... Ninguna medida..... 7
P303	**EN CASO DE PERSONA CON DENGUE**	Consulta al médico/hospital/EE.SS... 1 Lo automédica..... 2 Lo cuida en casa..... 3 Consulta a la farmacia..... 4
P304	**MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL (VERIFICAR EN LA CASA Y ALREDEDORES)**	Destrucción/relleno de recipientes en desuso que puedan acumular agua..... 1 Tratamiento de criaderos mediante la protección de depósitos de agua..... ... 2 Eliminación de criaderos (Recolección de inservibles)..... 3 Prevención de picaduras de mosquitos mediante el uso de mosquiteros ... 4 Uso del mosquitero durante los primeros ochos días de la enfermedad..... 5 Uso de mallas de protección de puertas y ventanas ..... 6 Consulta oportuna en caso de complicación o de otro enfermo..... ... 7 Atención oportuna de casos febriles respectivamente..... ... 8 Uso de repelentes/ uso de ropa manga larga..... . 9
P305	**RECONOCIENDO LOS CRIADEROS (EN CASA Y ALREDEDORES)**	Llantas 1 Baldes, tinas, tanques bajos 2 Chapitas 3 Cáscara de coco, cacao 4 Botellas de plástico 5 Envases descartables (para bebidas, platos, vasos usados) 6 Bebedores de animales 7 Todo objeto que acumule agua 8 OTROS (especifique)_____ 9

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS MINSA

P306	**PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR CRIADERO (VERIFICAR EN LA CASA Y ALREDEDORES)** Fumigar..... 1 Lavar y escobillar el lavadero y recipientes donde almacena agua..... 2 Eliminar criaderos (objetos en desuso) en recojo de inservibles..... 3 Mantener recipientes en desuso sin agua / botar agua estancada..... 4
P307	**ACTIVIDADES DE CONTROL (VERIFICAR EN LA CASA ALREDEDORES)** Colocar mosquiteros..... 1 Eliminar focos del mosquito..... 2 Lavar el lavadero y recipientes.... 3 Fumigar..... 4 Evitar acumular agua..... 5 Usar la motita de (abate)..... 6 Mantener todo limpio..... 7
P308	**INFORMACIÓN RECIBIDA ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL** Establecimiento de salud 1 — Inspector sanitario 5 Amigos o vecinos 2 — Familia 6 Televisión 3 — Colegio 7 En las noticias 4 — Folletos 8



SECCIÓN 4. ACTITUDES Y PRÁCTICAS FRENTE A LAS MEDIDAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DEL DENGUE

No.	Preguntas	Categorías de codificación	
P401	**ACTITUD/PRÁCTICA** SI : 1 NO : 2	Asiste a reuniones de la comunidad	1
		Participa en actividades para prevenir el dengue	1
		Acuerda con vecinos la recolección de inservibles	1
		Educa a otros sobre las medidas de prevención	1
		Tiene posibilidades para realizar acciones de control	1
		Considera que sus sugerencias son escuchadas	1
		Lidera campañas para prevenir el dengue	1
		Consigue ayuda para programas de prevención	1
		Reclama acciones ante las autoridades	1

RESULTADO DE LA ENTREVISTA Completa.....	SI ☐ NO ☐	DÍA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐☐☐

CÓDIGOS DEL ENCUESTADOR Y SUPERVISOR

ENCUESTADOR (A)	SUPERVISOR (A)
☐☐	☐☐☐

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

INTRUCTIVO:
PARA EL LLENADO DE LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) SOBRE EL DENGUE

Esta encuesta está diseñada para facilitar el llenado del cuestionario CAP, dirigido a la población respecto al dengue en las zonas endémicas a nivel nacional.

Para el registro de las columnas y filas, deberá tener en cuenta las siguientes pautas, que a continuación se detallan:

- La encuesta se debe aplicar de manera individual y reservada, y en el idioma o lengua del encuestado; utilizando los términos que permitan entender con claridad el sentido de la pregunta.
- El encuestador deberá buscar la mayor comodidad y tranquilidad del encuestado.
- El encuestador debe explicar al encuestado el objetivo del cuestionario, y la importancia de su colaboración.
- Así mismo se debe recalcar que esta encuesta es reservada.
- La primera parte referente a la "PRESENTACIÓN" que debe ser dada por el encuestador al encuestado.
- La segunda parte referente al "CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD" de los datos o resultados obtenidos por el encuestador.
- La tercera parte referente a los "DATOS PERSONALES" del encuestado que debe ser llenada por el mismo.
- La cuarta parte correspondiente a "ENCUESTA POR SECCIONES" llenada por el encuestador, el que deberá hacer la pregunta al encuestado en los términos más comprensibles para él y sin apartarse del sentido de la pregunta.
- La quinta parte referente al "RESULTADO DE LA ENCUESTA".
- En caso que el encuestado solicite una explicación respecto a alguna pregunta, el encuestador deberá explicarla en los términos más adecuados, hasta que el encuestado lo entienda completamente.

PRIMERA PARTE : PRESENTACIÓN DE ENCUESTADOR O PRIMER CONTACTO CON EL ENCUESTADO

ENCUESTAR:
Es el proceso mediante el cual, la persona encargada de conducir la entrevista, es decir, de plantear las preguntas y de escuchar, y registrar las respuestas del encuestado; dispone de un contenido de frases comunes y comprensibles para explicarle los objetivos y finalidad de la encuesta e invitarlo a participar del estudio.

NOTA: La persona que encuesta y la persona encuestada no se conocen y una de las tareas principales debe ser: establecer un vínculo o relación amigable. La primera impresión que cause EL ENCUESTADOR a la persona que va a encuestar, influenciará en su deseo de cooperar con la encuesta. Cuando se presente, su apariencia debe ser apropiada y sus modales amistosos. Gane la confianza de las personas para que le proporcionen la información con soltura y veracidad.

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

SEGUNDA PARTE: CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD

En esta parte, se le pedirá al encuestado su consentimiento para realizar la encuesta con su firma; certificando que el encuestado a dado su autorización verbal y escrita voluntariamente para participar en la encuesta; es probable que en esta parte él o la encuestada se negará o dudará en responder a las preguntas, pidiendo que se le informe para qué van a ser usados estos datos. Explíquele, que la información que usted recopile de sus respuestas será completamente confidencial, que ningún nombre individual será utilizado para ningún propósito y que toda la información será usada en estadísticas, y no será usada con ningún fin diferente al del estudio. Por lo tanto, no debe mostrar cuestionarios, que ya han sido completados por otros encuestadores en frente del encuestado o encuestada, o cualquier otra persona.

TERCERA PARTE : ENCUESTA POR SECCIONES

La encuesta se divide en 4 secciones:

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES: CONTINUACIÓN DE LA FILIACIÓN DEL ENCUESTADO.
SECCIÓN 2. CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL DENGUE.
SECCIÓN 3. PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y TRATAR EL DENGUE.
SECCIÓN 4. ACTITUDES Y PRÁCTICAS FRENTE A LAS MEDIDAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DEL DENGUE.

Cada sección tiene sus números (N°), preguntas o enunciados diferentes; así como sus categorías de codificación.

En cuanto a la numeración codificada de la primera columna: se está describiendo en un orden correlativo la "P" como la pregunta a realizar; el N° de la sección y el N° de la pregunta actual a desarrollar. Por ejemplo: P201, este código se refiere a la Pregunta N° 1: ¿Qué es el dengue?, perteneciente a la Sección 2.

En cuanto a las categorías de codificación esta encuesta utiliza PREGUNTAS CON RESPUESTAS PRE-CODIFICADAS:

Estas son preguntas, respecto a las cuales, se conoce con antelación el tipo de respuesta que la persona encuestada puede dar. Las alternativas de respuesta y sus códigos respectivos están impresos en la encuesta; las cuales deben ser diligenciadas marcando con un círculo en las alternativas que han sido señaladas por el encuestador.
Ej. : En la Pregunta 4, de la Sección 2. La respuesta pre-codificada encerrada en un círculo es la "2".

P204	**¿COMO SE TRANSMITE EL DENGUE?**	Cuando me tose a la cara	1
		Cuando me pica un zancudo que pico a un enfermo.	(2)
		Otro especifique_____	3

Otro ejemplo: En la Pregunta 6, de la sección 2. La respuesta pre-codificada encerrada en un círculo es la "Sí".

P106	AFILIADO AL SIS	SI	(1)
		NO	2

Existe una alternativa al final de cada columna de "categoría de codificación":

Otros Especifique:..... (en este caso se llenará el espació con la respuesta descrita por el encuestado).

Ministerio de Salud
M.I. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPGS MINSA

CUARTA PARTE : DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

En esta parte, se registran los datos personales identificativos del individuo a encuestar, esto incluye:
- Nombre completo del encuestado,
- Distrito, AA.HH y/o Sector: Colocar el nombre del distrito, provincia y la comunidad (específica), en la que reside habitualmente el encuestado (en caso que resida en dos o más lugares, indicar en el que pasa más tiempo en el último año) y finalmente el dato del EE.SS. de su jurisdicción o aquel donde acude a atenderse con mayor frecuencia.

QUINTA PARTE: RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Aquí, se verá si la encuesta o entrevista ha sido culminada o no en su totalidad, marcando con una "X" en el recuadro a lado del **SÍ** (si la encuesta fue llenada completamente) o con una "X" en el recuadro a lado del **NO** (en caso de no estar terminada).

Por ejem: Completa ..... SI [X]

Adicionalmente, se colocará la fecha referida al día, mes y año en que se realizó la encuesta.

CÓDIGOS DEL ENCUESTADOR Y SUPERVISOR

En estos recuadros, según la realidad local y distribución de viviendas, tendrán un encuestador y supervisor con sus respectivos códigos, en relación a la sectorización elaborada, por ejemplo: Un encuestador distribuido por un número de manzanas y lotes.

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPOS
MINSA

TÉCNICA MUESTRAL

Se deberá aplicar, una técnica de muestreo para trabajar con información representativa que nos permita evaluar la efectividad de la intervención educativo comunicacional. Para ello se trabajará en base a las siguientes indicaciones técnicas:

- Diseño muestral: Estudio cualitativo por conglomerados (comunidades nativas).
- Marco poblacional: la población de las zonas de intervención entre 18 a 50 años.
- Población: Conocimientos, actitudes y prácticas de toda la población de las zonas de intervención mayores de 18 años.
- Unidad de análisis: poblador de la zona de intervención mayor de edad.
- Muestra: "N" pobladores de las comunidades de las zonas de intervención que sean mayores de edad.
- Recopilación de información: La información se recopilará de fuente primaria, mediante la técnica de encuesta aplicando un cuestionario con preguntas objetivas, de alternativas múltiples y semi cerradas.

Método:

Paso 1: Definir el universo marco poblacional.

Paso 2: Definir el tamaño muestral: en base a la prevalencia de casos, se determina un tamaño mínimo encuestas (N° estimado por estadística y epidemiología, según población) a nivel de toda la zona de intervención; el cual se deberá prorratear entre todas las comunidades que serán intervenidas.

Se podrá usar la siguiente formula:

$$n = \frac{N*Z*p*(1-p)}{(N-1)*e^2 + Z^2 * p*(1-p)}$$

Dónde:

n= El tamaño de la muestra que queremos calcular.
N= Tamaño del universo (p.e. 3 millones de personas entre 15 y 65 años).
Z= Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza. El valor más frecuente es el nivel de confianza 95% -> 1.96.
e= Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5% = 0.05).
p= Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general usaremos 50% = 0.5

Paso 3: Identificar la sectorización de cada comunidad y prorratear la cantidad de encuestas que le corresponde a cada comunidad, entre el número de viviendas, manzanas o lotes (o su equivalente).

Paso 4: Aleatoriamente identificar las viviendas, manzanas o lotes (o su equivalente) que serán intervenidas para la aplicación del número de encuestas que le corresponde. Z^2

Paso 5: Finalmente, se aplicará la encuesta a la persona mayor de edad, de la primera vivienda que se aborde al azar dentro del lote, manzana o su equivalente.

• Procesamiento de datos: Se elaborarán gráficas y tablas estadísticas para presentar los resultados.

Ministerio de Salud — M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud — DPCS MINSA

ANEXO 5

ALGUNAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULOS NO MONETARIOS PARA VOLUNTARIADO

RECONOCIMIENTO Y/O ESTÍMULOS NO MONETARIOS	PROPUESTAS DE MOMENTOS
1. Reconocimiento público y social acerca de la labor voluntaria de los ACS: ❖ Entrega de diploma/resolución o constancia a cargo de la autoridad municipal (cada seis meses o anual). ❖ Entrega de canastas de víveres con productos básicos de la zona.	▪ El Día del ACS. ▪ Celebración por Navidad.
2. Reconocimiento e incentivo para la labor voluntaria de los ACS: ❖ Dotación de materiales educativos comunicacionales básicos para educar a las familias: rotafolios, trípticos, papelotes u otros. ❖ Pasantías a experiencias de trabajo a localidades con intervenciones similares. ❖ Atención preferencial a los ACS para realizar los trámites en la Municipalidad.	▪ De acuerdo a la necesidad o la dinámica de trabajo comunitario. ▪ A demanda. ▪ A demanda.
3. Reconocimiento público y social acerca de la labor voluntaria de los ACS: ❖ Colocación de una placa movible en la puerta de la vivienda del ACS, para su reconocimiento como tal, de parte de la municipalidad y como punto de ubicación del Agente Comunitario de Salud dentro de la comunidad. ❖ Equipamiento del ACS: Gorra con visera, chaleco, botas, poncho impermeable, linterna, mochila y otros según amerite la realidad de cada localidad.	▪ Modelo de placa, de material de madera.  ▪ Anual.
4. Otras formas y/o tipos de reconocimiento e Incentivo NO MONETARIO que se puedan dar o hayan identificado en cada localidad.	

Fuente: Tomado de los criterios técnicos para el funcionamiento del CPVC

Ministerio de Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

ANEXO 6

PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL CONCURSO INTERESCOLAR DE IDENTIFICACIÓN, RECOJO Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DEL ZANCUDO *Aedes aegypti*

1. La DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microred/Establecimiento de salud o la que corresponda convocara a una reunión de coordinación con el Gobierno Local de la jurisdicción y con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), para establecer el cronograma de reuniones técnicas del concurso interescolar.
2. La UGEL emite invitación circular a directores de las instituciones educativas; para la capacitación a los docentes y la participación en la fecha establecida para el concurso interescolar.
3. Coordinación permanente (semanal) con la Municipalidad, la UGEL y DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microred/Establecimiento de salud o la que corresponda.
4. La UGEL elabora las bases del concurso, el cual es revisado por una de las instancias de salud y la Municipalidad correspondiente; que posteriormente lo publicará en su página web.
5. La Municipalidad y la DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microred/Establecimiento de salud o la que corresponda reproducen las "Hojas de Registro" y la respectiva "Hoja de Consolidado por Aula".
6. La DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microred/Establecimiento de salud o la que corresponda capacita a los docentes, en el uso de la "Hoja de Registro para la identificación de criaderos" y "El recojo de los objetos en desuso" (criaderos) (inservibles).
7. La UGEL distribuye las hojas de registro una (01) semana antes del concurso para la identificación de los criaderos.
8. El día del concurso, el representante de la municipalidad recoge y pesa los criaderos de las instituciones educativas; según cronograma establecido y firma una ficha de control de pesaje con el director de cada institución educativa concursante.
9. Asimismo, se recoge el consolidado por aula de la hoja de registro de cada institución educativa.
10. Posterior al concurso, la UGEL presenta los resultados obtenidos de las fichas de control del peso conseguido por cada institución educativa y una ficha de evaluación pedagógica; publicando en la página web de la UGEL los colegios ganadores.
11. Se programa la fecha de premiación con participación de las tres (03) instituciones: Municipio – DIRESA/GERESA/DISA/Red/Microred/Establecimiento de salud o la que corresponda – UGEL.

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

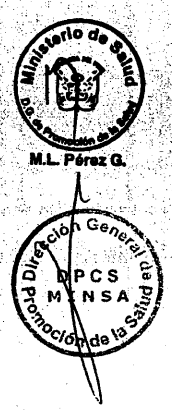
NOTA: Respecto a la reproducción de materiales comunicacionales y logística para el acto de premiación (premios, estrado, banner, entre otros), cada institución debe elaborar su plan de requerimiento de acuerdo a la distribución entre las instituciones participantes.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

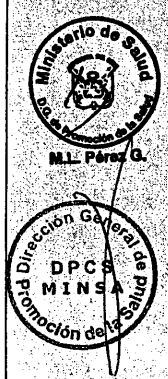
ANEXO 07

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CORTO PLAZO PROPUESTAS PARA LA ELIMINACIÓN DE CRIADEROS:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RECURSOS BÁSICOS	ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
1. Plan de Comunicación Social.	• Se debe elaborar un Plan de Comunicación Social en el primer mes, que considere las actividades a realizarse a lo largo del año (Abril – Diciembre 201_); el cual debe expresarse con mayor énfasis en el último trimestre. Los mensajes deben centrarse de manera principal en la eliminación de criaderos característicos de la zona. (Se debe pedir a la Dirección de Saneamiento Ambiental, que informe cuales son los criaderos de zancudo altamente potencial de la zona; para que se elaboren los mensajes enfatizando en la eliminación y manejo de esos criaderos, Ejemplo. Tanque alto, tanque bajo, ollas, recipientes donde almacenan el agua, escurridor de platos o cáscara de coco, llantas, entre otros). • El plan de Comunicación Social se establecerá en 2 fases: - **Primera Fase:** Elaboración del plan comunicacional, que contempla la elaboración, validación y/o reproducción de materiales educativo comunicacional de folletería (dípticos, trípticos, volantes, stickers, almanaques, gigantografías, carteles, murales, entre otros. Full color) y spots radiales y televisivos. Su ejecución será en los primeros meses (Abril – Mayo 201_). • **Segunda Fase:** Consistirá en la reproducción y difusión de los mensajes producidos en diferentes formas (material educativo impresos y audiovisuales)en los diferentes espacios de la comunidad del distrito, con énfasis en las zonas de alto riesgo. Asimismo, se difundirá los mensajes y se anunciará las campañas de recojo de potenciales criaderos (inservibles) mediante perifoneo. • Su ejecución será preferentemente en los siguientes meses del año (junio a diciembre y enero a marzo del siguiente año).	Plan de Comunicación elaborado = 1 anual. Ejecución de Plan de Comunicación = 1 Informe Trimestral.	• Recursos Humanos. • Piezas comunicacionales. • Reproducción y difusión de cuñas radiales, spot tv, afiches, gigantografías, stickers, almanaques, dípticos, trípticos, volantes, carteles, murales, entre otros. Con sus respectivas especificaciones técnicas). • Infraestructura: • Jornadas informativas (stands, estrados, toldos, entre otros). • Unidades móviles con equipo de perifoneo.	Para desarrollar las actividades de este Plan, se debe coordinar con las siguientes gerencias municipales: • Gerencia Municipal. • Gerencia de Desarrollo Social y Salud. • Abastecimiento y Adquisiciones, • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. • Gerencia de Imagen Institucional • y • Gerencia de Administración y Finanzas. Asimismo, se debe coordinar o realizar convenios con diferentes entidades: • Bancos. • Fábricas. • Cines. • Emisoras radiales.



	• Los materiales deben ser distribuidos a los actores sociales, líderes de su comunidad (presidentes de la JVC, o las que hagan sus veces, ACS y/o directores de II.EE., gerentes de entidades privadas (por ejemplo: bancos, fabricas, cines, emisoras radiales y canales de televisión local), medios alternativos, con la intención de que estos instrumentos puedan ser difundidos y socializados en todos los escenarios públicos. • Se debe identificar actores en el distrito que puedan apoyar reproduciendo los materiales educativo comunicacionales. Ej. Empresas, actores sociales, entre otros.			• Televisión local. • Otros medios alternativos.



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RECURSOS BÁSICOS	ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
2. Vigilancia Comunitaria	• Consiste en vigilar; es decir, cuidar, observar, estar alerta a lo que está pasando en la comunidad; en este caso está referida a todas las acciones que conlleven a evitar y controlar el dengue, debiendo realizar en forma permanente como una actividad regular con énfasis en las zonas de riesgo. • La vigilancia comunal puede ser realizado por un grupo conformado por inspectores municipales, ACS, autoridades y líderes comunales, con la asistencia técnica y acompañamiento del personal de salud de la Red/Microred/EE.SS., para ello se deben realizar las siguientes acciones: • Identificación de las zonas de alto riesgo a vigilar, para ello la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces/ Red/ Microred/ Establecimiento de salud coordinará con las áreas de Saneamiento Ambiental y de Epidemiología para que informe cuales son las localidades de alto riesgo del distrito y poder focalizar la intervención. • Se conformará el Comité de Vigilancia Comunitaria (en el mes de abril) en coordinación con la municipalidad, podrá ser integrado por los líderes comunales (JVC, OSB, ACS) y visitadores de vivienda, captados por el Área de Participación Vecinal de la Municipalidad, o se podrá trabajar con el grupo de la Municipalidad ya conformado para similar fin (Ej.: Encargado o Grupo responsable de ejecutar la meta del Plan de Incentivos (PI) del Ministerio del Ambiente: Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en un 12% de las viviendas urbanas del distrito). Por otro lado, los ACS de la localidad/barrio/sector del distrito, fortalecerá al grupo conformado para visitar a las familias. El personal de salud del establecimiento de salud debe asesorar al comité de vigilancia comunitaria. • La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, realizará dos (02) talleres de capacitación (mayo y junio), al grupo que visitará las viviendas de las	Captación de ACS. Ejecución de talleres de capacitación =2.	• Recursos Humanos. • Estímulos no monetarios: • Materiales de capacitación para sesión demostrativa. • Linternas. • Camets de identificación y chalecos. • Cuadernos de vigilancia.	• Líderes Comunales (JVC). • ACS. • La DIRESA/ GERESA/DISA o la que haga sus veces, brindará los talleres de capacitación al grupo que visitara las viviendas de las localidades de alto riesgo. • Participara las Gerencias o Subgerencias de la municipalidad que tienen equipo para

M.L. Pérez G.

DPCS MINSA

	localidades de alto riesgo. • Distribución de las zonas de riesgo por sectores priorizados a cada grupo para la ejecución de visitas a las viviendas. Se realizarán durante los siguientes meses del año: junio a diciembre y de enero a marzo del siguiente año. • El equipo que visite las casas, de las zonas de mayor riesgo; educarán en prácticas saludables y acompañarán en la identificación de criaderos y recojo de residuos sólidos para la eliminación de potenciales criaderos de zancudo. • Asimismo, el grupo de trabajo comunitario vigilará el entorno de las zonas en riesgo y alertará a las autoridades municipales de los espacios públicos, que sean potenciales criaderos de zancudos para su regulación o intervención según corresponda; tales como centros de acopio informales o lugares de reciclaje al aire libre. • Se sugiere, que para la conformación del grupo puedan convocar a voluntarios de universidades, institutos, entre otros. • Para efectos de motivar y estimular a los voluntarios y ACS que conforman el Comité de Vigilancia Comunitaria, se debe coordinar con el consejo municipal distrital/provincial, y plantear una propuesta para reconocimiento y/o estímulos no monetarios para los ACS, los cuales deben ser autorizados y otorgados en los meses de abril y diciembre. (Ver anexo 5).			visitar las familias de la zona.

Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RECURSOS BÁSICOS	ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
3. Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)	• La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, debe incidir, coordinar con la municipalidad para que se emita una Ordenanza Municipal que incorpore un cronograma de campañas masivas de eliminación de criaderos de zancudo (inservibles), durante el año. • La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces orientará en la organización de la campaña masiva de recolección de criaderos de zancudo al Gobierno Local en el marco del cumplimiento del artículo 80 de la Ley Orgánica de municipalidades para que este realice acciones que redunden en la salud de la población. Para ello se debe sugerir a la municipalidad coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, el Área de Participación Vecinal y con la participación de los actores sociales claves y de los diferentes sectores de su ámbito para realizar esta campaña de manera intensiva al menos dos (2) veces al año, de preferencia en el primer y cuarto trimestre del año (relacionado a periodos de lluvias); y debe servir para movilizar a la población y las instituciones públicas y privadas. • Asimismo, la DIRESA/GERESA o la que haga sus veces orientara a la municipalidad para que convoque finalmente, a todos los actores públicos y privados; para garantizar la mayor cobertura de las intervenciones en las campañas masivas de recolección y eliminación de inservibles, teniendo como aliados estratégicos a: a. Ministerio Público: para que autoricen y faciliten el ingreso de maquinaria y/o personas que realicen las recolecciones inservibles en casas o terrenos abandonados y que se han convertido en basurales y algunos con aniegos se han transformado en criaderos de zancudos. b. Ministerio de la Mujer y Beneficencia Pública: Para incidir en la no utilización de floreros con agua en los cementerios locales, los cuales son focos infecciosos y criaderos del zancudo *Aedes aegipty*. c. ONG: para la ayuda en la elaboración de materiales educativos y capacitaciones.	02 campañas al año: 1er y 4to trimestre.	• Recursos Humanos. • Camiones recolectores y camionetas. • Furgonetas. • Tractores. • Bolsas. • Guantes y mascarillas. • Combustible. • Materiales para sesiones demostrativas, designadas por la autoridad en salud o aliados estratégicos.	Para la ejecución de estas actividades se debe coordinar con las siguientes gerencias u oficinas municipales: • Gerencia Municipal. • Gerencia de Limpieza Pública o de Gestión Ambiental. • Gerencia de Desarrollo Social y Salud. • Abastecimiento y Adquisiciones. • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. • Gerencia de Imagen Institucional. Asimismo, para la ejecución de esta actividad se debe establecer aliados estratégicos intergubernamentales como: • Representantes regionales (DIRESA/ GERESA/DISA). • La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (GRVCS). • Gerencia Regional de Agricultura. • Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DGPS MINSA

	d. La empresa privada también debe participar apoyando con insumos, recursos, según sea el caso. e. La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (GRVCS) y Gerencia Regional de Agricultura dependiendo de su competencia apoyarán con recursos humanos o materiales. f. Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de la difusión y sensibilización a la población. • Tanto la Municipalidad, a través de sus gerencias u oficinas, conjuntamente con sus aliados estratégicos deben asegurar equipamiento necesario como disposición de: camiones recolectores, tractores y furgonetas con combustible y contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos; camionetas para transportar a los equipos; así como material de protección guantes, botas, mascarillas y bolsas. • Un punto crítico a tener en cuenta, y que debe ser controlado por el Gobierno Local en el marco de sus funciones, es la recolección y disposición final de los residuos sólidos e inservibles; para evitar el reciclaje y la exposición de los mismos al aire libre en los puntos de acumulación o acopio.			• Ministerio Público. • Ministerio de la Mujer. • Beneficencia Pública. • ONGs. • Otras instituciones de la zona.

Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RECURSOS BÁSICOS	ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
4. Recojo y procesamiento de residuos sólidos.	• La DIRESA/GERESA/DISA/RED/ Microred de salud incidirá sobre la importancia de la función de la municipalidad en mantener la regularidad y cumplimiento del servicio de recojo y procesamiento de residuos sólidos para evitar la acumulación de criaderos en las calles o puntos de acopio. • El programa selectivo de residuos sólidos, impulsado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), en el marco del Plan de Incentivo, fortalecerá esta actividad y contribuirá a disminuir los potenciales criaderos de zancudo en las viviendas. • De igual manera, para esta actividad se incidirá con el Gobierno Local para que prevea la disposición adecuada de volquetes o camiones recolectores con combustible; y contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos y así asegurar diariamente el servicio público de recojo de residuos sólidos. • En caso, de no contar con la maquinaria pesada; la municipalidad puede coordinar intergubernamentalmente con la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Gerencia Regional de Obras e Infraestructura.	Plan de recojo y eliminación de residuos sólidos = 01. Ejecución de plan de recojo y eliminación = 01 informe mensual.	• Recurso Humano :personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos. • Camiones Recolectores. • Disposición adecuada de Volquetes con combustible. • Escobas. • Bolsas.	Para esta actividad el Gobierno Local debe coordinar institucionalmente con sus gerencias u oficinas municipales de: • Gerencia de Salud y Limpieza Pública. • Gerencia de Gestión Ambiental. • Gerencia Municipal. Y Gerencias Regionales de: • Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. • Gerencia Regional de Obras e Infraestructura.

Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RECURSOS BÁSICOS	ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
5. Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)	• Son actividades focalizadas que buscan intervenir espacios públicos y privados para el recojo y la eliminación de criaderos. • Esta actividad se debe realizar cuatro (04) veces al año: dos (2) campañas con centros laborales y dos (2) campañas con II.EE. (primaria, secundaria y superior), recomendándose realizarlas en el último semestre del año (septiembre a diciembre), específicamente; coincidiendo con la culminación del año académico, la estación primaveral y el comienzo de vacaciones e inicio de las lluvias y el verano. • A continuación, se indican las acciones a seguir tanto en la II.EE. como en los centros laborales. • La tarea en la II.EE, consiste en movilizar a los alumnos para que limpien las escuelas y recojan los inservibles dentro y fuera de ellas. • Asimismo, pueden realizar concursos interescolares para que los alumnos lleven de sus casas los inservibles (potenciales criaderos del zancudo), hacia un sitio de acopio preferentemente fuera de la II.EE; desde ese punto la Municipalidad en coordinación con la II.EE. los pesa, recoja y elimina. La II.EE ganadora será la que acopie mayor tonelada de potenciales criaderos. • A nivel de centros laborales, la DIRESA/GERESA/DISA/RED orientará y acompañará a la Municipalidad para que coordine con los inspectores de las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo para definir la fecha, en la cual todos los centros laborales en simultáneo; realicen el recojo de potenciales criaderos de zancudo (inservibles) de su centro laboral y la Municipalidad debe garantizar el recojo y eliminación de los mismos. Para ello, evitando paralizar las actividades, un grupo de trabajadores serán designados en la fecha para el recojo y eliminación de criaderos de zancudo y acopien en un lugar predeterminado, este grupo de trabajadores serán previamente capacitados por la autoridad sanitaria regional.	4 campañas al año: 2 con centros laborales y 2 con II.EE. (eliminación de criaderos)	• Recursos Humanos contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos. • Bolsas. • Disponer de: • Camiones o volquetes recolectores con combustible.	• Para esta actividad, habrá una coordinación entre la Autoridad Sanitaria Regional, Gobiemo Local, DREL, UGEL, y Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. debe coordinar. • Gerencia de Salud y Limpieza Pública de la municipalidad. • Gerencia de Gestión Ambiental. • IIEE primaria y secundaria. • La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación o las que hagan sus veces a nivel de Gobierno Regional y Local o las que hagan sus veces. • Así como los empresarios de los relevantes centros laborales. • En la Municipalidad con la Gerencia Regional de Vivienda, Trabajo Construcción y Saneamiento.

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

	• Para esta actividad el Gobierno Local debe disponer de camiones o volquetes recolectores con combustible y contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos. • Las Gerencias de Educación Municipal y Regional; así como las Gerencias Regionales de Trabajo, del Medio Ambiente y la de Vivienda, Construcción y Saneamiento: pueden premiar a la II.EE. o centros laborales que realicen una adecuada labor de recolección de inservibles en su comunidad.			

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPOS
MINSA

ANEXO 8

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEGÚN GRUPOS OBJETIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE

Se recomienda, desarrollar actividades de promoción de la salud según cinco (05) grupos objetivos de trabajo para la prevención del dengue, organizados de la siguiente manera:

1. Personal de Salud de la DIRESA/GERESA/DISA, RED, Microrred y Establecimientos de Salud.
2. Autoridades regionales y locales.
3. Sector Educación.
4. Organizaciones Sociales de Base (OSB), Agentes Comunitarios de Salud (ACS) y población general.
5. Sector privado y centros laborales.

A continuación desarrollamos las actividades recomendadas para cada grupo:

1. PERSONAL DE SALUD

Las actividades a ser realizadas por el Equipo de Gestión de la DIRESA/GERESA/DISA o las que haga sus veces, son las siguientes:

a) Los equipos técnicos de promoción de la salud de las DIRESAs/GERESAs/DISAs o la que hagan sus veces, que estén en zonas endémicas de dengue deben elaborar y aprobar un plan anual de actividades de prevención del dengue o Plan EGI Dengue en su jurisdicción; en el marco de las disposiciones técnicas de la autoridad sanitaria nacional y promover la conformación mediante Resolución Directoral, de un equipo permanente de gestión para la prevención del dengue, a nivel de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces y de cada Red de Salud de su jurisdicción integrado por todas las áreas técnicas de salud; el que tendrá como responsable a la Estrategia Sanitaria Regional de Metaxénicas de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas o la que haga sus veces y como Secretario Técnico, al responsable de Promoción de la Salud a nivel regional y a sus equivalentes a nivel de cada Red de salud de su jurisdicción.

b) Dichos equipos permanentes deberán mantener reuniones mensuales en su nivel correspondiente, para monitorear y analizar el cumplimiento del plan anual de prevención del dengue o la que haga sus veces (Plan EGI Dengue) en su jurisdicción. Trimestralmente la reunión será conjunta entre la DIRESA/GERESA/DISA o la que hagan sus veces y sus redes para hacer una evaluación de su cumplimiento. En caso, no se constituya el equipo permanente, el Director Ejecutivo de Promoción de la Salud o el que haga sus veces deberá conformar un Equipo de Gestión de Promoción de la Salud; con la función de monitorear el cumplimento del plan de actividades y hacer incidencia sobre la autoridad sanitaria regional.

c) El equipo regional y de las redes de promoción de la salud deben organizar al menos dos veces al año, reuniones de capacitación y sensibilización para responsables y personal de redes, microredes y establecimientos del primer nivel de atención; sobre la promoción de prácticas saludables y acciones de prevención frente al dengue mediante la promoción de prácticas claves; que permitan disminuir el riesgo de enfermar por dengue. En dichas reuniones, se deberá incidir sobre la importancia del abordaje de los determinantes sociales vinculados al dengue; y brindar las pautas técnicas para la organización del trabajo comunitario y de educación sanitaria a la población.

d) Asimismo, deben organizar al menos dos veces al año reuniones de sensibilización con actores sociales como gobiernos locales, autoridades sectoriales, sociedad civil y organizaciones sociales, líderes comunales y sector privado entre otros con quienes se deberá incidir sobre la importancia del abordaje de los determinantes sociales vinculados al dengue y la participación social para la prevención y control del dengue.

e) La DIRESA/GERESA/DISA o la que hagan sus veces deben capacitar al personal de salud en estrategias de comunicación social; bajo el enfoque de la interculturalidad en la salud local.

f) También, deben realizar la adecuación del material educativo comunicacional y las redes garanticen la disponibilidad de material educativo comunicacional; así como establecer las estrategias de menor costo efectivas para informar a la población sobre las practicas saludables de protección personal y de la vivienda; así como el manejo adecuado de potenciales criaderos y almacenamiento de agua intra y peri domiciliaria, y otras medidas de prevención y control del dengue.

g) Orientar al gobierno regional y gobiernos locales según corresponda, en las acciones de educación sanitaria, difusión de medidas de protección, campañas de recojo de criaderos, vigilancia del cumplimiento de prácticas y mejoramiento de entornos, que contribuyan a la disminución de riesgos de aparición de brotes de dengue.

h) Convocar a los prestadores de servicios del Sector Salud (EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, otros establecimientos de salud públicos y privados, Hospital de la Solidaridad) para coordinar acciones conjuntas desde la organización del trabajo comunitario, capacitación del personal y difusión de mensajes preventivos a la población.

i) Orientar a los equipos de salud local y a la Junta Vecinal Comunal (JVC), en la conformación o fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Comunitaria con participación activa del ACS; para identificar los riesgos en el entorno y vigilar el cumplimiento de prácticas saludables por la población.

j) Promover la elección y formación de nuevos voluntarios (ACS) en las localidades afectadas y fortalecimiento de los existentes.

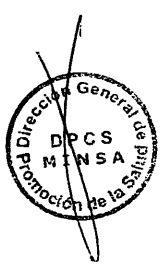
Los jefes de establecimientos de salud, microredes y redes serán responsables de realizar las siguientes actividades a nivel local:

k) Programar y realizar actividades educativas y comunicacionales durante todo el año; orientadas a promover las prácticas saludables y acciones de prevención frente al dengue dirigidas a la población en general.

l) Realizar por lo menos dos (2) veces al año, reuniones de información y capacitación con todo el personal de salud al interior de cada establecimiento, las que deberán ser programadas, de preferencia en los días de baja demanda de pacientes y así evitar perjudicar la atención de los servicios de salud. En dichas reuniones, se debe enfatizar la importancia del abordaje de los determinantes sociales para la prevención del dengue.



m) Fortalecer las competencias del personal de salud (técnico y profesional) para mejorar el trabajo y coordinación con los ACS, y otras formas de voluntariado en su rol educador como agente de cambio frente al dengue.



n) Coordinar la programación de actividades con cada II.EE. de la jurisdicción para las acciones de capacitación sobre las medidas de prevención y control del dengue; así como las jornadas de limpieza, identificación, eliminación y tratamiento de criaderos al interior y en la periferia de las mismas; dirigidas y asumidas por la comunidad educativa (docentes, padres de familia y alumnos), según corresponda.

o) Programar y ejecutar actividades educativas y demostrativas con OSB (vaso de leche, comedores, entre otros.) y diversos conglomerados poblacionales, en los que se difundan el correcto procedimiento de limpieza de recipientes y el correcto mantenimiento y conservación del agua; entre otras prácticas recomendadas por la autoridad sanitaria para la prevención del dengue.

2. AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

Las actividades, a ser realizadas por el Equipo de Gestión de la DIRESA/GERESA/DISA o las que haga sus veces, son las siguientes:

a) Elaborar y mantener un directorio actualizado de autoridades regionales, alcaldes distritales y provinciales; y otras autoridades del sector público y privado; y sociedad civil de su jurisdicción, según nivel que corresponda.

b) Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, quienes deben asumir el rol de liderar y conducir el proceso político y social para la prevención y control del dengue a nivel regional y local, según corresponda; apoyándose en la asesoría técnica de la autoridad sanitaria del nivel correspondiente; quien debe retroalimentar resultados de impacto de las intervenciones, para lo cual debe establecer coordinaciones y mecanismos de comunicación periódica con las diferentes autoridades.

c) Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, quienes deben convocar reuniones periódicas informativas, de coordinación y monitoreo a todos los actores sociales; acerca de las actividades que se vienen realizando para la prevención y control del dengue con el apoyo técnico de la autoridad sanitaria regional o local.

d) Difundir los mensajes claves contenidos en los materiales educativos comunicacionales y cartillas informativas elaboradas por la autoridad sanitaria, a través de los medios de comunicación local de su jurisdicción; y hacer las coordinaciones para el apoyo de otras instituciones y organizaciones comunitarias que tengan recursos para realizar acciones de difusión.

El personal de salud a nivel de DIRESA/GERESA/DISA / Redes y microrredes, deberá promover que los gobiernos locales asuman las siguientes actividades:

e) Emitir políticas públicas (ordenanzas) distritales o provinciales, en relación a la prevención y control del dengue tomando como referencia la propuesta que elabore la autoridad sanitaria regional o local.

f) Instalar o reactivar la mesa multisectorial de salud o su equivalente, bajo su liderazgo político y colocar en agenda el tema de prevención del dengue, para establecer los mecanismos de implementación de las ordenanzas relacionadas a la prevención y control del dengue.

g) Poner a disposición del personal de salud, el Serenazgo para que acompañe en la vigilancia comunitaria y perifoneé los mensajes educativo comunicacionales proporcionados por la autoridad sanitaria regional, en las localidades de alto riesgo.



h) Convocar a las organizaciones de sociedad civil, JVC, OSB y otras formas de organización comunitaria (clubes, grupos parroquiales, entre otros.) a reuniones informativas y de capacitación para implementar las medidas de prevención y control del dengue a ser brindadas por la autoridad sanitaria regional.



i) Movilizar recursos humanos de su dependencia (agentes municipales, líderes comunales, inspector y policía municipal, y otros.) para sumarse al comité de vigilancia comunitaria y a las campañas de educación y comunicación social dirigidas a la población con mensajes referidas a la prevención del dengue.

j) Organizar con el apoyo de la autoridad sanitaria regional y otros sectores; campañas generales y selectivas de recojo y eliminación de criaderos (inservibles).

k) Programar intervenciones para eliminar y tratar los potenciales criaderos en los mercados, cementerios y otros lugares públicos; así como educar a los propietarios y usuarios sobre las medidas preventivas para evitar el dengue.

l) Regular y promover el funcionamiento de empresas recicladoras y aquellas que tienen riesgo de manipular potenciales criaderos; con la finalidad que tengan un manejo adecuado de los mismos.

m) Difundir mensajes preventivos y de protección a la población, a través de los mediante los medios de comunicación masiva de su jurisdicción (radios municipales, emisoras radiales privadas, diarios locales, y otros).

3. SECTOR EDUCACIÓN

Las actividades a ser realizadas por el Equipo de Gestión de la DIRESA/GERESA/DISA o las que haga sus veces, son las siguientes:

a) Realizar reuniones de coordinación con las autoridades regionales de educación, incluidas las UGEL para emitir o implementar las directivas relacionadas a las acciones del dengue, en el marco de la RM N° 0493-2012-ED que aprueba: la "Norma para orientar la organización y desarrollo de las actividades de educación preventiva, mitigación y respuesta ante el dengue en las II.EE. públicas y privadas del país".

b) Realizar acciones de incidencia con las autoridades educativas pertinentes, a fin de que incluyan en el contenido curricular referido a las prácticas y entornos saludables; y acciones preventivas frente al dengue, así como la incorporación en el presupuesto institucional de educación, la adquisición del material educativo comunicacional necesario para la realización de las sesiones educativas y demostrativas a los alumnos.

c) Organizar en coordinación con las UGEL y los gobiernos locales, por lo menos dos (02) veces al año el: "Concurso Interescolar de eliminación de criaderos del zancudo que transmite el dengue"; orientado a la eliminación selectiva de criaderos intradomiciliarios de los estudiantes y en la comunidad de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por la autoridad sanitaria nacional.

d) Elaborar, en coordinación con las autoridades del Sector Educación, previo al inicio del año lectivo, un Cronograma de capacitación a los docentes de su jurisdicción, para la implementación de prácticas saludables y medidas de prevención frente al dengue en la institución educativa y en el hogar.

El personal de salud a nivel de DIRESA/GERESA/DISA/Redes y microrredes realizará las siguientes actividades a nivel local (Redes y microredes):

e) Ejecutar el cronograma de sesiones educativas y demostrativas a docentes, utilizando material educativo (lavado y mantenimiento de recipientes que almacenan agua, uso de arena húmeda en floreros en lugar de agua).

f) Elaborar y ejecutar en coordinación con la autoridad educativa correspondiente, un cronograma de reuniones informativas referidas a las prácticas saludables y medidas de prevención frente al dengue; dirigidas a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), comités de aula, comités de grado y padres de familia en general; por cada institución educativa de su jurisdicción.

g) Coordinar con los directores de las II.EE., la publicación de material informativo validado sobre las acciones de prevención del dengue (paneles, murales, letreros, etc.) en sus instalaciones; por lo menos durante el periodo de riesgo. Asimismo, la realización de actividades educativas dirigidas a los expendedores de los quioscos sobre eliminación de potenciales criaderos de zancudos, higiene y manipulación de los alimentos, e higiene del ambiente del quiosco.

Ministerio de Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPOS
MINSA

h) Incidir en las II.EE de las zonas de mayor riesgo para que impulsen la implementación de los rincones de aseo (dotación de jabón y agua, papel toalla, la limpieza, malla en las ventanas y ventilación adecuada) y las jornadas de eliminación de criaderos potenciales dentro y alrededor de las II.EE.

i) Promover la formación de Vigías Escolares en las II.EE., para prevenir el dengue en los domicilios y la comunidad.

j) Elaborar y monitorear conjuntamente con las II.EE., un cronograma de capacitación de réplica del docente a alumnos, acerca de las prácticas saludables para la prevención y control del dengue.

4. ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (OSB), AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD (ACS) Y POBLACION GENERAL

Las actividades, a ser realizadas por el Equipo de Gestión de la DIRESA, GERESA o las que hagan sus veces, son las siguientes:

a) Actualizar el directorio de las JVC y todas las OSB, que existen en la comunidad ubicadas en zonas de riesgo para dengue.

b) Actualizar anualmente, la base de datos de registro de los ACS de las zonas de riesgo para dengue; y capacitarlos por lo menos dos veces al año, con respecto al uso de metodologías educativas para educación en adultos y los principales mensajes de salud que deben emplear para la prevención del dengue, de acuerdo a la realidad local.

c) Gestionar ante las autoridades regionales, locales y sector privado la implementación y equipamiento de un kit básico para los ACS; a fin que realicen las actividades educativas comunicacionales, en las comunidades ubicadas en zonas de riesgo para el dengue, de acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria.

d) Implementar o fortalecer, el Comité de Vigilancia Comunitaria para la vigilancia del cumplimiento de prácticas saludables de las familias y la identificación y notificación oportuna a la autoridad sanitaria, de los factores de riesgo de dengue en la comunidad; debiendo incluir a las OSB, JVC, programas sociales y la comunidad educativa dentro del sistema de vigilancia.

El personal de salud a nivel de DIRESA/GERESA/DISA/ Redes y microrredes realizará las siguientes actividades a nivel local (Redes y microredes):

f) Informar y capacitar a las organizaciones de sociedad civil, JVC, OSB y otras formas de organización comunitaria (clubes, grupos parroquiales, entre otros.), convocados por la autoridad municipal de su jurisdicción, acerca de la implementación de las medidas de prevención y control del dengue, que incluya las sesiones demostrativas de limpieza de recipientes y conservación del agua para evitar la proliferación de potenciales criaderos de dengue, por lo menos dos veces al año.

g) Establecer un mecanismo y flujograma de comunicación para la autoridad sanitaria regional, respecto a la información generada por el sistema de vigilancia comunitaria sobre los factores de riesgo del dengue.

h) Realizar reuniones de monitoreo de las acciones del Comité de Vigilancia Comunitaria por lo menos tres veces al año, para su respectiva retroalimentación y asistencia técnica.

i) Orientar en la elaboración de un cronograma de micro jornadas (sectores, barrios, y otros.) de difusión de información, limpieza y eliminación de criaderos de zancudo, por

lo menos tres veces al año a cargo de las JVC y OSB, y otras organizaciones comunitarias (clubes, grupos parroquiales, entre otros.) en sus zonas de influencia o residencia.

j) Llevar a cabo reuniones de monitoreo de actividades programadas con las organizaciones de sociedad civil, OSB y programas sociales, no menos de cuatro (04) reuniones anuales.

k) Elaborar un informe anual de las actividades realizadas con los diferentes actores de de la comunidad e informar a la autoridad sanitaria correspondiente y retroalimentar a los diferentes actores de la comunidad participantes.

5. SECTOR PRIVADO Y CENTROS LABORALES

Las actividades, a ser realizadas por el Equipo de Gestión de la Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud o las que hagan sus veces, son las siguientes:

a) Elaborar y actualizar anualmente, el directorio de empresas e instituciones del sector público y privado; especialmente de las farmacias y boticas, y los diferentes medios de comunicación, que tengan influencia en las zonas en riesgo para dengue.

b) Reunirse por lo menos, dos veces al año con las empresas privadas (buses de transporte interprovincial, empresas de transporte local, agencias financieras, cines, mega plazas, centros comerciales, clubes deportivos, restaurantes y ferias gastronómicas, y otros.) con la finalidad de comprometer su participación; en la difusión de los mensajes educativo comunicacionales para la prevención del dengue, entre sus usuarios y población en general, mediante el uso de diversas formas de publicidad.

c) Comprometer a las empresas del sector privado, especialmente a las farmacias y boticas, prestadores de salud del sector privado y medios de comunicación para la difusión del teléfono de INFOSALUD: 0 800-108-28, entre sus usuarios.

El personal de salud a nivel de DIRESA/GERESA/DISA/ Redes y microrredes realizará las siguientes actividades a nivel local (redes y microredes):

d) Programar reuniones individuales con los propietarios de empresas privadas, bodegas, mercados, centros de abasto, tiendas de expendio de alimentos, entre otros, para comprometer la reproducción e instalación en sus ambientes, de material educativo comunicacional adicional al proporcionado por la autoridad sanitaria regional, dirigido a sus trabajadores y sus clientes.

e) Programar en coordinación con los propietarios o representantes de empresas públicas y privadas, de las zonas de riesgo de dengue; la realización de sesiones educativas y demostrativas dirigidas a sus trabajadores para conocer las prácticas, que deben desarrollar para la prevención del dengue, por lo menos dos veces al año.

f) Organizar campañas de recojo, tratamiento y eliminación de potenciales criaderos (inservibles), dentro y alrededor de los centros laborales; en coordinación con los inspectores de trabajo, el municipio y la autoridad sanitaria y con la activa participación de los trabajadores, jornadas que se recomienda realizar por lo menos tres veces al año.

g) Para efectos de las intervenciones recomendadas, las II.EE. también deben ser consideradas al igual que los centros laborales.

ANEXO 9

PASOS GENERALES QUE ORIENTAN LA CREACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) EN LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CON UNIDAD FORMULADORA

1. Área o Gerencia de Salud identifica un problema, por ejemplo de saneamiento básico, en la una localidad de su distrito y ***emite informe*** **al Alcalde.**
2. **Alcalde prioriza este problema,** y **envía informe** a su **Gerencia Municipal.**
3. Esta gerencia, a su vez **solicita ejecutar una obra** que **mejore el saneamiento básico,** por ejemplo: para brindar agua potable a la comuna en su casa las 24 horas del día.
4. Gerencia de Obras, recepciona el pedido y **fórmula el perfil del proyecto** para luego derivarlo a su **"Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública (UFPIP)"**

***Nota**:

- Si la Gerencia de Obras, no tuviera Unidad Formuladora, puede derivarlo a otras gerencias que si cuentan con una, por ejemplo la Gerencia de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, etc.

5. En esta unidad (UFPIP):
   - Formula el Plan de Trabajo, para formular el **Perfil de Proyecto.**
   - Realizar el **taller de involucrados** donde se presenta el proyecto, sometiéndose a observaciones por parte de los involucrados (Juntas de agua Potable y Saneamiento (JAS), miembros y autoridades de la comunidad). De igual modo, se debe contar con representantes de la Unidad Formuladora para brindar asesoramiento a las inquietudes de la población participante del taller.
   - Luego de este evento, nuestro plan **se inscribe al banco de proyectos** del Sistema Nacional de Proyectos **(SNIP) – MEF,** para la **asignación de código** SNIP.
6. Después, el proyecto **pasa a la OPI** que es una oficina adscrita a la Unidad Ejecutora del PIP, donde se levantan las observaciones y se evalúa la viabilidad del proyecto.
7. Posteriormente, declarado viable el **"Proyecto" se elabora el expediente técnico o estudio definitivo,** siendo realizado por la Gerencia de Obras o Unidad de Infraestructura y/o a través de una licitación, donde se contrata a una unidad formuladora externa.
8. Una vez terminado el estudio definitivo con **viabilidad y presupuesto;** finalmente retorna a la Gerencia Municipal, donde a su vez se informa al Alcalde; se **expide la resolución** correspondiente y se **empieza a ejecutar la obra** de acuerdo al PIP gestionado.

MUNICIPALIDAD SIN UNIDAD FORMULADORA

1. Área o Gerencia de Salud, identifica un problema de saneamiento básico en la una localidad de su distrito y ***emite informe*** **al Alcalde.**
2. **Alcalde prioriza este problema,** y **envía informe** a su **Gerencia Municipal,**
3. Esta gerencia, a su vez **solicita ejecutar una obra** que **mejore el saneamiento básico,** por ejemplo: para brindar agua potable a la comuna en su casa las 24 horas del día.
4. En este caso, el Gobierno Local Distrital crea un convenio con otro municipio vecino, que si tenga Unidad Formuladora y OPI para la elaboración de sus proyectos, y sus posteriores evaluaciones (del PIP).
5. También puede solicitar el apoyo a la Unidad Formuladora y OPI, del Municipio Provincial de la jurisdicción.

***Nota**:

- Algunos municipios distritales y provinciales no contarán con esta oficina. Si su gobierno local, tuviera este último caso, puede acudir a la Unidad Formuladora del Gobierno Regional, donde será gestionado su proyecto; teniendo necesariamente que solicitar asesoramiento por parte del equipo regional y/o contratar a un formulador, para acceder a esta instancia.

OBSERVACIONES

Los PIP, se deben elaborar en una forma más simple de lo que actualmente se realizan; debiéndose orientar en poner un mayor énfasis en la identificación del problema, en la descripción de las actividades, componentes y obtención del presupuesto para su implementación.





ANEXO10: CRONOGRAMAS DE INTERVENCIONES A CORTO PLAZO, PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DENGUE 201___.

I. Líneas de Intervención Generales

Resultado: Reducción de los niveles de infestación aédica (zancudos) a menos del 2%, en las localidades intervenidas mediante la ejecución intensiva y permanente de actividades de eliminación de criaderos intra y peri domiciliarios, en el período de abril a diciembre del 201__.

Plan de trabajo	Tarea	201X			Línea basal Año 201X									Línea control 201X	Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	
Implementar acciones conjuntamente con el Gobierno Local, para la prevención y control del dengue.	• Línea basal: 1) Encuestas CAP 2) Medición de IA/IB				X										La DIRESA/GERESA/ DISA /RED.
	1. Plan de Comunicación Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Municipio distrital, provincial.
	2. Vigilancia Comunitaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3. Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)				X						X	X	X		La DIRESA/GERESA/ DISA o la que haga sus veces (PROMSA, DEPI, DESA) o RED/MICRORED de cada localidad, en coordinación con la autoridad municipal, así como con representantes de las Gerencias regionales de Educación, Vivienda, Ambiente y Agricultura, Trabajo y otros aliados estratégicos de la localidad.
	4. Recojo y procesamiento de residuos sólidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	5. Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)									X	X	X	X		
	• Monitoreo de las acciones							X			X				
	• Línea control: 1) Encuestas CAP 2) Medición de IA/IB												X		
	• Evaluación e informe anual.													X	

M.L. Pérez G.

II. Líneas de intervención específicas

A. Descripción de intervención propuesta 2.1: Plan de Comunicación Social

Resultado: Las familias de su localidad asumen comportamientos y actitudes protectoras frente al dengue y eliminan criaderos de zancudos de sus viviendas (con la difusión realizada, las familias informadas sacan sus inservibles a puntos de acopio).

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Plan de Comunicación Social	Elaboración de un Plan de Comunicación Social anual, el cual debe expresarse con mayor énfasis en el último trimestre. Y se establecerá en dos (2) fases:											X	X	El representantes de Promoción de la Salud (PROMSA) y Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o RED de salud de cada Región, coordinara con el área de Imagen Institucional del Municipio distrital o provincial, miembro del equipo de trabajo dengue.
	Primera Fase: Elaboración, validación y reproducción de material educativo comunicacional (dípticos, trípticos, volantes, stickers, almanaques, gigantografías, carteles, murales, y otros. Full color.) y spots radiales y televisivos.				X	X								
	Coordinación con los gobiernos locales para la validación y reproducción de material educativo comunicacional.				X	X								

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Plan de Comunicación social	• **Segunda Fase:** Consistirá en la reproducción y difusión de los mensajes producidos a través de diversos materiales educativo comunicacionales (folletería, dípticos, audio, spot tv, entre otros.) en los diferentes espacios de la comunidad del distrito, con énfasis en las zonas de alto riesgo. • Asimismo, se difundirá los mensajes y se anunciará las campañas de recojo de inservibles, mediante perifoneo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El representantes de Promoción de la Salud (PROMSA) y Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o RED de salud de cada Región, coordinara con el área de Imagen Institucional del Municipio Distrital o provincial, miembro del equipo de trabajo dengue.
	• Los materiales deben ser distribuidos a los actores sociales, líderes de su comunidad (alcaldes vecinales, presidentes de JUVES, ACS y/o directores de II.EE.), gerentes de entidades privadas (por ejemplo: entidades bancarias, fábricas, cines, emisoras radiales y canales de televisión local), a medios alternativos con la intención de que estos instrumentos de educación, puedan ser difundidos en todos los escenarios públicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Representantes de Promoción de la Salud (PROMSA) de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o RED de salud de cada Región.

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

B. Descripción de intervención propuesta 2.2: Vigilancia Comunitaria

Resultado: Comunidades de riesgo vigiladas, en el cumplimiento de las prácticas saludables y en el mejoramiento del entorno, permanentemente por un equipo mixto conformado por la DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred y el Municipio, eliminando criaderos de zancudo en viviendas y comunidad, reduciendo los factores potenciales de brotes epidémicos en la zona.

Actividad	Tarea	Año 201												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Vigilancia Comunitaria	La DIRESA/GERESA/.DISA o la que haga sus veces /EE.SS identifica las localidades de riesgo a vigilar en coordinación con la Dirección de Saneamiento Ambiental y Epidemiología.				X	X								El responsable de Promoción de la Salud, de cada DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o Red / Microrred de salud de cada zona coordinadora con el Municipio distrital o provincial (Área Participación Vecinal, Consejo Distrital/Provincial).
	Se conformará el comité de vigilancia comunitaria (en el mes de abril) en coordinación con la municipalidad, podría ser integrado por los líderes comunales (JVC, OSB, ACS) y visitadores de vivienda, captados por el Área de Participación Vecinal de la Municipalidad, o se podrá trabajar con el grupo de la Municipalidad ya conformado para similar fin (Ejem: Encargado o Grupo responsable de ejecutar la meta del Plan de Incentivos (PI) del Ministerio del Ambiente: Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en un 12% de las viviendas urbanas del distrito).				X	X								

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

DPCS MINSA
Dirección General de Promoción de la Salud

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Vigilancia Comunitaria	La DIRESA/GERESA o la que haga sus veces brindará dos (2) talleres de capacitación al grupo de líderes comunales (JVC, OSB, ACS) y personal de la municipalidad, que visitará las viviendas de las localidades de riesgo.				X					X				El responsable de Promoción de la Salud, de cada DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o Red / Microred de salud de cada zona coordinadora con el Municipio distrital o provincial (Área Participación Vecinal, Consejo Distrital/Provincial).
	Distribución de zonas de riesgo por sectores priorizados a cada grupo para ejecución de visitas domiciliarias; donde el equipo vigilará y educará en prácticas saludables, y acompañarán en la identificación de criaderos y recojo de residuos sólidos. Se realizarán durante los siguientes meses del año: junio a diciembre y de enero a marzo del siguiente año	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Propuesta autorizada y otorgamiento de reconocimiento y/o estímulos no monetarios para los ACS y voluntarios convocados de universidades, institutos.				X								X	

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

C. Descripción de intervención propuesta 2.3: Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)

Resultado: Eliminación de criaderos de zancudo en el distrito, mediante la movilización masiva, participación ciudadana y de las instituciones públicas y privadas.

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)	Emisión de Ordenanza Municipal, documento que formaliza nuestra intervención y la eleva a carácter de Política Pública Local.				X									El representante de salud de PROMSA, DESA de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o Red/Microrred de cada Región de Salud orientará al Municipio distrital, provincial con la Gerencia Municipal, Gerencia de Limpieza Pública o de Gestión Ambiental, Gerencia de Desarrollo Social para que se realice la actividad.
	Se orienta a la municipalidad coordinar previamente con la GDS, el Área de Participación Vecinal y convocar a los actores sociales claves de los diferentes sectores de su ámbito para distribuir responsabilidades para la campaña; se debe hacer al menos dos (2) veces al año, de preferencia en los períodos previos a las lluvias e intensidad del calor.	X	X	X							X	X	X	
	La autoridad de salud regional monitorea las acciones de la campaña masiva de recolección y eliminación de criadero.	X	X	X							X	X	X	
	Convocar aliados estratégicos intersectorial e intergubernamental para garantizar la mayor cobertura de intervención.	X	X	X							X	X	X	

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles)	En caso de no contar con la maquinaria pesada (camiones recolectores, y otros). Se puede coordinar y gestionar intergubernamentalmente con las gerencias regionales aliados y otros aliados estratégicos.	X	X	X							X	X	X	Aliados estratégicos intergubernamentales: • Ministerio de Salud o representantes regionales (DIRESA/GERESA/DISA). • Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (GRVES). • Gerencia de Obras e Infraestructura. • Gerencia Regional de Agricultura. • Gerencia Regional de Desarrollo Social. • Ministerio Público. • Ministerio de la Mujer. • Beneficencia Pública. • Organismos no Gubernamentales (ONG).
	Gobierno Local controla punto crítico para la recolección y disposición final de los residuos sólidos; y así evitar el reciclaje y la exposición de los inservibles en los puntos de acumulación o acopio.	X	X	X							X	X	X	

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

D. Descripción de intervención propuesta 2.4: Recojo y procesamiento de residuos sólidos

Resultado: Distritos limpios con un sistema de recojo y procesamiento de residuos sólidos permanente, que contribuye a la eliminación de potenciales criaderos de zancudo.

Actividad	Tarea	Año 201												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Recojo y procesamiento de residuos sólidos	Actividad programada a lo largo del año, la DIRESA/GERESA/DISA/RED/Microrred de salud incidirá sobre la importancia de la función de la municipalidad en mantener la regularidad y cumplimiento del servicio de recojo y procesamiento de residuos sólidos para evitar la acumulación de criaderos en las calles o puntos de acopio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La DIRESA/GERESA/DISA/RED incidirá con el Municipio Distrital o Provincial (Áreas Participación Vecinal, Salud y Limpieza Pública, Saneamiento Ambiental, Salubridad).
	El programa selectivo de residuos sólidos impulsado por el MINAM, meta del Plan de Incentivo, fortalecerá esta actividad y contribuirá a disminuir los potenciales criaderos de zancudo en las viviendas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	De igual manera, para esta actividad se incidirá con el Gobierno Local para que prevea la disposición adecuada de volquetes o camiones recolectores con combustible; y contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos y así asegurar diariamente el servicio público de recojo de residuos sólidos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

E. Descripción de intervención propuesta 2.5: Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)

Resultado: Instituciones públicas, privadas y sectores participan activamente a través de sus instituciones: Centros Laborales, II.EE., entre otros, asumiendo acciones de eliminación de potenciales criaderos de zancudo.

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)	Esta actividad, se debe realizar cuatro (4) veces al año, recomendándose realizarlas en el último semestre del año.							X	X	X	X	X	X	El Equipo de Salud con representantes de PROMSA, DESA de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces o RED/ Microrred de cada región. Municipio Distrital, Provincial en coordinación con las áreas correspondientes del Municipio Y Aliados estratégicos intergubernamentales como: Ministerio de Educación o representantes regionales (DREL/ UGEL). La Dirección/Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
	Dos (02) campañas con centros laborales La DIRESA/GERESA/DISA orientará a la Municipalidad para que coordine con la Dirección/Gerencia Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo para definir fecha de recojo de criaderos del zancudo (inservibles), para que los centros laborales en simultáneo, realicen el recojo de objetos inservibles.									X		X		
	Dos (2) campañas de limpieza en II.EE. (primaria, secundaria y superior.) Realización de concurso inter-escolar. Movilizando a los alumnos para que lleven de sus casas, los objetos inservibles (potenciales criaderos) hacia un sitio dispuesto, desde cuyo punto la Municipalidad los recoja y elimine.								X	X	X	X	X	

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

Actividad	Tarea	Año 201_												Responsables
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles)	Las gerencias de Educación Municipal y Regional; así como las gerencias regionales de Trabajo, del Medio Ambiente y la de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Pueden premiar a la población escolar o centros laborales que realicen una adecuada labor de recolección de inservibles en su comunidad.								X	X	X	X	X	Gerencia Regional de Educación.
	Coordinar institucionalmente para la disposición adecuada de volquetes o camiones recolectores, con combustible y contar con personas capacitadas para el recojo de residuos sólidos.								X	X	X	X	X	Gerencia Regional de Agricultura. Gerencia Regional de Desarrollo Social. Ministerio Público. Ministerio de la Mujer. Beneficencia Pública. ONG.

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

ANEXO 11
MODELO DE OFICIO CON INFORME ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DIRESA/GERESA/DISA O LA QUE HAGAN SUS VECES

OFICIO Nº -201 -XXXXXX

XXXXXXXXXX, XX de Enero del 201__

Señor (a)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Director (a) General
DIRESA/GERESA/DISA o la que hagan sus veces
Presente.-

ASUNTO: Informe de Evaluación de Actividades.

ATENCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud ó la que haga sus veces.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar la documentación, que da cuenta del cumplimiento de acciones en el marco del **"Acta de compromiso intergubernamental para la intervención sobre los determinantes sociales de la salud asociados al dengue,** que corresponde a esta Municipalidad.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de las intervenciones; a favor de la comunidad contribuye a disminuir el riesgo de enfermar por dengue.

En tal sentido, adjunto al presente el reporte de las actividades, en función a los criterios técnicos establecidos por el Documento Técnico de Promoción de la Salud del MINSA, que incluye:

I. LÍNEA DE BASE Y DE CONTROL

ÍNDICE AÉDICO y BRETAU ANTES DE LA INTERVENCIÓN

(Fecha:__ /04 /201__): .....%....

ÍNDICE AÉDICO Y BRETAU DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Fecha:__ / 12 /201__): .....%....

ENCUESTA ECAP: Elaborar un resumen de las diferencias más relevantes, entre el resultado de la encuesta de base y de control:

ECAP Línea de Base:	ECAP Línea de Control:

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

II. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

INTERVENCIONES	REPORTE DE ACTIVIDADES	FECHA EN QUE SE REALIZA	RESPONSABLES
1. Encuestas ECAP.			
2. Comunicación Social.			
3. Vigilancia Comunitaria.			
4. Campaña masiva de recolección y eliminación de criaderos (inservibles).			
5. Recojo y procesamiento de residuos sólidos.			
6. Campaña selectiva de recojo y eliminación de criaderos (inservibles).			
7. Realizar monitoreo trimestral del plan de intervención (N° de Reuniones).			
8. Proyecto de inversión en ...			

Sin otro particular, me despido de usted.

Se puede adjuntar alguna evidencia: Por ejemplo:

1. ***Constancia de Capacitación a Voluntarios.***
2. ***Cargo de los reportes semestrales del Índice Aédico e Índice Breteau***
3. ***CD con evidencias fotográficas y/o video de actividades.***

Atentamente,

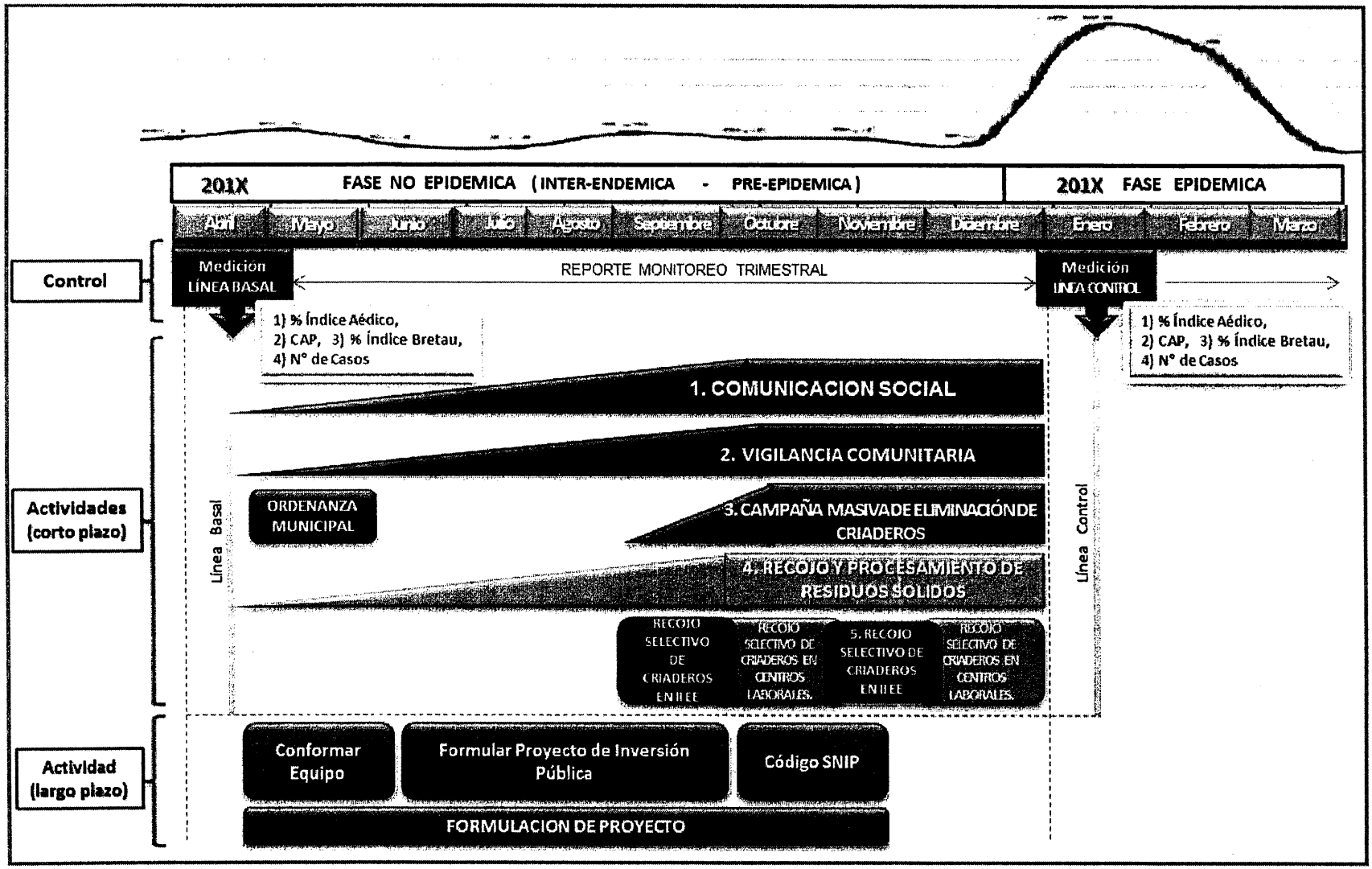
Nombre XXXXXXXXXXXX
Coordinador del Equipo de trabajo dengue
Municipalidad XXXXXXXXXXXX

Nombre XXXXXXXXXXXX
Director de la Red/Microrred de
Salud de XXXXXXXXXX

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

ANEXO 12
ESQUEMA: INTERVENCIÓN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL PERÍODO SIN BROTE



M.L. Pérez G.

DPOS MINSA

DOCUMENTO TÉCNICO:
"ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE A TRAVES DEL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD"

ANEXO 13

CUADRO DE MONITOREO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE

EJEMPLO: SE: 18 Fecha: Del 28/04/2014 Al 04/05/ 2014

GERESA / DIRESA / DISA : .....

RED/MICRORED DE SALUD: ..... PROVINCIA : ..... DISTRITO : .....

ESCENARIOS DE INTERVENCION	ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN		REGISTRO DIARIO DEL N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD / SEMANA EPIDEMIOLÓGICA															Observaciones
			Cantidad Programada	META %	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 28/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 29/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 30/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 01/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 02/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 03/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 04/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Incluye Colegios, Universidades e Institutos)	REUNIONES DE CAPACITACION A DOCENTES DE II.EE., FORMACIÓN DE BRIGADAS y CONCURSO INTERESCOLAR	N°. colegios intervenidos (públicos y privados) de las zonas priorizadas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejm: 2 Colegios de Secundaria particular
		N° universidades, institutos intervenidos (públicos y privados) de las zonas priorizadas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejm: 2 universidades y 1 instituto
		N°. de docentes capacitados, con visita de acompañamiento o verificación in situ		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de capacitaciones a estudiantes, por los docentes.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N°. de II.EE que implementan la vigilancia de febriles		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de campañas para el recojo de criaderos (inservibles)		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de II.EE que participan en el concurso interescolar de recojo de criaderos (inservibles)		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de concursos interescolar de recojo de criaderos		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N°. de II.EE con paneles, murales, letreros con mensajes alusivos a la prevención y control del dengue.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de vigias estudiantiles capacitados		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de vigias estudiantiles operativas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejem: Voluntariado..
	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN MASIVA Y DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD	N° de ferias educativas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de movilizaciones / pasacalle		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
GOBIERNOS LOCALES	GESTIÓN TERRITORIAL	N° de ordenanzas emitidas en relación a la prevencion y control del dengue		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de coordinaciones realizadas con instituciones de salud		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de gobiernos locales que brindan apoyo con el Serenazgo para el trabajo de campo.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de reuniones del COE Distrital		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de reuniones del COE Salud DIRESA/DISA/GERESA		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de campañas masivas de limpieza y recojo de criaderos inservibles		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

Ministerio de Salud – Dir. de Promoción de la Salud – M.L. Pérez G.

Dirección General de Salud – DPCS MINSA – Promoción de la Salud

ESCENARIOS DE INTERVENCION	ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN		REGISTRO DIARIO DEL N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD / SEMANA EPIDEMIOLÓGICA														Observaciones
			Cantidad Programada	META %	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 28/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 29/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 30/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 01/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 02/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 03/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 04/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	
GOBIERNOS LOCALES	SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE MEDIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	N° de gobiernos locales que reproducen material educativo comunicacional.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de equipos conformados para realizar Perifoneo durante las actividades de fumigación.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejem: (MÓVILES: Motocar, camioneta, CON SU EQUIPO DE AUDIO)
FAMILIA	VISITAS A FAMILIAS	N° de familias que reciben sesiones demostrativas / educativas para la prevención y control del dengue		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	ACS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE.	N° de viviendas recuperadas por las brigadas ACS .		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de febriles referidos en comunidad por el ACS.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de ACS Capacitados		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de ACS Activos que apoyan diariamente al control vectorial y realizan la Educación sanitaria a familias.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
COMUNIDAD	ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (OSB) y JUNTAS VECINALES COMUNALES (JVC) QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE.	N° de OSB capacitadas en sesiones educativas / demostrativas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejem: Nombre de Vaso de leche, comedores populares, etc.
		N° de OSB que brindan información sobre medidas de prevención y control del dengue.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de JVC capacitadas en sesiones demostrativas y/o educativas		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de JVC que brindan información sobre medidas de prevención y control del dengue.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	Ejem: Nombre de la JVC.
	MERCADOS	N° de mercados capacitados en sesiones educativas y/o demostrativas.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de mercados que difunden medidas prevención y control del dengue, mediante material impreso y audio		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	CENTROS DE TRABAJO	N° de campañas de limpieza y recojo de inservibles dentro de los centros laborales (Mercados, II.EE, empresas), etc.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de centros de trabajo que difunden medidas de prevención y control del dengue, a través de material informativo impreso y/o audio visual		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

Ministerio de Salud — Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Perez G.
DPCS MINSA — Dirección General de Promoción de la Salud

ESCENARIOS DE INTERVENCION	ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN		REGISTRO DIARIO DEL N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD / SEMANA EPIDEMIOLÓGICA														Observaciones
			Cantidad Programada	META %	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 28/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 29/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 30/04/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 01/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 02/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 03/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 04/05/2014	Porcentaje Avanzado (%)	
COMUNIDAD	CENTROS DE TRABAJO	N° de farmacias y boticas capacitadas en vigilancia de febriles y cuidado en el expendio de antipiréticos.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de consultorios o centros médicos, que son capacitados para la prevención y control del dengue; y manejo de los casos.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL QUE DIFUNDEN MEDIDAS PREVENTIVAS	N° de entrevistas radiales		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de emisoras radiales		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de canales televisión		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de horas de perifoneo		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
SECTOR SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	N° de capacitaciones al personal de salud en promoción de prácticas saludables en relación a la prevención y control de dengue		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de capacitaciones al personal de salud en vigilancia comunitaria		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de visitas domiciliarias a febriles, referidos por el ACS		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		N° de sesiones demostrativas realizadas por el personal de salud, a los usuarios del EE.SS.		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	CAPTACIÓN DE PROMOTORES / ACS COMUNITARIOS	N° de ACS nuevos captados		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Análisis de los datos y resultados:

Nombre, Firma y sello del Comisionado - DIRESA/GERESA o la que haga sus veces

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

DOCUMENTO TÉCNICO:
"ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE A TRAVES DEL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD"

INTRUCTIVO Nº 01

LLENADO DEL CUADRO DE MONITOREO DIARIO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL DENGUE

Este cuadro está diseñado para facilitar el registro diario solicitado, de una semana epidemiológica, en relación a la información de las actividades de promoción de la salud, en el marco de la lucha contra el dengue.

Para el registro de las columnas y filas, deberá tener en cuenta las siguientes pautas que a continuación se detallan:

- **En la segunda fila**: Registrar el número de semana epidemiológica (SE) a la que pertenece la información que se va a reportar; y así mismo colocar la fecha de inicio y final de la SE en mención.
- **En la tercera fila**: Registrar el nombre de la GERESA/ DIRESA /o la que haga sus veces, a la que pertenece la información.
- **En la cuarta fila**: Registrar el nombre de la Red o Micro Red de salud a la que pertenece la información.
- **En la primera columna (C1)**: Se describen los escenarios de intervención, donde se implementarán las actividades de Promoción de la Salud, para la prevención y control de dengue.

ESCENARIOS DE INTERVENCION (C1)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GOBIERNOS LOCALES
FAMILIA
COMUNIDAD
SECTOR SALUD

- **En la segunda y tercera columna (C2 y C3)**: Se describen las actividades planteadas en Promoción de la Salud, de manera genérica (G) y específicas (E), como parte de las intervenciones propuestas.

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

ACTIVIDADES		DESCRIPCCIÓN
(2) (G)	(3) (E)	
REUNIONES DE CAPACITACION A DOCENTES DE II.EE., FORMACIÓN DE BRIGADAS y CONCURSO INTERESCOLAR	N° de colegios intervenidos (públicos y privados) de las zonas priorizadas.	Consignar como colegios intervenidos a aquellos que: 1) Han participado en el recojo de criaderos (inservibles) dentro de la institución; y 2) Conforman parte de la red vigilancia de febriles.
	N° de universidades, institutos intervenidos (públicos y privados) de las zonas priorizadas.	Consignar como universidades intervenidas a aquellos que: 1) Han participado en el recojo de criaderos (inservibles) dentro de la institución; y 2) Conforman parte de la red vigilancia de febriles.
	N° de docentes capacitados, con visita de acompañamiento o verificación in situ.	Consignar a aquellos docentes que: 1) Han sido capacitados por el personal de salud (instructores) en acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue desde la comunidad educativa; y 2) Que capacitan a su vez a los estudiantes de su II.EE; siendo necesario el acompañamiento de un personal de salud, que verifique mínimamente en un ocasión esta última capacitación otorgada por los docentes.
	N° de capacitaciones a estudiantes, por los docentes.	Actividad referida a la capacitación brindada a los estudiantes de las II.EE. que: 1) Han sido capacitados a su vez, por su docente en acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue desde la comunidad educativa y con proyección a sus comunidades.
	N°. de II.EE que implementan la vigilancia de febriles.	Son las instituciones que a través de sus docentes y vigías escolares, notifican los casos sospechosos de dengue (o febriles) al EE.SS: Referido como caso: a toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y que estuvo dentro de las dos últimas semanas, en un área con transmisión de virus dengue.
	N° de campañas para el recojo de criaderos. (inservibles)	Los directores y profesores deben coordinar realizar estas campañas como mínimo 2 veces al año dentro de la Institución Educativa, para eliminar todos los objetos que puedan acumular agua y que ya no se utilicen, dentro de la Institución Educativa.
	N° de II.EE que participan en el concurso interescolar de recojo de criaderos. (inservibles)	Son las II.EE que participan en el concurso interescolar a través de redes educativas; previa capacitación. Esta actividad consiste en que los estudiantes deben identificar, recoger y eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua y que ya no utilicen dentro de sus casas; para esta acción los alumnos deben completar una ficha de identificación de criaderos del *Aedes aegypti*, posteriormente recogen estos criaderos y luego son trasladados a su Institución Educativa. Debe realizarse como mínimo 2 veces al año.
	N° de concursos interescolar de recojo de criaderos.	Actividad referida al desarrollo del concurso interescolar organizado por la UGEL, DISA/DIRESA/GERESA y Municipio. Debe realizarse como mínimo 2 veces al año.
	N° de II.EE con paneles, murales, letreros con mensajes alusivos a la prevención y control del dengue.	Las II.EEs participan en estas actividades, por redes educativas previa capacitación y coordinación con la UGEL y el EE.SS. Esta actividad se realiza como mínimo 2 veces al año.
	N° de vigías estudiantiles capacitados.	Consignar a aquellos estudiantes de las II.EE. que han sido capacitados por el personal de salud en acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue desde la comunidad educativa y con proyección a la comunidad.
	N° de vigías estudiantiles operativas.	Consignar a aquellos estudiantes de las II.EE. que: 1) Han sido reconocidos como vigías y capacitados por el personal de salud en acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue desde la comunidad educativa y con proyección a sus viviendas. 2) Participan en sesiones educativas / demostrativas. 3) Ayudan a realizar la vigilancia de febriles en la II.EE. y Comunidad.
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN MASIVA Y DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD	N° de ferias educativas.	Consignar a aquellas actividades donde los estudiantes de las II.EE brindan sesiones educativas / demostrativas. en acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue desde la comunidad educativa y con proyección a sus viviendas.
	N° de movilizaciones / pasacalle.	Actividad de donde los integrantes de las II.EEs realizan una movilización masiva (marcha) en un día determinado, por las calles principales del distrito, con mensajes alusivos de acciones preventivas promocionales para evitar y controlar el dengue.

Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud – DPCS MINSA

ACTIVIDADES		DESCRIPCCIÓN
(2) (G)	(3) (E)	
GESTIÓN TERRITORIAL	N° de ordenanzas emitidas en relación a la prevención y control del dengue.	Emisión de ordenanzas municipales (OM), en relación a las actividades la prevención y control del dengue, que establezca sanciones pecuniarias, según realidad del distrito. Mínima 1 OM, por cada gobierno local (distrital y/o provincial).
	N° de coordinaciones realizadas con instituciones de salud.	Actividad referida a las coordinaciones con ESSALUD, FF.AA, PNP y otras; de naturaleza pública y privada.
	N° de gobiernos locales que brindan apoyo con el Serenazgo para el trabajo de campo.	Consignar a los gobiernos locales que brindan el apoyo del Serenazgo para facilitar y resguardar el trabajo de campo del personal de salud y ACS, durante las intervenciones casa por casa, en localidades inseguras y renuentes a las acciones de prevención y control de dengue.
	N° de reuniones del COE Distrital.	Cuantificación de reuniones semanales multisectoriales del Comité Operativo de Emergencia (COE) del distrito endémico. Actividad liderada por el gobierno local.
	N° de reuniones del COE Salud DIRESA/DISA/GERESA.	Cuantificación de reuniones diarias del Comité Operativo de Emergencia (COE) de salud, en la zona.
	N° de campañas masivas de limpieza y recojo de inservibles.	Cuantificar el número de campañas organizadas por los gobiernos locales, las cuales deben coordinar, con sus líderes comunales para realizar estas actividades como mínimo 2 veces al año en las zonas de riesgo del distrito, para eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua y que ya no se utilicen, dentro de las viviendas.
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE MEDIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	N° de gobiernos locales que reproducen material educativo comunicacional.	Los gobiernos locales que tienen dentro de su plan comunicacional anual de prevención y control del dengue, un presupuesto para la reproducción de materiales educativos - comunicacionales, que serán utilizados diariamente por el personal de salud, integrantes de las instituciones educativas, ACS y comunidad en general.
	N° de equipos conformados para realizar perifoneo diario durante las actividades de fumigación.	Cuantificar los equipos conformados para realizar el perifoneo, que va informando a las familias previo a la actividad de fumigación.
VISITAS A FAMILIA	N° de familias que reciben sesiones demostrativas / educativas para la prevención y control del dengue.	Se deben consignar a las Familias que: 1) Reciben sesiones educativas y demostrativas por parte del personal de salud o ACS, para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua) Meta 100% de familias en zonas de riesgo que reciben sesiones demostrativas.
ACS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE.	N° de viviendas recuperadas por las brigadas ACS.	Actividad referida a las intervenciones desarrolladas por el ACS, para sensibilizar y disuadir a los vecinos renuentes de su comunidad, para que faciliten el acceso al personal de salud a sus viviendas (durante las intervenciones de educación sanitaria, vigilancia entomológica, abatización y fumigación).
	N° de febriles referidos en comunidad por el ACS.	Se refiere a toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y que estuvo dentro de las dos últimas semanas, en un área con transmisión del virus dengue, captados por el ACS en comunidad; a través del registro de sus actividades diarias; posteriormente notificados y finalmente referidos por el ACS al establecimiento de salud, con o sin acompañamiento del mismo.
	N° de ACS capacitados.	Se deben consignar a aquellos ACS capacitados en: 1) Sesiones educativas, demostrativas para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua). 2) Vigilancia comunitaria y apoyan en la vigilancia entomológica. Esta actividad tiene la finalidad de fortalecer las competencias de los ACS referidas a las acciones de promoción para la prevención del Dengue.
	N° de ACS activos que apoyan diariamente al control vectorial y realizan la educación sanitaria a familias.	Se deben consignar a los ACS que: 1) Brindan sesiones educativas y demostrativas a las familias para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua), durante las visitas domiciliarias. 2) Realizan vigilancia comunitaria y apoyan en la vigilancia entomológica.

Ministerio de Salud – Dirección de Promoción de la Salud – M.L. Pérez C.

Dirección General de Promoción de la Salud – DPCS MINSA

ACTIVIDADES		DESCRIPCCIÓN
(2) (G)	(3) (E)	
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (OSB) y JUNTAS VECINALES COMUNALES (JVC) QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE.	N° de OSB capacitadas en sesiones educativas / demostrativas.	Se deben consignar a las OSB que se capacitan recibiendo sesiones educativas y demostrativas por parte del personal de salud o ACS, para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua).
	N° de OSB que brindan información sobre medidas de prevención y control del dengue.	Se deben consignar a aquellas OSB capacitadas previamente y que realizan en sus comunidades: 1) Sesiones Educativas, demostrativas para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua). 2) Vigilancia Comunitaria.
	N° de JVC capacitadas en sesiones demostrativas y/o educativas.	Se deben consignar a las JVC que se capacitan recibiendo sesiones educativas y demostrativas por parte del personal de salud o ACS, para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y Estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua).
	N° de JVC que brindan información sobre medidas de prevención y control del dengue.	Se deben consignar a aquellas OSB capacitadas previamente y que realizan en sus comunidades: 1) Sesiones Educativas, demostrativas para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua). 2) Vigilancia Comunitaria.
MERCADOS	N° de mercados capacitados en sesiones educativas y/o demostrativas.	Se deben consignar a los mercados en donde el personal que labora en ellos, reciben capacitaciones en sesiones educativas y demostrativas por parte del personal de salud o ACS, para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua) en sus puestos.
	N° de mercados que difunden medidas prevención y control del dengue, mediante material impreso y audio.	Se deben consignar a los mercados en donde el personal que labora en ellos, han sido sensibilizados, capacitados y que realizan difusión de las actividades para la prevención y control del dengue a través de: 1) Material impreso: trípticos, dípticos, pancartas, banners o banderolas. 2) Material de audio: perifoneo interno, spots radiales en los perímetros de los mercados.
CENTROS DE TRABAJO	N° de campañas de limpieza y recojo de inservibles dentro de los centros laborales (Mercados, II.EE, empresas), etc.	Se debe registrar las campañas de limpieza en los centros laborales, para ello es necesario coordinar con el municipio del distrito o provincia. Realizar esta actividad como mínimo 2 veces al año en las zonas de riesgo del distrito.
	N° de centros de trabajo que difunden medidas de prevención y control del dengue, a través de material informativo impreso y/o audio visual.	Se deben consignar a los centros de trabajo en donde el personal que labora en ellos, han sido sensibilizados, capacitados y que realizan difusión de las actividades para la prevención y control del dengue a través de: 1) Material impreso: trípticos, dípticos, pancartas, banners o banderolas. 2) Material de Audiovisual: perifoneo interno, spots audiovisuales ubicados en salas de espera o dispersión, comedores, etc. * Se consideran centros laborales: centros de abasto, bodegas, tiendas de expendio de alimentos en general, empresas privadas (bancos), etc.
	N° de farmacias y boticas capacitadas en vigilancia de febriles y cuidado en el expendio de antipiréticos.	Se deben consignar al personal capacitado que trabaja en las farmacias o las que hagan sus veces, en: 1) Notificación de casos sospechosos de dengue (o febriles) al EE.SS: Referido como caso: a toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y que estuvo dentro de las dos últimas semanas. En área con transmisión de virus dengue. 2) Expendio responsable de antipiréticos. 3) Derivación de los casos febriles al EE.SS.
	N° de consultorios o centros médicos, que son capacitados para la prevención y control del dengue; y manejo de los casos.	Se deben consignar a todos centros médicos particulares o los que hagan sus veces, en donde el personal que labora en ellos son capacitados en: 1) Sesiones educativas para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua). 2) Identificación de signos de alarma. 3) Notificación de casos sospechosos de dengue (o febriles) al EE.SS: Referido como caso sospechoso: a toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y que estuvo dentro de las dos últimas semanas, en un área con transmisión de virus dengue. 4) Expendio responsable de antipiréticos. 5) Derivación de los casos febriles al EE.SS de mayor complejidad, en casos de gravedad o según lo requiera el paciente.

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

ACTIVIDADES		DESCRIPCCIÓN
(2) (G)	(3) (E)	
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL QUE DIFUNDEN MEDIDAS PREVENTIVAS	N° de entrevistas radiales	Actividad referida a autoridades y líderes de la comunidad entrevistados para brindar mensajes claves para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua).
	N° de emisoras radiales	Actividad referida a las emisoras radiales que participan brindando mensajes claves para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua).
	N° de canales de televisión	Actividad referida a los canales de televisión local o por cable, que participan brindando mensajes claves para prevenir y controlar el dengue, acerca de entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua).
	N° de horas de perifoneo	Actividad referida al número de horas de perifoneo realizadas por los equipos de perifoneo, que brindan mensajes claves para prevenir y controlar el dengue.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	N° de capacitaciones al personal de salud en promoción de prácticas saludables en relación a la prevención y control de dengue.	Se deben consignar al número de capacitaciones dirigidas al personal de salud relacionadas al trabajo de la promoción de prácticas y entornos saludables a nivel de: 1) Gobierno Local. 2) Instituciones educativas / Universidades. 3) Centros laborales. 4) Familias. 5) Agentes comunitarios. 6) Comunidad. 7) Establecimientos de salud. 8) Población en general.
	N° de capacitaciones al personal de Salud en vigilancia comunitaria.	Se deben consignar al número de capacitaciones dirigidas al personal de salud en acciones de "Vigilancia Comunitaria".
	N° de visitas domiciliarias a febriles, referidos por el ACS.	Es la visita domiciliaria que realiza el personal de salud a las personas febriles que han sido referidos por el ACS.
	N° de sesiones demostrativas realizadas por el personal de salud, a los usuarios del EE.SS.	Se deben consignar a las sesiones educativas y demostrativas realizadas por el personal de salud, para prevenir y controlar el dengue promoviendo entornos saludables (higiene de la vivienda, disposición adecuada de residuos sólidos) y estilos de vida saludables (almacenamiento y tratamiento del agua). Estas sesiones deben brindarse al 100% de los usuarios de los servicios de un establecimiento de salud de las zonas de riesgo, indiferentemente de cual sea su dolencia o patología.
CAPTACIÓN DE PROMOTORES / ACS COMUNITARIOS	N° de ACS nuevos captados.	Actividad referida a la búsqueda y captación de una persona hombre o mujer voluntaria, elegida y reconocida por la comunidad con valores (ACS), que es capacitado integralmente en temas que abordan los determinantes de la enfermedad. El personal de salud que realiza el trabajo comunitario dentro de la jurisdicción de su establecimiento, debe calcular y programar el número de ACS necesarios para realizar las visitas a la comunidad y promover la elección de nuevos ACS.

Ministerio de Salud
Dir. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

- **En la cuarta y quinta columna (C4 y C5):** En esta parte se debe tener en cuenta que durante el período de brote de dengue, lo ideal es programar una meta al 100%, por lo tanto se debe registrar la cantidad total (programada).

PROGRAMACIÓN	
CANTIDAD Programada (C4)	**META % (C5)**
0	**100%**

- **Desde la sexta hasta la décimo novena columna (C6 a la C19):** Registra el número de actividades realizadas por día (ejemplo Columna 6), y luego detallando el porcentaje avance/día (columna 7, que es automático); dentro de la SE señalada en la segunda fila.

Ejemplo: Columna 6 y 7

REGISTRO DIARIO DEL N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD / SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	
N° ACTIVIDADES REALIZADAS al 28/04/2013 (C6)	**Porcentaje Avanzado (%) (C7)**
...	**... %**

- **En la vigésima columna (C20):** Registrar algunas observaciones; por ejemplo en la actividad N° 01: El N° de colegios intervenidos (públicos y privados) de las zonas priorizadas; en observaciones podemos registrar si todos colegios fueron privados o públicos u otras de mayor interés; pudiendo citar si los colegios fueron de nivel inicial, primario o secundario. Estos datos podrían ser importantes en su localidad; si se inter-relacionan con otras actividades, tales como el concurso interescolar. Otro ejemplo sería el poder registrar en este punto cuantos se beneficiaron con las actividades, como en el caso brindar una sesión demostrativa o educativa.

Observaciones (C20)

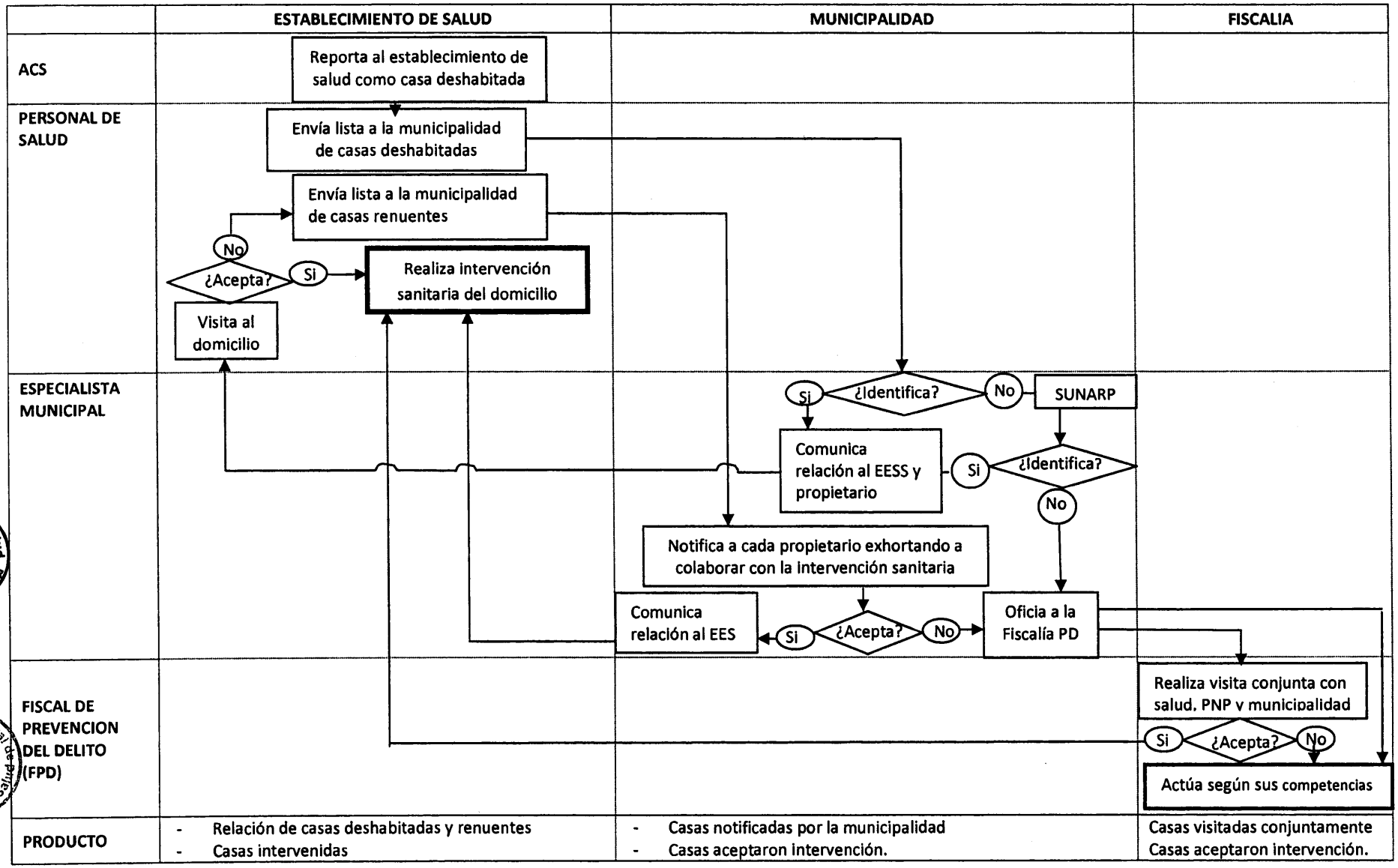
- En la **penúltima fila:** Registrar el nombre, firma y sello del Comisionado - DIRESA/GERESA.
- **En la última fila:** Registrar un breve análisis de la información que contiene el cuadro de monitoreo, aspectos relacionados a la programación, oportunidades y dificultades para la implementación de las actividades desarrolladas, entre otras.

Nota: en el caso que algunas de las actividades no apliquen a su realidad colocar: "No Aplica" o "NA".

Junio / 2013.

ANEXO 14

MAPA DE PROCESOS PARA INTERVENCION DE CASAS DESHABITADAS



Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

DEFINICIONES:

- **VIVIENDA DESHABITADA**

  Vivienda que se encuentra sin ocupante por lo menos un mes.[1]

ACCIONES:

- **PARA LAS VIVIENDAS o CASAS DESHABITADAS**

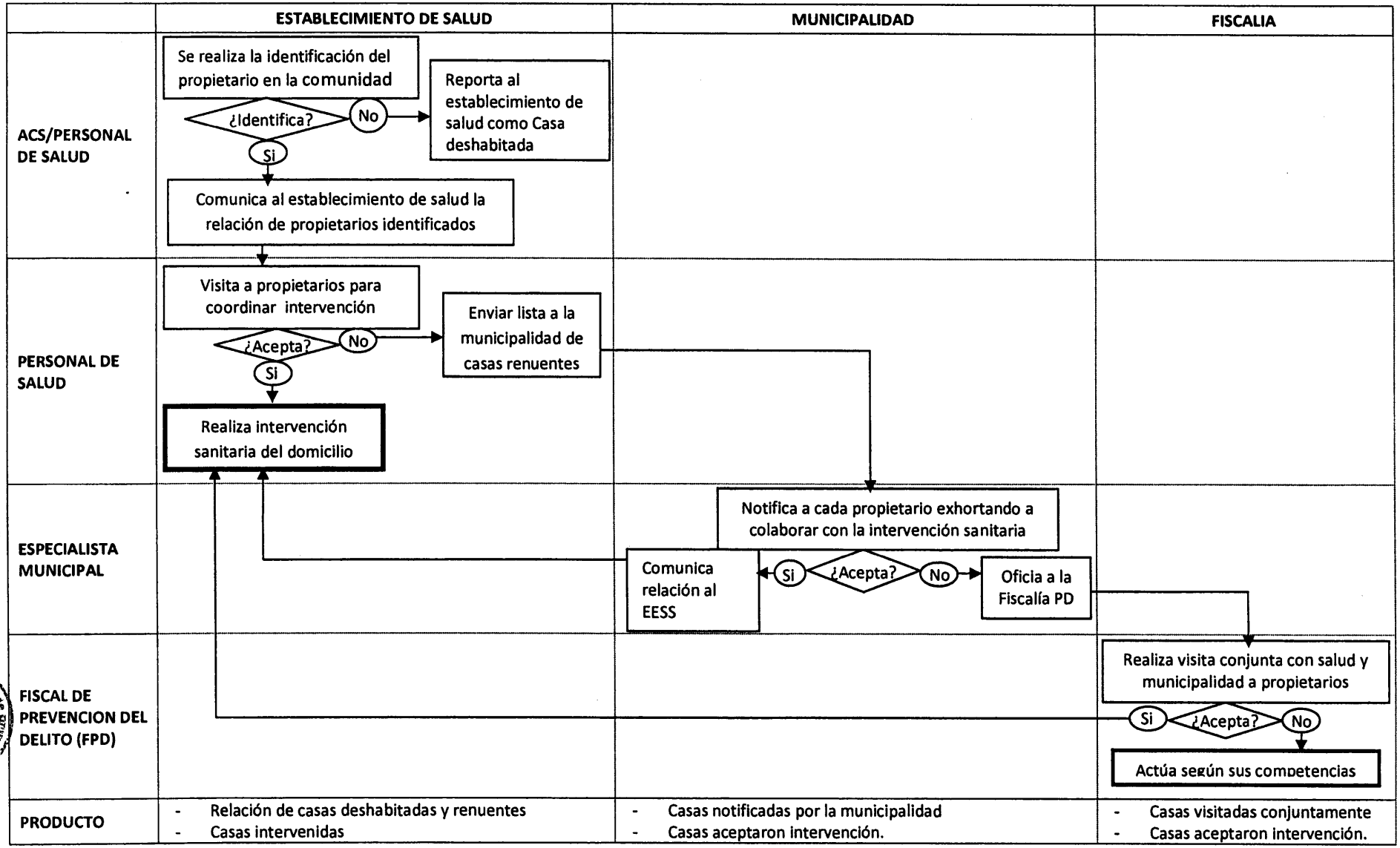
- ► El personal de salud o ACS registra la casa como **DESAHABITADA** y envía el listado a la municipalidad de la localidad, quien identifica al propietario de la casa mediante sus fuentes informativas y le comunica la fecha de intervención.
- ► En caso que no identifica al propietario mediante sus fuentes, entonces se solicitará esta información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Una vez identificado el propietario, le comunica la fecha de intervención.
- ► El día señalado, si el propietario accede se realiza la intervención sanitaria. En caso que el propietario no accede a la intervención, la municipalidad de la localidad realiza el Acta de advertencia 1, donde se señala la fecha de la próxima visita.
- ► El día de la visita, si el propietario accede a la intervención se procederá a la intervención sanitaria. En caso que el propietario no acceda a la intervención, la municipalidad oficia a la Fiscalía de Prevención del Delito (Oficio).
- ► El Fiscal de Prevención del Delito realiza la visita coordinada con la autoridad sanitaria regional y la municipalidad, si el propietario accede a la intervención se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario no accede a la intervención, el Fiscal actúa de acuerdo a sus facultades.

Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

[1] Dirección General de Salud Ambiental.MINSA.2011. Norma Técnica de Salud para la Implementación de la Vigilancia y Control del *Aedes aegypti*, Vector del Dengue en el Territorio Nacional, aprobado con RM N° 797-2010/MINSA

MAPA DE PROCESOS PARA INTERVENCION DE CASAS CERRADAS



Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.
Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS MINSA

DEFINICIONES:

- **VIVIENDA CERRADA**

  Vivienda que se encuentra cerrada al momento de la inspección de vivienda o que no haya presencia de un adulto al momento de la inspección. (DIGESA)[2]

ACCIONES:

PARA LAS VIVIENDAS o CASAS CERRADAS

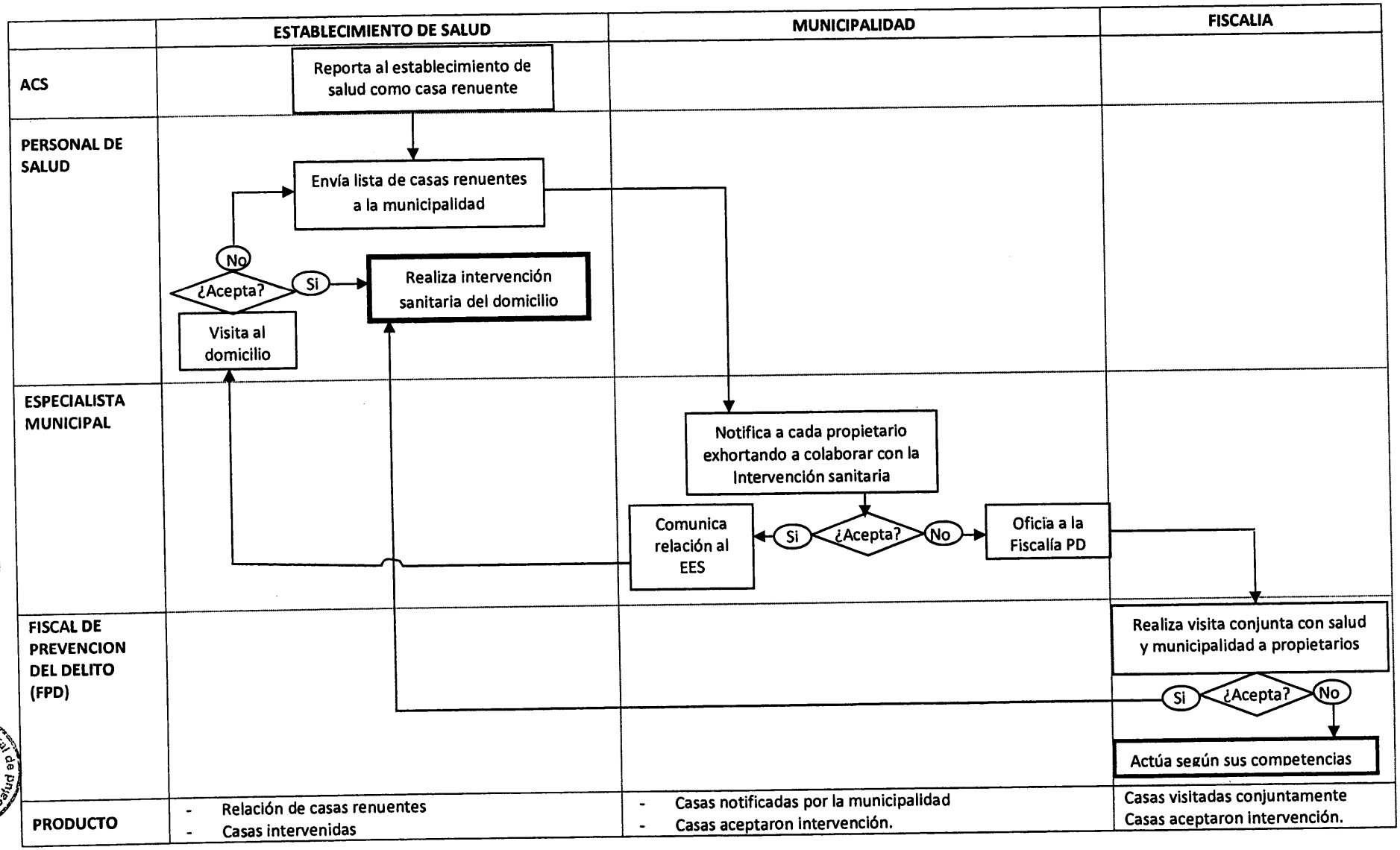
- El personal de salud o ACS con la colaboración de los vecinos, identifica al propietario o poseedor de la casa (verificar con título de propiedad, constancia de posesión o contrato de alquiler u otro documento a fin) y lo visita para comunicarle la próxima fecha de intervención y solicitar su apoyo para la realización de la actividad. En caso de no identificar al propietario o poseedor de la casa, se clasificará a la casa o predio como **DESHABITADAS.**
- Si el propietario o poseedor de la casa accede a colaborar, entonces se procederá a realizar la acción sanitaria según lo programado. En caso contrario, es decir, no manifiesta su disposición a colaborar, el personal de salud o ACS lo registrará para informar a la municipalidad dicha situación.
- Una vez que la municipalidad recibe la relación de los propietarios o poseedores de casas o predios cerrados que no colaboren con las actividades sanitarias, este realiza el Acta de advertencia 1, donde señala la fecha de la próxima visita.
- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede a la intervención se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario o poseedor de la casa no accede a la intervención, la municipalidad oficia a la fiscalía de prevención del delito (Oficio).
- El fiscal de prevención del delito realiza la visita coordinada con la autoridad sanitaria regional y la municipalidad de la localidad, si el propietario o poseedor de la casa accede a la intervención se procede a la intervención sanitaria. En caso de que el propietario o poseedor de la casa no accede a la intervención, el fiscal actúa de acuerdo a sus facultades.

Ministerio de Salud D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

[2] Idem

MAPA DE PROCESOS PARA INTERVENCION DE CASAS RENUENTES



M.L. Pérez G.

DEFINICIONES:

- **VIVIENDA RENUENTE**

  Vivienda que se encuentra con la presencia de un adulto al momento de la inspección pero que no autoriza el ingreso a la vivienda. [3]

ACCIONES:

PARA LAS VIVIENDAS o CASAS RENUENTES

- El personal de salud o ACS registra la casa como **RENUENTE** y envía el listado a la municipalidad de la localidad, quien envía el Acta de advertencia 1, donde se señala la fecha de la próxima visita.
- El día de la visita, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario o poseedor de la casa no acceda a la intervención, la municipalidad de la localidad oficiará a la fiscalía (Oficio).
- El fiscal de prevención del delito realiza la visita coordinada con la autoridad sanitaria regional, Policía Nacional del Perú y la municipalidad de la localidad, si el propietario o poseedor de la casa accede, se procede a la intervención sanitaria. En caso que el propietario o poseedor de la casa no acceda a la intervención, el fiscal actúa de acuerdo a sus facultades.

Ministerio de Salud Dir. Gral. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud DPCS MINSA

[3] Ídem

MODELO DE ACTA 1: ADVERTENCIA PARA CASAS RENUENTES

En fecha _____, siendo las _____,del mes de _____de año _____, se constituyó el funcionario de la institución (Municipalidad / Salud) _____ identificado con el nombre de _____, con DNI N°_____, al establecimiento y/o inmueble del propietario o poseedor Sr.(a)_____, con DNI N°_____ ubicado en: _____Distrito _____Provincia _____y Departamento de _____ para realizar **LA INSPECCIÓN Y/O FUMIGACIÓN DE INMUEBLE PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA PROLIFERACIÓN DEL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE,** quien luego de ser informado (a) sobre los motivos de la intervención, se niega a brindar su colaboración aduciendo_____.

Motivo por el cual se hace de su conocimiento que su actitud de **NO PERMITIR LA INSPECCION Y/O FUMIGACION DE SU VIVIENDA PARA LA PREVENCION CONTRA LA PROLIFERACION DEL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE** contraviene lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 26842 Ley General de la Salud, que establece que *"Toda persona es responsable frente a terceros por el incumplimiento de las practicas sanitarias y de higiene destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles, así como por los actos o hechos que originen contaminación del ambiente".*

Dicha conducta viola las medidas sanitarias impuestas por la autoridad de salud, la cual se encuentra sancionada en el artículo 292 del Código Penal, correspondiente a los delitos contra la salud pública, por lo que se comunica que se le volverá a visitar el día __/____/_____ en los horarios de _____, por lo cual se levanta el presente **ACTA,** firmando los presentes en señal de conformidad.

_____
Nombre:
Cargo:
DNI:
Personal de la municipalidad:

_____
PROPIETARIO/POSEEDOR DE LA VIVIENDA:
Nombre:
DNI:

PD. Si el propietario o poseedor de la vivienda no firma, colocar el motivo de porque no firma el acta.

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

MODELO DE OFICIO ANTE LA FISCALIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Cambio Climático"

Lima,.....de 2014

OFICIO Nº .....-2014- ...../.....

SEÑOR:

FISCAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Presente.-

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento a su Despacho que la Gerencia o Subgerencia (municipal) _____ a mi cargo en coordinación con la DIRESA/GERESA/DISA/RED_____ ha dispuesto la intervención de las viviendas que a continuación se detallan para realizar una inspección al advertirse que podrían contener **POTENCIALES CRIADEROS DE ZANCUDOS**. Se detalla:

-

-

Sin embargo, los ocupantes de las viviendas antes referidas se han mostrado renuentes a prestar su colaboración para la inspección y/o fumigación de las viviendas, por lo que en salvaguarda de la salud pública y de la población en general, solicito a usted se sirva disponer la presencia de un representantes de la fiscalía a su cargo para acompañar en el proceso de intervención a las viviendas a fin de evitar la propagación de la **EPIDEMIA DEL DENGUE**.

Esperando su gentil apoyo, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente

_____

Nombre del Funcionario:
Cargo:
Personal de la municipalidad:

Ministerio de Salud
D.G. de Promoción de la Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPCS
MINSA

IX. BIBLOGRAFÍA

1. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud Dengue: Guías para el diagnóstico tratamiento, prevención y control. La Paz, Bolivia. OPS/OMS, 2010.Págs. Cap.1.
2. Organización Mundial de la Salud.2008. Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.
3. PAHO. Number of reported cases of dengue and dengue hemorrhagic fever (DHF), Region of the Americas (by country and subregion). Washington, DC, Pan American Health Organization, 2008.
4. Leitmeyer KC. Dengue virus structural differences that correlate with pathogenesis. Journal of Virology, 1999, 73(6):4738–4747.
5. Lanciotti RS et al. Molecular evolution and epidemiology of dengue-3 viruses. Journal of General Virology, 1994, 75(Pt 1):65–75.
6. Lloyd, L., 2003. Mejores prácticas para la prevención y control del dengue en las Américas. USAID América Latina y el Caribe. 127 pp.
7. Parks W & L Lloyd, 2004. Planning Social mobilization and communication for dengue fever prevention and control. WHO/CDS/WMC/2004.2.
8. Ley Orgánica de Municipalidades.
9. PAHO. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Regional Committee resolution CD43.R4, adopted at the 53rd session of the Regional Committee for the Americas, 43rd Directing Council. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2001.
10. Renganathan E et al. Communication-for-Behavioural-Impact (COMBI): a review of WHO's experiences with strategic social mobilization and communication in the prevention and control of communicable diseases. In: Haider M, ed. Global publichealth communication: challenges, perspectives, and strategies. Sudbury, MA, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2005 (pp 305–320).
11. Nathan MB, Lloyd L, Wiltshire A. Community participation in environmental management for dengue vector control: experiences from the English-speaking Caribbean. Dengue Bulletin, 2004, 28(Suppl):13–16.
12. Norma Oficial Mexicana.NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.
13. Por Octavio Rojas. En Razón y Palabra. N° 34, año 8, agosto - septiembre 2003, México. Mensajes Claves y Preguntas y Respuestas. Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al Comunicar.
14. Dirección General de Epidemiología, Informe de la Situación del Dengue en el Perú. Ministerio de Salud, 2013.
15. Dirección General de Promoción de la Salud.MINSA.2011.DT: Directiva Administrativa para el trabajo con el Agente Comunitario de Salud N° 174-MINSA/DGPS-V.01.
16. Dirección General de Promoción de la Salud.MINSA.2011.DT: Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el Cuidado Infantil, aprobado con RM N° 528-2011/MINSA.
17. Dirección General de Promoción de la Salud.MINSA.2011.DT: Lineamientos de Política para la Vigilancia Ciudadana en Salud, aprobado con RM N° 040-2011/MINSA.
18. Dirección General de Salud Ambiental.MINSA.2011. Norma Técnica de Salud para la implementación de la Vigilancia y Control del *Aedes aegypti*, Vector del Dengue en el Territorio Nacional, aprobado con RM N° 797-2010/MINSA.
19. Ministerio de Salud de El Salvador.2012. Lineamientos técnicos para el abordaje del Dengue.

Ministerio de Salud
M.L. Pérez G.

Dirección General de Promoción de la Salud
DPGS MINSA